

Buku Ajar

PENGANTAR PRAKTIK KEBIDANAN

Yeti Yuwansyah • Intan Azkia Paramitha • Heni Setyawati
Afritayeni • Diyanah Kumalasary • Katarina lit
Megawati



BUKU AJAR

PENGANTAR PRAKTIK KEBIDANAN

Penulis:

Yeti Yuwansyah, SST., M.Kes., M.Keb.

Bdn. Intan Azkia Paramitha, S.Tr.Keb., M.Keb.

Heni Setyowati, S.SiT., M.Kes.

Bdn. Afritayeni, SST., M.Kes.

Diyanah Kumalasary, SST., M.Kes.

Katarina Iit, SST., M.Kes.

Megawati, S.ST., MKM.



Buku Ajar Pengantar Praktik Kebidanan

Penulis: Yeti Yuwansyah, SST., M.Kes., M.Keb.

Bdn. Intan Azkia Paramitha, S.Tr.Keb., M.Keb.

Heni Setyowati, S.SiT., M.Kes.

Bdn. Afritayeni, SST., M.Kes.

Diyanah Kumalasary, SST., M.Kes.

Katarina Iit, SST., M.Kes.

Megawati, S.ST., MKM.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7294-00-5

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ajar "Pengantar Praktik Kebidanan" ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kebidanan, mulai dari konsep dasar hingga praktik aplikatif, yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh mahasiswa kebidanan dan praktisi kesehatan. Materi yang disajikan mencakup definisi dan sejarah kebidanan, peran bidan dalam konteks nasional dan global, hingga tren dan isu terkini yang relevan dengan praktik kebidanan masa kini.

Dalam setiap babnya, buku ini menguraikan berbagai pendekatan yang esensial bagi profesi kebidanan, termasuk pembahasan yang mendalam tentang Social Model dan Medical Model serta pentingnya membangun kemitraan yang berorientasi pada kebutuhan perempuan (women-centered care). Kami berharap diskusi tentang paradigma kebidanan, regulasi sertifikasi dan lisensi, serta berbagai isu profesional dan etika yang disajikan dapat memperkaya wawasan dan keterampilan profesional bagi para pembaca dalam menghadapi tantangan praktik kebidanan di era globalisasi ini.

Harapan besar kami bahwa buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga dapat menginspirasi para mahasiswa dan praktisi kebidanan dalam meningkatkan kompetensi serta dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan terbaik bagi perempuan dan keluarga. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami nantikan guna penyempurnaan edisi berikutnya.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 DEFINISI BIDAN, SEJARAH DALAM KEBIDANAN (BIDAN, PENDIDIKAN BIDAN DAN PELAYANAN BIDAN), PERAN BIDAN DALAM KONTEKS NASIONAL DAN GLOBAL	1
---	----------

A. Definisi Bidan	3
B. Sejarah dalam Kebidanan	4
C. Peran Bidan Dalam Konteks Nasional Dan Global.....	19
D. Latihan Soal	21
E. Kunci Jawaban	21
F. Rangkuman Materi	22
G. Glosarium.....	22
H. Daftar Pustaka.....	23

BAB 2 TREN DAN ISU DALAM PRAKTIK KEBIDANAN	25
---	-----------

A. Tren Terkini dalam Praktik Kebidanan	26
B. Isu Kontemporer dalam Praktik Kebidanan.....	30
C. Konsep Dasar Keselamatan Pasien.....	31
D. Kebutuhan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Continuous Professional Development - CPD).....	33
E. Pentingnya Etika dan Legal dalam Praktik Kebidanan	34
F. Advokasi Kebijakan dan Kemitraan.....	35
G. Pendekatan Multidisipliner dan Kolaborasi Tim	36
H. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan	36
I. Latihan Soal	37
J. Rangkuman Materi	39
K. Glosarium.....	41
L. Daftar pustaka	42

BAB 3 SOCIAL MODEL VS MEDICAL MODEL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN ..	45
---	-----------

A. Antisipasi Keadaan Normal	46
B. Seni dalam Praktik Kebidanan.....	46
C. Lokal/Komunitas dalam Praktik Kebidanan	48
D. Teknologi sebagai Penolong	49

E. Latihan Soal	50
F. Rangkuman Materi.....	52
G. Glosarium.....	53
H. Daftar Pustaka.....	55

BAB 4 SOCIAL MODEL VS MEDICAL MODEL: MENGHARGAI PERBEDAAN, KEPERCAYAAN, INTUISI/MEMAKNAI INTUISI, HUBUNGAN, AKTUALISASI

DIRI	58
A. Konsep Dasar Social Model dalam Praktik Kebidanan	59
B. Menghargai Perbedaan	60
C. Kepercayaan	62
D. Intuisi/Memaknai Intuisi	64
E. Hubungan.....	66
F. Aktualisasi Diri	68
G. Latihan Soal	69
H. Rangkuman materi	71
I. Glosarium	73
J. Daftar Pustaka.....	74

BAB 5 PARTNERSHIP.....76

A. <i>Primary Care</i>	78
B. <i>Women Centered Care</i>	80
C. <i>Empowering</i>	83
D. <i>Trust</i>	86
E. Latihan	87
F. Kunci Jawaban	88
G. Rangkuman Materi	88
H. Glosarium.....	88
I. Daftar Pustaka.....	88

BAB 6 LINGKUP PRAKTIK BIDAN, PARADIGMA KEBIDANAN, REGULASI

YANG MENGATUR SERTIFIKASI, LISENSI BIDAN INDONESIA..... 90

A. Lingkup Praktik Bidan	91
B. Standar dan Tempat Praktik Bidan.....	92
C. Ruang Lingkup Praktik Kebidanan	93
D. Peran dan Tanggung Jawab Bidan.....	94
E. Standar dan Tempat Praktik Bidan.....	94
F. Definisi Paradigma Bidan	95

G. Komponen Kompetensi	97
H. Pengertian Regulasi.....	99
I. Latihan	102
J. Kunci Jawaban	104
K. Rangkuman Materi	105
L. Glosarium.....	105
M. Daftar Pustaka.....	105

BAB 7 ISU PROFESIONAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN, ETIK DALAM KEBIDANAN, DAN KONSEP BERUBAH.....108

A. Isu Profesional dalam Praktik Kebidanan	109
B. Etik dalam Kebidanan	111
C. Konsep Berubah dalam Praktik Kebidanan.....	113
D. Latihan Soal	115
E. Rangkuman Materi	117
F. Glosarium.....	118
G. Daftar Pustaka.....	120

PROFIL PENULIS123

BAB 1

DEFINISI BIDAN, SEJARAH DALAM KEBIDANAN (BIDAN, PENDIDIKAN BIDAN DAN PELAYANAN BIDAN), PERAN BIDAN DALAM KONTEKS NASIONAL DAN GLOBAL

Pendahuluan

Buku pengantar praktik kebidanan ini terdiri dari tiga bab, dimana bab satu ini berisi definisi bidan, sejarah dalam kebidanan (bidan, pendidikan bidan dan pelayanan bidan), peran bidan dalam konteks nasional dan global. Buku ajar "Pengantar Praktik Kebidanan" ini disusun sebagai panduan bagi mahasiswa sarjana kebidanan untuk memahami konsep dasar dalam praktik kebidanan. Tujuan utama dari buku ini adalah memberikan landasan teori yang kuat serta keterampilan dasar yang diperlukan dalam praktik kebidanan, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan standar profesi bidan.

Sasaran utama buku ini adalah mahasiswa program sarjana kebidanan yang sedang menempuh mata kuliah pengantar praktik kebidanan. Buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami peran dan tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan yang aman, holistik, dan berbasis bukti. Selain itu, buku ini juga bermanfaat bagi dosen dan praktisi kebidanan sebagai referensi dalam proses pembelajaran dan praktik klinik. Isi buku ini mencakup berbagai aspek fundamental praktik kebidanan, mulai dari konsep dasar kebidanan, etika dan hukum dalam kebidanan, komunikasi terapeutik, hingga keterampilan dasar yang diperlukan dalam asuhan kebidanan. Setiap bab disusun secara sistematis agar mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan konsep yang dipelajari ke dalam praktik kebidanan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Metode pembelajaran yang digunakan dalam buku ini mengedepankan pendekatan berbasis keterampilan dan pemecahan masalah. Materi disampaikan melalui kombinasi antara teori, studi kasus, serta latihan praktik yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan konsep kebidanan secara nyata. Pendekatan pembelajaran dalam buku ini bersifat interaktif dan berpusat pada mahasiswa. Selain pembelajaran mandiri melalui bacaan dan refleksi kritis, buku ini juga dirancang untuk mendukung diskusi kelompok, simulasi praktik, dan pembelajaran berbasis kasus. Dengan pendekatan ini, diharapkan

mahasiswa dapat mengembangkan pemikiran kritis, keterampilan klinis, serta sikap profesional dalam menjalankan praktik kebidanan.

Sebagai pedoman penggunaan, buku ini dapat digunakan sebagai bahan ajar utama maupun referensi pendukung dalam pembelajaran kebidanan. Setiap bab dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, ringkasan materi, serta soal latihan yang dirancang untuk menguji pemahaman mahasiswa. Dengan struktur yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar yang efektif bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi praktik kebidanan di dunia nyata.

Tujuan Intruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai pengantar praktik kebidanan. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang definisi bidan, sejarah dalam kebidanan (bidan, pendidikan bidan dan pelayanan bidan), peran bidan dalam konteks nasional dan global.

Tujuan Intruksional Khusus:

- Mahasiswa mampu menjelaskan definisi bidan
- Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dalam kebidanan:
 - Bidan
 - Pendidikan Bidan
 - Pelayanan Kebidanan
- Mahasiswa mampu menjelaskan peran bidan dalam konteks nasional dan global

Capaian Pembelajaran:

Mampu menjelaskan definisi definisi bidan, sejarah dalam kebidanan (bidan, pendidikan bidan dan pelayanan bidan), peran bidan dalam konteks nasional dan global.

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini adalah definisi bidan, sejarah dalam kebidanan (bidan, pendidikan bidan dan pelayanan bidan), peran bidan dalam konteks nasional dan global.

A. Definisi Bidan

Bidan adalah tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu dan anak, mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga kesehatan reproduksi wanita secara umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, pengertian bidan dijelaskan sebagai berikut: "Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan."

International Confederation of Midwives (2005) juga menjelaskan bahwa pengertian bidan yang dimaksud adalah sebagai berikut: "Bidan adalah seseorang yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikan kebidanan yang didasarkan pada Kompetensi Esensial ICM untuk Praktik Kebidanan dan kerangka Standar Global ICM untuk Pendidikan Kebidanan dan diakui di negara tempat ia berada; yang telah memperoleh kualifikasi yang diperlukan untuk terdaftar dan/atau memiliki izin resmi untuk praktik kebidanan dan menggunakan gelar 'bidan'; dan siapa yang menunjukkan kompetensi dalam praktik kebidanan."

Dari kedua pengertian yang sudah dijelaskan, terdapat sedikit perbedaan jika kita melihat pengertian bidan dari Ikatan Bidan Indonesia (2016). Berikut adalah penjelasan tentang definisi bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia (IBI). "Bidan adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memfasilitasi persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi."

Secara keseluruhan, definisi bidan adalah seseorang yang telah mempelajari dan telah menyelesaikan program kebidanan serta mendapatkan pengakuan, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri supaya dapat menjalankan tugas seorang bidan, seperti memfasilitasi persalinan dan memberikan pengarahan kesehatan kepada masyarakat, terutama ibu hamil dan ibu yang sudah memiliki anak.

Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal,

deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan.

Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak. Bidan dapat praktik diberbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat, Rumah Sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya.

B. Sejarah dalam Kebidanan

1. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kebidanan Di Luar Negeri

a. Amerika

Dalam bukunya *Theory for Midwifery Practice*, Rosamund Bryar memaparkan tentang perkembangan pelayanan kebidanan yang ada di Amerika. Bryar menyatakan bahwa:

- 1) Tahun 1765 pendidikan formal untuk bidan mulai dibuka. Akhir abad ke-18 banyak kalangan medis berpendapat secara emosi dan intelektual wanita tidak dapat belajar dan menerapkan metode obstetric. Pendapat ini digunakan untuk menjatuhkan profesi bidan, sehingga bidan tidak mempunyai pendukung, uang, tidak teroganisir dan tidak dianggap profesional.
- 2) Tahun 1770-1820 Para wanita golongan atas di kota-kota besar, melahirkan ditolong oleh "Bidan Pria" / dokter. Bidan hanya menangani persalinan wanita yang tidak mampu membayar dokter. Pada masa itu juga terjadi perubahan persepsi dimana kelahiran merupakan masalah medis yang harus ditangani oleh dokter.
- 3) Sampai dengan pada awal abad 20 para bidan berperan seperti dokter berpengalaman tanpa pendidikan spesifik, standar-standar, atau peraturan- peraturan yang mengatur dalam memeriksakan pelayanan kebidanan.
- 4) Tahun 1915 Dokter Joseph de Lee menyatakan: kelahiran bayi adalah patologis dan bidan tidak mempunyai peran didalamnya. Pada saat ini mulai diberlakukannya protap pertolongan persalinan yaitu:
 - a) memberikan sedative pada awal inpartu
 - b) membiarkan servik berdilatasi
 - c) memberikan ether pada kala II
 - d) melakukan episiotomi
 - e) melahirkan bayi dengan forcep
 - f) ekstraksi placenta

- g) memberikan uterotonika
- h) menjahit episiotomy
- 5) Tahun 1900-1930 akibat protap yang diberlakukan tersebut, AKI mengalami penurunan menjadi 600-700 kematian per 100.000 kelahiran hidup. 30-50% wanita melahirkan di rumah sakit.
- 6) Dokter Grantly Dickie meluncurkan buku tentang persalinan alami sehingga spesialis obstetric berusaha meningkatkan peran tenaga diluar medis termasuk bidan.
- 7) Tahun 1955: Dibuka sekolah *American College of Nurse-Midwives* (ACNM)
- 8) Tahun 1971: Seorang bidan di Tennessee mulai menolong persalinan secara mandiri di institusi kesehatan.
- 9) Tahun 1979: Badan pengawasan obat Amerika mengatakan bahwa ibu bersalin yang menerima anaestesi dalam dosis tinggi telah melahirkan anak-anak yang mengalami kemunduran perkembangan psikomotor
Pernyataan ini membuat:
Masyarakat mulai tertarik dengan proses persalinan alamiah
Persalinan dilakukan di rumah
Memacu peran bidan
- 10) Tahun 1980-an: ACNM membuat alternative dalam pelayanan persalinan dan mengubah pernyataan negative tentang *homebirth*. Dibuat legalisasi tentang praktek profesional bidan, sehingga membuat bidan menjadi profesi dengan lahan praktek yang spesifik dan membutuhkan organisasi yang mengatur organisasi tersebut.
- 11) Tahun 1982: MANA (*Midwife Alliance of North America*) dibentuk untuk meningkatkan komunikasi antar bidan serta membuat peraturan sebagai dasar kompetensi untuk melindungi bidan. Negara Arizona, bidan mempunyai tugas khusus yaitu melahirkan bayi. Untuk perawatan selanjutnya merawat bayi dan memberikan injeksi bukan lagi tugas bidan, hanya dilakukan jika diperlukan.
- 12) Tahun 1980: Bidan menangani 1,1% persalinan dan tahun 1994: 5,5%
- 13) Tahun 1988: Angka SC menurun 25% dan menjadi 21% tahun 1995
- 14) Tahun 1989: Penggunaan forcep menurun 5,5% dan menjadi 3,8% tahun 1994. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Bidan Amerika saat ini antara lain:
 - a) Ada banyak undang-undang baru, direct entry midwife dianggap ilegal
 - b) Lisensi praktek berbeda antar Negara, tidak ada standar praktek nasional sehingga tidak ada definisi yang jelas tentang bidan yang telah terdidik dan memiliki standar kompetensi yang sama

c) Sedikit data tentang direct entry midwife dan persalinan oleh bidan

d) Kritik tajam dari profesi medis kepada *direct entry midwife*

Pendidikan kebidanan biasanya berbentuk praktek lapangan. Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun dan praktek lapangan selama 2 tahun tapi biaya sangat mahal. Kebidanan memiliki sebuah organisasi untuk membentuk standart, menyediakan sertifikat dan membuat ijin praktek. Saat ini, America merupakan Negara yang menyediakan perawatan maternitas termahal di dunia, tetapi paling buruk dalam hal perawatan antenatal dibandingkan dengan Negara industri lainnya.

b. Australia

1) Abad 19: Florence Nightingale adalah pelopor kebidanan dan keperawatan yang dimulai dengan tradisi dan latihan – latihan.

2) Tahun 1824:

Kebidanan masih belum dikenal sebagai bagian pendidikan medis di Inggris dan Australia. Kebidanan masih didominasi oleh dokter

3) Tahun 1862: Pendidikan kebidanan pertama kali dimulai. Lulusannya dibekali dengan pengetahuan teori dan praktek.

4) Tahun 1893: Pendidikan Diploma kebidanan dimulai

5) Sejak tahun 1899:

Hanya bidan dan perawat terlatih yang boleh bekerja di RS. Sebagian besar wanita melahirkan tidak dirawat selayaknya oleh masyarakat. Ketidak seimbangan seksual dan moral membuat prostitusi berkembang cepat. Menyebabkan banyak wanita hamil diluar nikah dan jarang memperoleh pelayanan dari bidan dan dokter karena pengaruh sosial mereka.

6) Tahun 1913: 30% persalinan ditolong oleh bidan

7) Tahun 1900-1940:

Dokter banyak menolong persalinan namun tidak ada penurunan berarti pada AKI dan bidanlah yang disalahkan.

Kenyataannya wanita di kota besar yang melahirkan dengan dokter, mempunyai resiko infeksi yang lebih besar daripada wanita miskin yang ditangani oleh bidan.

Kebidanan di Australia telah mengalami perkembangan yang pesat sejak 10 tahun terakhir.

Dasar pendidikan berubah dari *tradisional hospital based programe* menjadi *tertiary course of studies* menyesuaikan kebutuhan pelayanan dari masyarakat. Tapi tidak semua institusi pendidikan melaksanakan perubahan tersebut dan lebih berorientasi pada RS. Kurikulum disusun berdasarkan

pengalaman dan keahlian di lapangan kebidanan. Kekurangan dari pendidikan kebidanan di Australia hampir sama dengan di Indonesia karena belum ada persamaan persepsi mengenai implementasi kurikulum sehingga lulusan bidan mempunyai kompetensi klinik yang berbeda. Hal ini ditambah dengan kurangnya kebijakan formal dan tidak adanya standar nasional.

8) Tahun 1994:

- a) *National Review of Nurse Education* mengatakan bahwa tidak ada *direct entry* untuk pendidikan bidan di Australia.
- b) Mahasiswa kebidanan harus menjadi perawat dulu sebelum mengikuti pendidikan bidan, karena kebidanan termasuk sub spesialisasi keperawatan (*maternal and child health*) yang didalamnya termasuk :
 - (1) Pendidikan tentang keluarga berencana
 - (2) Kesehatan wanita
 - (3) Perawatan ginekologi
 - (4) Perawatan anak
 - (5) Kesehatan anak dan keluarga
 - (6) Kesehatan neonatus dan remaja
- c) Adanya peraturan ini, mempersempit peran dan ruang kerja bidan.
- d) Literatur kebidanan masih kurang
- e) Kurikulum hanya sesuai untuk mahasiswa pemula atau menengah dan kadang-kadang mahasiswa yang sudah terlatih di keperawatan kebidanan diberikan porsi yang sama dengan pemula atau sebaliknya.
- f) Beberapa tahun setelah Australia mengadakan pelatihan kebidanan, datang para pendidik yang membuka universitas yang memiliki cara tersendiri untuk menghasilkan tenaga yang berkualitas dan pemerintah mendukung bidan serta memperluas peran bidan.

c. Inggris

Pada tahun 1902 pelatihan dan registrasi bidan mulai diteraturkan. Selama tahun 1930 banyak perawat yang teregistrasi masuk kebidanan karena dari tahun 1916 mereka melaksanakan kursus-kursus kebidanan lebih singkat dari pada perempuan tanpa kualifikasi keperawatan. Tahun 1936 kebanyakan siswa-siswa kebidanan teregistrasi sebagai perawat. Pelayanan kebidanan di Inggris banyak dilakukan oleh bidan praktek swasta. Semenjak pertengahan 1980 kurang lebih 10 orang bidan melaksanakan praktek mandiri. Tahun 1990 bertambah sekitar 32 bidan, 1991 menjadi 44 bidan, dan 1994 sekitar 100 orang bidan dengan 80 bidan masuk dalam *Independent Midwives Assosiation*. Alasan bidan di Inggris melakukan praktek mandiri:

- 1) Penolakan terhadap model medis dalam kelahiran

- 2) Ketidakmampuan menyediakan perawatan yang memuaskan dalam NHS (*National Health Service*)
- 3) Untuk mengurus status bidan sebagai praktisi
- 4) Untuk memberikan kelangsungan perawatan dan kemampuan bidan dalam memberikan pertolongan persalinan di rumah sebagai pilihan mereka.

Pendidikan kebidanan di Inggris:

- 1) High School + 3 tahun
- 2) Nurse + 18 bulan

Mayoritas bidan di Inggris adalah lulusan diploma. Sejak tahun 1995 sudah ada lulusan S1 kebidanan dengan dasar SMU + 3-4 tahun.

d. New Zealand

Selama 50 tahun masalah kebidanan hanya terpaku pada medicalisasi kelahiran bayi yang progresif. Wanita tukang sihir telah dikenal sebagai bagian dari maternal sejak tahun 1904. Tindakan keperawatan mulai dari tahun 1971 mulai diterapkan pada setiap ibu hamil, hal ini menjadikan bidan sebagai perawat spesialis kandungan.

Pada tahun 1970 Selandia Baru telah menerapkan medicalisasi kehamilan. Ini didasarkan pada pendekatan mahasiswa pasca sarjana ilmu kebidanan dari universitas Auckland untuk terjun ke rumah sakit pemerintah khusus wanita. Salah satu konsekuensi dari pendekatan ini adalah regional jasa. Ini adalah efek dari sentralisasi yang mengakibatkan penutupan rumah sakit pedesaan dan wilayah kota.

Dengan adanya dukungan yang kuat terhadap gerakan feminis, banyak wanita yang berjuang untuk meningkatkan medicalisasi dan memilih persalinan di rumah. Dengan adanya dukungan yang kuat terhadap gerakan feminis, banyak wanita yang berjuang untuk meningkatkan medicalisasi dan memilih persalinan di rumah. Kumpulan *Homebirth* di Auckland dibentuk tahun 1978. dimulai dengan keanggotaan 150 orang dan menjadi organisasi nasional selama 2 tahun yaitu NZNA (*New Zealand Nurses Association*). Perkumpulan ini didukung oleh para langganan, donatur dan tenaga kerja sukarela atau fakultatif yang bertanggung jawab atas banyaknya perubahan positif dalam sistem RS. Tahun 1986 homebirth sangat berpengaruh dalam kemajuan melawan penetapan yang dibuat oleh medis, akhirnya menteri pelayanan kesehatan secara resmi mengakui homebirth tahun 1986.

Pada tahun 1980 NZNA membuat garis besar mengenai kebijakan atas pembatasan rumah hal ini disampaikan oleh penasehat panitia maternal jasa kepada jawatan kesehatan. Panitia maternal jasa adalah suatu panitia dimana

dokter kandungan menyatakan peraturan mengenai survey maternal terutama dalam hal memperdulikan rumah.

Sekarang NZNA telah membuat kemajuan yang patut dipertimbangkan dalam menetapkan konsep general perawat kesehatan keluarga secara berkesinambungan menyediakan pelayanan mulai dari kelahiran sampai meninggal. Sejak tahun 1904 RS St. Hellen mengadakan pelatihan kebidanan selama 6 bulan dan ditutup tahun 1979. sebagai penggantinya sejak tahun 1978 beberapa politeknik keperawatan berdiri, selain itu ada yang melanjutkan pendidikan di Australia untuk memperoleh keahlian kebidanan. Tercatat 177 (86 %) bidan telah memperoleh pendidikan kebidanan di luar negeri pada tahun 1986 dari 206 bidan yang ada, dan hanya 29 orang lulusan kebidanan Selandia Baru tahun 1987.

Tahun 1981 sebagian besar RS memasukkan bidan keperkumpulan perawat, para bidan mengalami krisis untuk membentuk organisasi dan pemimpin dari mereka. Kemudian muncul perkumpulan bidan yang menentang NZNA untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut langsung di bawah RS atau dibawah dokter kandungan.

2. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kebidanan di Dalam Negeri

Perkembangan pendidikan bidan berhubungan dengan perkembangan pelayanan kebidanan. Keduanya berjalan seiring untuk menjawab kebutuhan tuntutan masyarakat akan pelayanan kebidanan. Yang dimaksud dengan pendidikan ini adalah pendidikan formal dan non formal.

a. Tahun 1851

Pendidikan bidan dimulai pada masa penjajahan hindia belanda. Seorang dokter militer Belanda (DR. W. Bosch) membuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia. Pendidikan ini tidak berlangsung lama karena kurangnya peserta didik karena adanya larangan bagi wanita untuk keluar rumah.

b. Tahun 1902

Pendidikan bidan dibuka kembali bagi wanita pribumi di Rumah Sakit militer di Batavia dan tahun 1904 pendidikan bidan bagi wanita Indo dibuka di Makasar. Lulusan dari pendidikan ini harus bersedia ditempatkan dimana saja tenaganya dibutuhkan dan mau menolong msyarakat yang tidak/kurang mampu secara cumacuma. Lulusan ini mendapat tunjangan dari pemerintah kurang lebih 15-25 Gulden per bulan. Kemudian dinaikkan menjadi 40 Gulden perbulan (tahun 1922).

c. Tahun 1911/1912

Dimulai pendidikan tenaga keperawatan secara terencana di CBZ (RSUP) Semarang dan Batavia. Calon yang diterima dari HIS (SD 7 Tahun) dengan

pendidikan keperawatan 4 tahun dan pada awalnya hanya menerima peserta didik pria pada tahun 1914 telah diterima juga peserta didik wanita pertama , bagi perawat wanita yang lulus bisa melanjutkan kependidikan bidan selama 2 tahun. Untuk perawat pria dapat meneruskan pendidikan keperawatan lanjutan selama dua tahun juga.

d. Tahun 1935-1938

Pemerintah colonial Belanda mulai mendidik bidan lulusan Mulo (setingkat SLTP bagian B) dan hampir bersamaan di buka sekolah bidan di beberapa kota besar antara lain : di Jakarta di Rumah Sakit BersalinBudi Kemulyaan, RSB Palang Dua, dan RSB mardi Waluyo di Semarang. Pada tahun itu dikeluarkan peraturan yang membedakan lulusan bidan berdasarkan latar belakang pendidikan.

- 1) Bidan dengan latar pendidikannya Mulo dan pendidikan kebidanan selam 3 tahun disebut bidan kelas satu.
- 2) Bidan dari lulusan perawat (mantri) disebut bidan kelas dua
- 3) Perbedaan ini menyangkut gaji pokok dan tunjangan bagi bidan.

e. Tahun 1550-1953

Dibuka sekolah bidan dari lulusan SMP dengan batasan usia minimal 17 tahun dan lama pendidikan 3 tahun. Mengingat tenaga untuk menolong persalinan cukup banyak maka dibuka pendidikan pembantu bidan disebut penjenang kesehatan E atau pembantu bidan. Pendidikan ini dilanjutkan sampai tahun 1976 dan sekolah itu ditutup. Peserta didik PK/E adalah lulusan SMP ditambah 2 tahun. Lulusan PK/E sebagian besar melanjutkan ke pendidikan bidan selama 2 tahun.

f. Tahun 1953

Dibuka kursus tambahan bidan (KTB) di Yogya karta. Lamanya kursus antara 7-12 minggu. Tahun 1960 KTB dipindahkan ke Jakarta. Tujuan TKB adalah untuk memperkenalkan kepada lulusan bidan mengenai perkembangan program KIA dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sebelum lulusan memulai tugasnya sebagi bidan terutama menjadi bidan di BKIA. Tahun 1967 KTB ditutup.

g. Tahun 1954

Dibuka pendidikan guru bidan secara bersama-sama dengan guru perawat dan perawat kesehatan masyarakat di Bandung. Pada awalnya pendidikan ini berlangsung satu tahun kemudian menjadi 2 tahun dan terakhir berkembang menjadi 3 tahun. Pada awal tahun 1972, institusi pendidikan ini dilebur menjadi Sekolah Guru Perawat (SGP). Pendidikan ini menerima calon dari lulusan sekolah perawat dan sekolah bidan.

h. Tahun 1970

Dibuka program pendidikan bidan yang menerima lulusan dari sekolah pengatur rawat (SPR) ditambah dengan 2 tahun pendidikan bidan yang disebut Sekolah Pendidikan Lanjutan Jurusan Kebidanan (SPLJK) pendidikan ini tidak dilaksanakan merata di seluruh provinsi.

i. Tahun 1974

Mengingat jenis tenaga kesehatan menengah dan bawah sangat banyak (24 kategori), Depkes melakukan penyederhanaan pendidikan tenaga kesehatan non sarjana. Setelah bidan ditutup dan dibuka Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) dengan tujuan adanya tenaga muti porpose dilapangan dimana salah satu tugasnya adalah menolong persalinan normal. Namun karena adanya perbedaan falsafah dan kurikulum terutama yang berkaitan dengan kemampuan seorang bidan , maka tujuan pemerintah agar SPK dapat menolong perasalinan tidak tercapai atau terbukti tidak berhasil.

j. Tahun 1975-1984

Institusi pendidikan bidan ditutup, sehingga dalam 10 tahun tidak menghasilkan bidan. Namun organisasi profesi bidan (IBI) tetap ada dan hidup secara wajar 11.

k. Tahun 1981

Untuk meningkatkan kemampuan perawat kesehatan (SPK) dalam pelayanan ibu dan anak termasuk kebidanan, dibuka pendidikan diploma I Kesehatan Ibu dan Anak. ini hanya berlangsung 1 tahun dan tidak diberlakukan oleh seluruh institusi.

l. Tahun 1985

Dibuka lagi program pendidikan bidan yang disebut dengan PPB yang menerima lulusan dari SPR dan SPK. Pada saat itu dibutuhkan bidan yang memiliki kewenangan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di masyarakat. Lama pendidikan 1 tahun dan lulusannya dikembalikan kepada institusi yang mengirim.

m. Tahun 1989

Dibuka crash program pendidikan bidan secara nasional yang memperbolehkan lulusan SPK untuk langsung masuk program pendidikan bidan. Program ini dikenal sebagai program pendidikan bidan A (PPB/A). lama pendidikan 1 tahun dan lulusannya ditempatkan di desa-desa, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak di daerah pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menurunkan angka kematian ibu dan anak, untuk itu pemerintah menempatkan bidan di setiap desa sebagai PNS golongan II. Mulai tahun 1996 status bidan di desa sebagai pegawai tidak tetap (bidan PTT)

dengan kontrak selama 3 tahun dengan pemerintah, yang kemudian dapat diperpanjang dua kali tiga tahun lagi.

- n. Penempatan bidan ini menyebabkan orientasi sebagai tenaga kesehatan berubah. Bidan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya tidak hanya kemampuan klinik sebagai bidan tapi juga kemampuan untuk berkomunikasi, konseling dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat desa dalam meningkatkan taraf kesehatan ibu dan anak. Program Pendidikan Bidan (A) diselenggarakan dengan peserta didik cukup besar. Diharapkan tahun 1996 sebagian besar desa sudah memiliki minimal seorang bidan. Lulusan pendidikan ini kenyataannya juga tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang diharapkan seorang bidan profesional, karena pendidikan terlalu singkat dan jumlah peserta didik terlalu besar dalam kurun waktu satu tahun akademik, sehingga kesempatan peserta didik untuk praktik klinik kebidanan sangat kurang, sehingga tingkat kemampuan yang dimiliki seorang bidan juga kurang.

- o. Tahun 1993

Dibuka program pendidikan bidan B (PBB/B) yang peserta didiknya lulusan AKPER dengan lama pendidikan 1 tahun. Tujuan pendidikan ini adalah untuk mempersiapkan tenaga pengajaran pada PPB A. berdasarkan penelitian terhadap kemampuan klinik kebidanan dari lulusan ini tidak menunjukkan kompetensi yang diharapkan karena lama pendidikan yang hanya 1 tahun. Pendidikan ini hanya berlangsung 2 angkatan (1995 dan 1996) kemudian ditutup.

- p. Tahun 1993 juga dibuka pendidikan bidan program C (PPB/C) yang menerima masukan dari lulusan SMP. Pendidikan ini dilakukan di 11 provinsi yaitu Aceh, Bengkulu, Lampung dan Riau (untuk wilayah Sumatra) Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan (wilayah selatan) Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya. Pendidikan ini memerlukan kurikulum 3700 jam dan dapat diselesaikan dalam 6 semester. Selain pendidikan bidan diatas sejak tahun 1994-1995 pemerintah juga menyelenggarakan uji coba pendidikan bidan jarak jauh (Distance Learning) di tiga provinsi yaitu Jawa barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan untuk memperluas cakupan upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pengaturan penyelenggaraan ini telah diatur dalam SK Menkes No. 1247/Menkes/ SK/XII/1994. Diklat jarak Jauh bidan (DJJ) adalah DJJ kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan bidan agar mampu melaksanakan tugasnya dan diharapkan

berdampak pada penurunan AKI dan AKB. DJJ bidan dilaksanakan dengan menggunakan modul sebanyak 22 buah. Pendidikan ini dikoordinasikan oleh Pusdiklat Depkes dan dilaksanakan oleh Bapelkes di Provinsi.

- 1) DJJ I (1995-1996) dilaksanakan di 15 propinsi
- 2) DJJ II (1996-1997) dilaksanakan di 16 propinsi
- 3) DJJ III (1997-1998) dilaksanakan di 26 propinsi Secara kumulatif dari tahap I-III diikuti oleh 6.306 dan 3.439 (55%) dinyatakan lulus.
- 4) DJJ tahap IV (1998-1999) dilaksanakan di 26 propinsi dengan jumlah setiap propinsinya adalah 60 orang kecuali Maluku, Irian Jaya dan Sulawesi Tengah masing-masing hanya 40 orang dan propinsi Jambi 50 orang.

Selain pelatihan DJJ tahun 1994 juga dilaksanakan pelatihan pelayanan kegawat daruratan maternal dan neonatal (LSS; Life Saving Skill) dengan materi pembelajaran berbentuk 10 modul. Ditinjau dari proses penyelenggaraan ini dinilai tidak efektif.

q. Tahun 1996

IBI bekerjasama dengan Depkes dan *American College of Nursing Midwife* (ANCM) dan Rumah Sakit swasta mengadakan training of trainer kepada anggota IBI sebanyak 8 orang untuk LSS yang kemudian menjadi tim pelatihan inti LSS di PP IBI. Tim pelatihan LSS ini mengadakan TOT dan pelatihan baik untuk bidan di desa maupun bidan praktek swasta. Pelatihan praktek dilaksanakan di 14 propinsi dan selanjutnya melatih BPS secara swadaya, begitu juga guru atau dosen dari D3 kebidanan.

r. Tahun 1995-1998

IBI bekerja langsung dengan *Mother Care* melakukan pelatihan dan *peer review* bagi bidan RS, bidan Puskesmas, dan bidan di desa di propinsi Kalimantan selatan.

s. Tahun 2000

Terdapat tim pelatih Asuhan Persalinan Normal (APN) yang dikoordinasikan oleh *Maternal Neonatal Health* (MNH) yang sampai saat ini telah melatih APN di beberapa propinsi/kabupaten. Pelatihan LSS dan APN tidak hanya untuk pelatihan pelayanan, tetapi juga guru, dosen-dosen dari Akademi Kebidanan. Selain melalui pendidikan formal dan pelatihan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga diadakan seminar dan lokakarya organisasi (*Organization Development*: OD) dilaksanakan setiap tahun sebanyak 2 kali mulai tahun 1996 sampai dengan 2000 dengan biaya dari UNICEF.

t. Perkembangan Pendidikan Bidan Sekarang Mengingat besarnya tanggung jawab dan beban kerja bidan dalam melayani masyarakat, pemerintah bersama dengan IBI telah mengupayakan pendidikan bagi bidan agar dapat

menghasilkan lulusan yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan dapat berperan sebagai tenaga kesehatan profesional.

- u. Berdasarkan hal tersebut maka mulai tahun 1996 telah dibuka pendidikan diploma III kebidanan dengan menggunakan kurikulum nasional yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No. 009/U/1996 di enam provinsi dengan menerima calon peserta didik dari SMA. Saat ini kurikulum D III Kebidanan telah direvisi mengacu pada Kep Mendiknas 232 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan hasil revisi tersebut telah disahkan dengan keputusan menteri kesehatan RI No. HK.006.06.2.4.1583.
- v. Pada tahun 2001 tercatat ada 65 institusi yang menyelenggarakan pendidikan diploma III kebidanan di seluruh Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan diploma III Kebidanan sangat tinggi. Hal ini terlihat sampai saat ini jumlah institusi penyelenggara D III Kebidanan sudah mencapai 147 dengan 44 milik Depkes dan sisanya kepemilikan pemerintah daerah, TNI dan swasta. Hal ini perlu kita cermati bersama bahwa apabila peluang seperti akan tetap dipertahankan maka tidak ditutup kemungkinan jumlah institusi DIII kebidanan sulit untuk dibendung karena adanya aturan yang memungkinkan untuk itu. Sekaitan dengan hal tersebut sebaiknya pihak- pihak terkait seperti IBI melakukan studi tentang hal ini dan menyampaikan kepada pihak terkait dan berwenang sebagai masukan untuk membatasi izin pendirian Diploma Kebidanan dan DIV Bidan Pendidik. Dengan jumlah institusi yang cukup besar tersebut dihadapi berbagai masalah antara lain jumlah dosen serta sarana lahan praktik dan kasus yang terbatas. Untuk mengatasi kendala ini mulai tahun 2000 dibuka program diploma IV bidan pendidik yang diselenggarakan di fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pendidikan ini lamanya dua semester (satu tahun) dan saat ini telah berkembang program yang sama pada UNPAD (2001), USU(2004) dan STIKES Ngudi Waluyo Semarang, serta STIKIM Jakarta (2003).Akhir- akhir ini minat masyarakat untuk membuka program DIV bidan pendidik juga sudah mulai banyak seperti adanya beberapa usulan yang sudah masuk ke Pusdiknakes dari pemprakarsa program DIV bidan pendidik pada awalnya dilaksanakan dalam masa transisi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dosen. Apabila dianalisa lebih lanjut aturan yang berlaku pada Depdiknas adalah kualifikasi dosen minimal satu tingkat program yang dilaksanakan dengan program studi yang sesuai. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa DIV bidan pendidik dengan masa studi satu tahun terdiri dari beban materi profesi kebidanan kurang lebih 60 % dan 40 % beban materi kependidikan. Hal ini

sebenarnya belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan Depdiknas bahwa kualifikasi dosen minimal DIV dan S1 Kebidanan dan untuk menjadi pendidik perlu ditambah dengan kemampuan kependidikan. Dengan memperhatikan permasalahan tersebut mungkin sudah waktunya untuk memikirkan dan membuat rancangan pendidikan DIV Kebidanan kilinis dan S1 Kebidanan. Tidak tertutup kemungkinan pula untuk mengembangkan pendidikan pada jenjang S2 maupun SP1 dan SP2, apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dosen, peneliti dan menejer dalam bidang midwifery/kebidanan disamping tetap melaksanakan pemenuhan kebutuhan tenaga pelaksana pelayanan kebidanan oleh setiap tatanan pelayanan kesehatan. Tapi hal ini terlebih dahulu harus disusun dan ditetapkan kompetensi untuk masing-masing level/ jenjang pendidikan agar tidak terjadi kebingungan dikemudian hari. Penyusunan kompetensi ini dilakukan oleh IBI bersama-sama dengan unsure terkait lainnya seperti Depkes, organisasi profesi (POGI, IDAI, PERNASIA, dll). Adapun pembinaan dan pengawasan yang telah diupayakan oleh Pusdiknakes antara lain mulai dari penyusunan dan penetapan standar kompetensi bidan, penilaian ijin institusi baru, seleksi mahasiswa baru, penyusunan kurikulum, akreditasi dan ujian akhir program. Serta pengembangan beberapa standar pendidikan. Sampai saat ini dari 147 institusi telah terakreditasi sebanyak 26 dengan status sebagai berikut : A= 4, B = 18 dan C= 4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, ke depan kita sudah waktunya untuk meninjau ulang dan menata kembali pola pendidikan berjenjang dan berkelanjutan bagi bidan.

3. Sejarah Perkembangan Pelayanan Kebidanan di Luar Negeri

a. Amerika Serikat

Zaman dahulu kala di AS persalinan ditolong oleh dukun beranak yang tidak berpendidikan. Biasanya bila wanita sukar melahirkan, ahli obat menganjurkan agar wanita itu diusir serta ditakuti agar ras sakit bertambah dan kelahiran menjadi mudah karena kesakitan dan kesedihannya. Menurut catatan Thimas yang pertama kali praktek di AS adalah Samuel Fuller dan Istrinya. Kemudian menyusul Anne Hutchinson, ia menjadi bidan pada tahun 1634, pergi ke Boston dan melaporkan disana ia telah menolong persalinan dengan baik dan menghilangkan kepercayaan lama.

Kemudian nasib malang menimpa Anne Hutchinson ketika ia menolong sahabatnya bernama Marry Dyer, melahirkan anak dengan Anencephalus. Orang-orang mengecam Anne sebagai seorang ahli shir wanita. Akibat kecaman tu ia meninggalkan Boston dan pergi ke Long Island, kemudian ke Pelham, New York. Disana ia terbunuh waktu ada pemberontakan orang-orang

Indian. Karena ia dianggap sebagai orang yang berjasa maka ia diperingati dengan nama Hutchinson River Parkway.

Setelah orang Amerika mendengar perkembangan di Inggris beberapa orang Amerika terpengaruh dengan kemajuan di Inggris dan pergi kesana untuk memperdalam ilmunya. Antara lain:

- 1) Dr. James Lloyd (1728-1810), Beliau berasal dari Boston, belajar di London di RS Guy dan RS Saint Thimas.
- 2) Dr. William Shippen (1736-1808), Beliau berasal dari Philadelphia, belajar di Eropa selama lima tahun kemudian belajar pada Willian Smellie dan Jhon, William Hunter dan Mackenzie. Sekembalinya di AS mengembangkan kebidanan di Amerika. Pada tahun 1762. Dr. W. Shippen diizinkan mendirikan kursus kebidanan di Philadelphia Gazette. Masyarakat banyak menaruh minat, pria maupun wanitanya, sehingga kursusnya terdiri dari murid-murid pria dan wanita. Dalam praktek kebidanan muridmurid dipisahkan, murid pria berpraktek pada praktek pratikulinnya sendiri. Kemudian didirikan rumah sakit bersalin yang khusus untuk latihan muridnya. Kursus ini berlangsung terus sampai tahun 1765, kemudian ditutup karena adanya sekolah kedokteran dari Collage Philadelpjia. Dr. William Shippen diangkat menjadi professor Anatomi. Pembedahan dan kebidanan diajarkan bersama-sama pada tahun 1810 setelah ada pangangkatan dokter Thomas Chalkley James sebagai professor kebidanan. Ia menganjurkan partus buatan pada bayi premature bila pinggul ibu nya sempit.
- 3) Dr. Samuel Brad yang hidup pada tahun 1742-1821
Setelah menamatkan pelajarannya beliau pergi ke Eropa belajar di Edinburgh hingga tamat. Kemudian meneruskan lagi ke London hingga pada tahun 1768 kembali ke Amerika Serikat pada umur 26 tahun. Beliau terkenal dengan memajukan berdirinya bagian kedokteran di King College yang sekarang menjadi Universitas Columbia Dr. J.V.L. Tennet yang bekerja juga pada universitas itu menyebutnya sebagai professor kebidanan yang pertama di King College. Kemudian Dr Samuel Bard menulis buku kebidanan yang lain dan memuat pelajaran bagi dokter dan bidan. Isi buku tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a) Cara pengukuran Conyungata diagonalis
 - b) Kelainan-kelainan panggul
 - c) Melarang pemeriksaan dalam bila tidak ada indikasi
 - d) Kala I, dari permulaan persalinan sampai pembukaan lengkap
 - e) Kala II, dari pembukaan lengkap sampai kepala kelihatan di atas perineum

- f) Kala III, dari tampaknya kepala bayi diatas perineum sampai lahirnya seluruh tubuh bayi.
- g) Kala IV, dari lahirnya anak sampai lahirnya plasenta.
 - (1) Menasehatkan jangan menarik tali pusat untuk mencegah terjadinya inversion uteri.
 - (2) Mengajarkan bahwa letak muka dapat lahir spontan
 - (3) Melarang pemakaian cunam yang berulang-ulang karena banyak menimbulkan kerugian
- 4) Dr. Walter Channing (1786-1876)

Walter Channing mula-mula belajar kedokteran di universitas Pennsylvania, kemudian meneruskan ke Edinburgh dan London. Sekembalinya di Amerika Serikat beliau diangkat sebagai Profesor kebidanan di Sekolah Kedokteran Harvard, di mana sebelumnya diajarkan subjek kebidanan sebagai subjek tersendiri. Dr. Walter Channing juga seorang dokter yang pertama kali memperhatikan keadaan nifas di RSU Boston, Amerika Serikat.

4. Sejarah Perkembangan Pelayanan Kebidanan di Dalam Negeri

Perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Indonesia tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda, era kemerdekaan, politik/kebijakan pemerintah dalam pelayanan dan pendidikan tenaga kesehatan, kebutuhan masyarakat serta kemajuan ilmu dan teknologi.

- a. Pada tahun 1907 (Zaman Gubernur Jendral Hendrik William Deandels) Pada zaman pemerintah Hindia Belanda. AKI dan AKB sangat tinggi, Tenaga penolong persalinan adalah dukun . Para dukun dilatih dalam pertolongan persalinan tapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena tidak adanya pelatih kebidanan. Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kebidanan hanya diperuntukan bagi orang Belanda yang ada di Indonesia.
- b. Tahun 1849, dibuka pendidikan dokter Jawa di Batavia (di RS Militer Belanda sekarang RSPAD Gatot Subroto), seiring dengan dibukanya pendidikan dokter tersebut pada tahun 1851 dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh seorang dokter militer Belanda (Dr. W. Bosch) lulusan ini kemudian bekerja di RS dan di masyarakat. Mulai saat itu pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan oleh dukun dan bidan.
- c. Tahun 1952, mulai diadakan pelatihan bidan secara formal agar dapat meningkatkan kualitas pertolongan persalinan. Kursus untuk dukun masih berlangsung sampai dengan sekarang yang memberikan kursus adalah bidan. Perubahan pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh di msyarakat dilakukan dengan kursus tambahan yang dikenal dengan istilah kursus tambahan bidan (KTB) pada tahun 1953 di

Yogyakarta yang akhirnya dilakukan pula di kota-kota besar lain. Seiring dengan pelatihan tersebut didirikanlah Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) dimana bidan sebagai penanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan mencakup pelayanan antenatal, Postnatal dan pemeriksaan bayi dan anak termasuk imunisasi dan penyuluhan gizi. Sedangkan diluar BKIA, bidan memberikan portolongan persalinan di rumah keluarga dan pergi melakukan kunjungan rumah sebagai upaya tindak lanjut dari pasca persalinan.

- d. Dari BKIA inilah yang akhirnya menjadi suatu pelayanan yang terintegrasi kepada masyarakat yang dinamakan Puskesmas pada tahun 1957. Puskesmas memberikan pelayanan berorientasi pada wilayah kerja. Bidan yang bertugas di puskesmas berfungsi memberikan pelayanan KIA termasuk pelayanan KB baik diluar gedung maupun didalam gedung. Pelayanan kebidanan yang diberikan di luar Gedung adalah pelayanan kesehatan keluarga dan pelayanan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Pelayanan di Posyandu mencakup empat kegiatan yaitu : pemeriksaan kehamilan, pelayanan KB, imunisasi, gizi dan kesehatan lingkungan.
- e. Mulai tahun 1990 Pelayanan kebidanan diberikan secara merata dan dekat masyarakat. Kebijakan ini melalui Inpres secara lisan pada sidang Kabinet tahun 1992 tentang perlunya mendidik bidan untuk penempatan bidan di desa. Adapun tugas pokok bidan di desa adalah sebagai pelaksana KIA khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas serta pelayanan kesehatan BBL, termasuk pembinaan dukun bayi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya bidan di desa melaksanakan kunjungan rumah pada ibu dan anak yang memerlukannya, mengadakan pembinaan pada Posyandu di wilayah kerjanya serta mengembangkan pondok bersalin sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal tersebut di atas adalah pelayanan yang diberikan oleh bidan di desa. Pelayanan yang diberikan berorientasi pada kesehatan masyarakat berbeda dengan halnya bidan yang bekerja di RS dimana pelayanan yang diberikan berorientasi pada individu. Bidan di RS memberikan pelayanan poliklinik antenatal, gangguan kesehatan reproduksi di klinik KB, senam hamil, pendidikan perinatal, kamar bersalin, kamar operasi kebidanan, ruang nifas dan ruang perinatal. Bertitik tolak dari konferensi kependudukan dunia di Kairo pada tahun 1994 yang menekankan pada kespro, memerlukan area garapan pelayanan bidan. Area tersebut meliputi :
 - 1) Family Planning
 - 2) PMS termasuk infeksi saluran reproduksi
 - 3) *Safe Motherhood* termasuk bayi baru lahir dan perawatan abortus

- 4) Kesehatan Reproduksi pada remaja
- 5) Kesehatan Reproduksi pada orang tua

Bidan dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya didasarkan pada kemampuan dan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tersebut diatur melalui Permenkes. Permenkes yang menyangkut wewenang bidan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Permenkes tersebut dimulai dari; Permenkes No. 5380/IX/1963, wewenang bidan terbatas hanya pada pertolongan persalinan normal secara mandiri didampingi tugas lain.

- a. Permenkes No. 363/IX/1980, yang kemudian diubah menjadi Permenkes 623/1989
- b. Wewenang bidan dibagi dua yaitu wewenang umum dan wewenang khusus. Dalam wewenang khusus ditetapkan bila bidan melaksanakan tindakan khusus dibawah pengawasan dokter. Hal ini berarti bahwa bidan dalam melaksanakan tugasnya tidak bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan. Pelaksanaan dari Permenkes ini, bidan dalam melaksanakan praktek perorangan dibawah pengawasan dokter.
- c. Permenkes No. 572/VI/1996, Wewenang ini mengatur tentang registrasi dan praktek bidan. Bidan dalam melaksanakan prakteknya diberi kewenangan yang mandiri. Kewenangan tersebut disertai dengan kemampuan dalam melaksanakan tindakan. Dalam wewenang tersebut mencakup : pelayanan kebidanan yang meliputi: pelayanan ibu dan anak, pelayanan KB, pelayanan kesehatan masyarakat.
- d. Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktek bidan revisi dari Permenkes 572/VI/1996
- e. Kepmenkes No 1464 Tahun 2010
- f. Kepmenkes No 28 Tahun 2017
- g. UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

Dalam melakukan tugasnya, bidan melakukan kolaborasi, konsultasi dan merujuk sesuai dengan kondisi pasien, kewenangan dan kemampuannya. Dalam keadaan darurat bidan juga diberi wewenang pelayanan kebidanan yang ditujukan untuk penyelamatan jiwa. Dalam aturan tersebut juga ditegaskan bahwa bidan dalam menjalankan praktek harus sesuai dengan kewenangan, kemampuan, pendidikan, pengalaman berdasarkan standar profesi.

C. Peran Bidan Dalam Konteks Nasional Dan Global

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh seseorang didalam masyarakat. Setiap profesi kesehatan memiliki perannya masing-

masing didalam masyarakat. Peran bidan berdasarkan Undangundang No. 4 tahun 2019 adalah memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat secara mandiri maupun difasilitas kesehatan lainnya (puskesmas, RS, Klinik atau tempat pelayanan kesehatan lainnya). Peran bidan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan sebagai wadah pengembangan ilmu dan teknologi guna menyelesaikan permasalahan kesehatan ibu dan anak dimasyarakat. (Rosita, 2024).

Sejak tahun 1992, tanggal 5 Mei ditetapkan sebagai Hari Bidan sedunia. Salah satu tujuan hari bidan sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran akan peran penting bidan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya di unit terkecil, seperti desa. Tanggung jawab utama seorang bidan adalah membantu ibu sejak konsepsi hingga melahirkan sebagai anggota profesi medis. Meskipun mereka juga membantu pelayanan kesehatan lainnya, namun peran bidan dalam hal-hal yang berhubungan dengan persalinan bukanlah yang terpenting.

Peran bidan dalam konteks global:

1. Sebagai PMO (Petugas Pemantau Pil), bidan dapat membantu pelayanan TBC dengan berperan sebagai pengawas menelan obat (PMO) bagi pasien TBC, sesuai Permenkes 67 Tahun 2016. Jabatan ini berfungsi sebagai pengawas langsung, memastikan pasien TBC meminum semua obat yang diresepkan tanpa melewatkan satu pun obat. untuk menghindari interaksi obat yang disebabkan oleh penghentian pengobatan.
2. Sebagai tenaga kesiapsiagaan bencana a. Bidan adalah tenaga medis profesional yang biasanya bekerja di pusat kesehatan masyarakat atau di daerah yang paling mungkin terjadi bencana. Kesiapsiagaan darurat dan pengurangan risiko sangat penting dalam bidang-bidang ini. b. Bidan mempunyai peningkatan kemampuan dalam pelayanan kebidanan pada klien dengan keadaan darurat dalam situasi bencana dan mampu melaksanakan tugas membantu kasus kegawatdaruratan maternitas dan neonatus dalam situasi bencana dengan seefektif mungkin.
3. Sebagai pemberi pelayanan kebidanan berbasis bukti dalam ranah internasional Karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan layanan kebidanan yang pesat dan dinamis, penting bagi bidan untuk selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dalam skala global. Misalnya saja pada pertemuan ilmiah, bidan dapat berbagi informasi dengan berbagai pakar, baik dalam maupun luar negeri, mengenai topik-topik tertentu yang memajukan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan pengembangan pelayanan kesehatan.

D. Latihan Soal

1. Apa definisi bidan menurut International Confederation of Midwives (ICM)?
 - A. Tenaga kesehatan yang bertugas menangani penyakit wanita
 - B. Seseorang yang telah memperoleh kualifikasi yang terdaftar dan/atau memiliki izin resmi untuk praktik kebidanan
 - C. Dokter spesialis yang membantu proses persalinan
 - D. Perawat yang memiliki keahlian dalam merawat ibu hamil
 - E. Tenaga medis yang hanya fokus pada kesehatan ibu
2. Pelayanan kesehatan yang diberikan bidan kepada ibu, bayi, dan anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang pendidikan, registrasi, izin praktik, dan organisasi profesi bidan diatur dalam...
 - A. UU No. 4 Tahun 2019
 - B. (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010
 - C. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023
 - D. UU Nomor 17 Tahun 2023
 - E. HK.01.07/MENKES/1261/2022
3. Dalam cakupan global, tujuan utama peran bidan adalah...
 - A. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
 - B. Menggantikan peran dokter dalam dunia medis
 - C. Meningkatkan jumlah kelahiran di dunia
 - D. Mengurangi populasi global
 - E. Menghilangkan semua risiko kehamilan
4. Di Indonesia, organisasi profesi yang menaungi bidan adalah...
 - A. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
 - B. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
 - C. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
 - D. Himpunan Ahli Kesehatan Indonesia (HAKI)
 - E. Kementerian Kesehatan
5. Pendidikan kebidanan pertama kali dimulai di Australia pada tahun...
 - A. Tahun 1995
 - B. Tahun 1971
 - C. Tahun 1968
 - D. Tahun 1862
 - E. Tahun 1863

E. Kunci Jawaban

1. B
2. A
3. A

4. C
5. D

F. Rangkuman Materi

Bidan adalah tenaga kesehatan profesional yang memiliki keahlian dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, serta bayi baru lahir. Mereka juga berperan dalam kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Sejarah kebidanan telah ada sejak zaman kuno, di mana perempuan membantu persalinan secara tradisional. Perkembangan ilmu kebidanan mulai terlihat pada abad ke-17 dengan pengenalan teknik medis modern. Pada abad ke-20, kebidanan menjadi profesi formal dengan standar pendidikan dan pelatihan khusus. Peran Bidan dalam Konteks Nasional dan Global di tingkat nasional, bidan berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan prenatal, persalinan, dan pascapersalinan. Mereka juga berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Secara global, bidan berperan dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta akses layanan kesehatan reproduksi. Organisasi seperti WHO dan ICM (*International Confederation of Midwives*) menekankan pentingnya peran bidan dalam sistem kesehatan global. Bidan memiliki peran krusial dalam memastikan keselamatan ibu dan bayi melalui pendekatan berbasis bukti, keterampilan profesional, serta edukasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi.

G. Glosarium

ICM: singkatan dari *International Confederation of Midwives*, yang merupakan Konfederasi Bidan Internasional. ICM adalah organisasi nonpemerintah yang bekerja sama dengan bidan dan asosiasi bidan di seluruh dunia.

WHO: WHO (*World Health Organization*) adalah organisasi kesehatan dunia yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). WHO bertugas untuk mengatur dan mengoordinasikan isu-isu kesehatan global.

IBI: Ikatan Bidan Indonesia (IBI) merupakan organisasi profesi bidan di Indonesia. Wadah Para bidan dalam mencapai tujuan melalui kebijakan peningkatan profesionalisme anggota guna menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan berkualitas.

ACNM: *American College of Nurse-Midwives* (ACNM) adalah asosiasi profesional yang mewakili bidan dan perawat bidan bersertifikat di Amerika Serikat.

PMO: Pengawas Minum Obat, yaitu orang yang mengawasi pasien TBC minum obat secara teratur

Safe Motherhood: Safe motherhood merupakan upaya untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinannya sehat aman serta melahirkan bayi yang sehat.

Bidan PTT: Bidan PTT adalah bidan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). Bidan PTT ditempatkan di daerah-daerah terpencil dan pedalaman untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

H. Daftar Pustaka

-
- Kemenkes RI (2018) Profil Kesehatan RI Tahun 2017. Tahun 2017. Jakarta:Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kemenkes RI (2022) Profil Kesehatan RI Tahun 2021. Tahun 2021. Jakarta:Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Marshall, J. E., Knight, M., & Cornford-Wood, L. (2019). Continuing Professional Development and Midwifery Career Pathways. *Myles Professional Studies for Midwifery Education and Practice: Concepts and Challenges*, 249.
- Nunes, V. D., Gholitabar, M., Sims, J. M., & Bewley, S. (2014). Intrapartum care of healthy women and their babies: summary of updated NICE guidance. *Bmj*, 349
- Phillippi, J., & Kantrowitz-Gordon, I. (2023). *Varney's midwifery*. Jones & Bartlett Learning
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., ... & Declercq, E. (2014). Midwifery and quality care: findings from a new evidence-informed maternity care framework. *The Lancet*, 384(9948), 1129-1145.
- Sandall, J., Turienzo, C. F., Devane, D., Soltani, H., Gillespie, P., Gates, S., ... & Rayment-Jones, H. (2024). Midwife continuity of care models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane database of systematic reviews*, (4)
- Septina, Y., Keb, M. T., Srimulyawati, T., & Keb, M. T. (2020). *Pengantar Praktik Ilmu Kebidanan*. Penerbit Lindan Bestari.
- Treston, C. (2020). 2020: Year of the Nurse and Midwife. *Journal of the Association of Nurses in AIDS Care*, 31(2), 261
- World Health Organization. (2015). *Global technical strategy for malaria 2016- 2030*. World Health Organization
- World Health Organization. (2019). *Strengthening quality midwifery education for universal health coverage 2030*

BAB 2

TREN DAN ISU DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Pendahuluan

Praktik kebidanan selalu berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, teknologi, dan kebijakan kesehatan. Pemahaman terhadap tren dan isu terkini dalam praktik kebidanan penting untuk memastikan pelayanan kebidanan yang diberikan tetap relevan, aman, dan berkualitas tinggi. Bidan harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut serta memahami tantangan dan peluang yang muncul agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada ibu, bayi, dan keluarga.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami tren dan isu terkini dalam praktik kebidanan serta mampu menerapkan pengetahuan ini dalam praktik profesionalnya secara efektif dan adaptif.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis tren dan isu terbaru dalam bidang kebidanan serta memahami dampaknya terhadap praktik kebidanan masa kini dan masa depan.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

1. Mengidentifikasi berbagai tren dan isu yang sedang berkembang dalam praktik kebidanan.
2. Menganalisis dampak tren dan isu tersebut terhadap pelayanan kebidanan.
3. Merancang strategi adaptasi yang tepat dalam menghadapi tren dan isu terkini.

A. Tren Terkini dalam Praktik Kebidanan

Tren dalam praktik kebidanan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan demografi, kebijakan kesehatan, dan tuntutan masyarakat. Salah satu tren penting yang perlu diketahui oleh bidan adalah:

1. Telehealth dan Kebidanan Virtual Telehealth adalah penggunaan teknologi komunikasi digital untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh. Dalam praktik kebidanan, teknologi ini memungkinkan bidan untuk memberikan konsultasi prenatal, edukasi kesehatan ibu, serta pemantauan kondisi kehamilan secara virtual. Telehealth semakin populer dan banyak digunakan terutama sejak pandemi COVID-19, yang secara drastis mengubah pola interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien.

Pemanfaatan telehealth dalam praktik kebidanan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- a. **Kemudahan Akses:** Telehealth memungkinkan ibu hamil yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau mendapatkan layanan kesehatan dengan lebih mudah.
- b. **Efisiensi Waktu dan Biaya:** Konsultasi secara virtual mengurangi kebutuhan perjalanan pasien ke fasilitas kesehatan, sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi.
- c. **Kontinuitas Pelayanan:** Memungkinkan bidan untuk lebih rutin memantau kondisi kesehatan ibu dan janin, bahkan dalam situasi di mana kunjungan tatap muka terbatas.
- d. **Edukasi Kesehatan yang Lebih Efektif:** Materi edukasi prenatal dapat diberikan melalui berbagai media digital seperti video, webinar, dan modul online yang mudah diakses kapan saja oleh ibu hamil.

Meskipun telehealth memberikan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan dalam implementasinya, seperti:

- a. Ketersediaan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil.
- b. Keamanan data dan privasi pasien dalam komunikasi digital.
- c. Perlunya pelatihan khusus bagi bidan untuk mahir dalam penggunaan teknologi digital secara profesional dan efektif.

Untuk mengoptimalkan penggunaan telehealth dalam praktik kebidanan, penting untuk memiliki kebijakan dan regulasi yang jelas serta dukungan penuh dari lembaga pendidikan dan kesehatan dalam memberikan pelatihan teknologi bagi bidan.

2. Pendekatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Midwifery) Pendekatan berbasis bukti dalam kebidanan adalah praktik pengambilan keputusan klinis yang didasarkan pada hasil penelitian ilmiah terbaru dan relevan, pengalaman klinis praktisi, serta nilai dan preferensi pasien. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi atau keputusan klinis memiliki dasar ilmiah yang kuat, efektif, dan aman bagi ibu dan bayi.

Keuntungan utama dari pendekatan berbasis bukti dalam praktik kebidanan adalah:

- a. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan:** Pengambilan keputusan yang berdasarkan penelitian ilmiah terbaru membantu mengurangi risiko kesalahan klinis dan memastikan hasil kesehatan yang lebih optimal bagi ibu dan bayi.
- b. **Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya:** Dengan menggunakan intervensi yang terbukti efektif, sumber daya kesehatan seperti waktu, tenaga, dan biaya dapat dikelola secara lebih efisien.
- c. **Peningkatan Kepuasan Pasien:** Pasien yang menerima pelayanan berbasis bukti umumnya memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi karena merasa yakin bahwa perawatan yang mereka terima didasarkan pada standar terbaik dan terkini.

Langkah-langkah utama dalam implementasi praktik kebidanan berbasis bukti meliputi:

- a. **Mengidentifikasi Masalah atau Pertanyaan Klinis:** Bidan perlu memahami dan mengidentifikasi isu klinis spesifik yang membutuhkan solusi berbasis bukti.
- b. **Pencarian Bukti Ilmiah:** Mengakses jurnal ilmiah, database penelitian, dan sumber terpercaya lainnya untuk menemukan informasi terkini yang relevan dengan masalah klinis.
- c. **Penilaian Kritis terhadap Bukti:** Mengevaluasi kualitas, relevansi, dan validitas hasil penelitian untuk memastikan informasi tersebut dapat diterapkan dalam konteks praktik kebidanan.
- d. **Implementasi Bukti dalam Praktik:** Mengintegrasikan hasil penelitian dengan pengalaman klinis dan preferensi pasien dalam praktik sehari-hari.
- e. **Evaluasi Hasil dan Efektivitas:** Melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan intervensi berbasis bukti efektif dan memberikan manfaat maksimal.

Namun, implementasi praktik kebidanan berbasis bukti menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- a. Akses terbatas terhadap sumber literatur terbaru, terutama di daerah terpencil.
- b. Keterbatasan keterampilan dalam membaca dan menilai literatur ilmiah.

c. Resistensi terhadap perubahan praktik yang sudah lama dijalankan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, lembaga pendidikan kebidanan perlu memperkuat kurikulum yang mendukung pembelajaran berbasis bukti dan menyediakan pelatihan serta dukungan berkelanjutan bagi bidan dalam penerapan pendekatan ini.

3. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Integrasi praktik kebidanan dengan pelayanan kesehatan primer merupakan upaya strategis dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan keluarga. Konsep integrasi ini didasarkan pada prinsip bahwa kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan primer yang bertujuan menyediakan pelayanan yang holistik, berkelanjutan, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Manfaat utama dari integrasi praktik kebidanan ke dalam pelayanan kesehatan primer meliputi:

- a. **Peningkatan Akses Pelayanan:** Dengan integrasi, ibu hamil dapat dengan lebih mudah mendapatkan layanan kebidanan di fasilitas kesehatan primer terdekat, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil.
- b. **Kontinuitas Pelayanan:** Melalui integrasi, pelayanan kebidanan dapat diberikan secara kontinu mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas dan kesehatan bayi baru lahir, sehingga menciptakan kesinambungan perawatan yang lebih baik.
- c. **Kolaborasi Interprofesional:** Integrasi mendorong kolaborasi antara bidan dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang komprehensif dan terkoordinasi.
- d. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Integrasi memungkinkan standardisasi prosedur pelayanan, sehingga kualitas layanan kebidanan dapat dijaga dan ditingkatkan secara konsisten.

Implementasi integrasi pelayanan kebidanan dengan pelayanan kesehatan primer dapat dilakukan melalui beberapa langkah penting:

- a. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Memberikan pelatihan tambahan bagi bidan dalam berbagai aspek pelayanan kesehatan primer agar mampu berkontribusi secara maksimal dalam tim multidisipliner.
- b. **Penguatan Infrastruktur Pelayanan:** Menyediakan fasilitas, alat, dan bahan yang memadai di tingkat pelayanan primer agar bidan mampu memberikan layanan kebidanan secara efektif.

- c. **Pengembangan Sistem Rujukan yang Efektif:** Membuat mekanisme rujukan yang jelas dan efisien antara pelayanan primer dan pelayanan sekunder atau tersier untuk kasus-kasus yang membutuhkan intervensi lebih lanjut.
- d. **Penyusunan Kebijakan Pendukung:** Merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung integrasi pelayanan kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer, termasuk regulasi dan pendanaan.

Namun demikian, implementasi integrasi ini menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- a. Keterbatasan tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan primer.
- b. Infrastruktur pelayanan primer yang belum merata di berbagai daerah.
- c. Resistensi terhadap perubahan praktik dan budaya kerja yang baru.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya advokasi, edukasi, dan pelatihan yang berkelanjutan serta komitmen kuat dari pemangku kebijakan dan seluruh tenaga kesehatan.

- 4. Penekanan pada Kesehatan Mental Ibu** Perhatian terhadap kesehatan mental ibu selama masa kehamilan dan pasca persalinan telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kesehatan mental yang optimal sangat penting tidak hanya untuk kesejahteraan ibu tetapi juga untuk perkembangan dan kesehatan bayi secara keseluruhan. Kondisi mental yang sering ditemui seperti depresi perinatal, kecemasan, stres pasca trauma, dan gangguan mood lainnya membutuhkan perhatian khusus dari bidan sebagai penyedia layanan utama.

Manfaat dari penanganan kesehatan mental yang efektif dalam praktik kebidanan meliputi:

- a. **Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Bayi:** Ibu yang sehat secara mental mampu merawat bayinya dengan lebih baik dan memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan bayinya.
- b. **Pencegahan Komplikasi:** Penanganan dini terhadap masalah kesehatan mental dapat mencegah komplikasi yang lebih serius seperti depresi berat, gangguan kelekatan ibu-bayi, hingga dampak jangka panjang pada tumbuh kembang anak.
- c. **Penguatan Dukungan Sosial:** Menyediakan dukungan emosional dan sosial kepada ibu hamil dan ibu baru melalui konseling, terapi kelompok, atau dukungan keluarga dapat membantu memperbaiki kondisi mental ibu.

Langkah-langkah penting dalam penekanan kesehatan mental dalam praktik kebidanan meliputi:

- a. **Skrining Rutin:** Melakukan skrining kesehatan mental secara berkala pada ibu hamil dan ibu baru dengan menggunakan alat-alat skrining yang terstandar seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).
- b. **Edukasi dan Informasi:** Memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai tanda-tanda gangguan mental, pentingnya mencari bantuan, serta sumber daya yang tersedia.
- c. **Kolaborasi Multidisipliner:** Bekerja sama dengan profesional kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater dalam merancang intervensi yang tepat.
- d. **Dukungan Berkelanjutan:** Menyediakan akses yang mudah ke layanan konseling dan terapi serta memastikan tindak lanjut secara teratur.

Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi pendekatan ini meliputi:

- a. Stigma yang terkait dengan gangguan mental yang membuat ibu enggan mencari bantuan.
- b. Keterbatasan tenaga profesional yang terlatih dalam penanganan kesehatan mental di fasilitas kesehatan primer.
- c. Akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan mental, terutama di daerah terpencil.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendidikan kesehatan mental harus menjadi bagian integral dari pelatihan kebidanan. Dukungan kebijakan kesehatan yang jelas serta promosi kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mental ibu juga sangat penting.

B. Isu Kontemporer dalam Praktik Kebidanan

Seiring berkembangnya tren dalam praktik kebidanan, berbagai isu kontemporer juga muncul yang perlu diperhatikan secara serius oleh tenaga kebidanan, salah satunya adalah:

1. **Kesenjangan Akses Layanan Kebidanan** Kesenjangan akses layanan kebidanan menjadi salah satu isu krusial yang masih terjadi, terutama di daerah terpencil, pedesaan, dan kurang berkembang. Kesenjangan ini menciptakan hambatan signifikan dalam pencapaian tujuan kesehatan ibu dan bayi yang optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan ini meliputi:
 - a. **Geografis:** Wilayah terpencil atau sulit dijangkau secara geografis menyulitkan akses layanan kebidanan yang tepat waktu dan memadai.
 - b. **Sumber Daya Manusia:** Kurangnya tenaga kesehatan khususnya bidan yang berkualifikasi di daerah terpencil.
 - c. **Infrastruktur dan Transportasi:** Infrastruktur yang buruk serta kurangnya sarana transportasi menyebabkan hambatan signifikan dalam mobilitas tenaga kesehatan dan pasien.

- d. **Ekonomi dan Sosial Budaya:** Tingkat ekonomi yang rendah dan norma sosial budaya tertentu yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengakses layanan kebidanan.

Dampak dari kesenjangan akses ini sangat serius, di antaranya adalah:

- a. Meningkatnya angka kematian ibu dan bayi akibat terlambat mendapatkan layanan kesehatan.
- b. Komplikasi selama kehamilan dan persalinan yang tidak tertangani dengan baik.
- c. Terbatasnya kesempatan ibu dan bayi mendapatkan pelayanan kesehatan preventif yang berkualitas.

Strategi untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kebidanan antara lain:

- a. **Penguatan Sistem Kesehatan Primer:** Mengembangkan dan memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan primer di daerah terpencil melalui pembangunan infrastruktur yang memadai dan penyediaan tenaga kesehatan terlatih.
- b. **Pemanfaatan Teknologi Digital:** Mengintegrasikan telehealth atau layanan virtual untuk menjangkau daerah terpencil dan memberikan konsultasi awal secara cepat dan efisien.
- c. **Program Pelatihan Khusus:** Memberikan pelatihan khusus bagi bidan yang bertugas di daerah terpencil agar mampu menangani berbagai kondisi kebidanan secara mandiri.
- d. **Advokasi dan Kebijakan Proaktif:** Mengadvokasi kebijakan pemerintah yang secara khusus ditujukan untuk mengurangi kesenjangan akses, termasuk kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah sulit.
- e. **Mobilisasi Komunitas:** Melibatkan komunitas lokal dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya layanan kebidanan serta mengurangi stigma atau hambatan budaya yang ada.

Mengatasi kesenjangan ini membutuhkan pendekatan holistik dan kolaborasi multisektor yang kuat, melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara luas.

C. Konsep Dasar Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien dalam praktik kebidanan mencakup segala tindakan preventif yang bertujuan untuk mengurangi cedera, infeksi, dan komplikasi lain yang berpotensi terjadi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Komponen penting dalam keselamatan pasien meliputi:

- **Komunikasi Efektif:** Menjalin komunikasi terbuka dan jelas antara bidan, pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lain.

- **Kepatuhan terhadap Prosedur:** Konsistensi dalam mengikuti pedoman klinis dan standar operasional prosedur (SOP).
- **Monitoring Ketat:** Pengawasan secara ketat dan kontinu terhadap kondisi pasien sepanjang proses persalinan.

1. Tantangan dalam Pengelolaan Risiko

Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam pengelolaan risiko di antaranya:

a. Variasi Kompetensi Bidan

- Perbedaan tingkat keahlian dan pengalaman bidan bisa menyebabkan ketidakkonsistenan dalam praktik klinis yang berdampak pada keselamatan pasien.
- Upaya mitigasi dilakukan dengan pendidikan berkelanjutan serta pelatihan simulasi rutin untuk meningkatkan kompetensi klinis bidan.

b. Keterbatasan Sumber Daya

- Minimnya sarana dan prasarana di daerah terpencil menyebabkan tingginya risiko komplikasi akibat tidak tersedianya peralatan medis yang memadai.
- Solusinya berupa peningkatan investasi infrastruktur kesehatan dan pemerataan distribusi fasilitas pelayanan kesehatan.

c. Keterlambatan Identifikasi Risiko

- Kurangnya kemampuan dalam mengidentifikasi secara dini tanda bahaya pada kehamilan dan persalinan.
- Implementasi pelatihan khusus mengenai deteksi dini komplikasi kebidanan penting dilakukan secara rutin.

2. Strategi dalam Manajemen Risiko

Berbagai strategi efektif dalam mengelola risiko dalam praktik kebidanan meliputi:

a. Penguatan Sistem Dokumentasi

- Menggunakan rekam medis elektronik (Electronic Health Record/EHR) untuk meningkatkan akurasi pencatatan data klinis dan memudahkan komunikasi antar tenaga kesehatan.

b. Pendekatan Kolaboratif Tim

- Kerjasama interprofesional antara bidan, dokter spesialis obstetri, perawat, dan tenaga medis lainnya dapat mengurangi risiko kesalahan klinis melalui sistem double-checking.

c. Budaya Keselamatan (Safety Culture)

- Menanamkan budaya proaktif terhadap keselamatan pasien, seperti melaporkan kejadian nyaris cedera (near miss) serta melakukan analisis kejadian sentinel sebagai bahan pembelajaran bersama.

D. Kebutuhan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Continuous Professional Development - CPD)

1. Pentingnya CPD dalam Praktik Kebidanan

Dalam era informasi yang berkembang pesat, kebutuhan akan pengembangan profesional berkelanjutan menjadi krusial. Continuous Professional Development (CPD) adalah pendekatan sistematis yang bertujuan memastikan bidan selalu memperbaharui pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mereka agar tetap relevan dengan tuntutan praktik kebidanan modern.

2. Tujuan CPD dalam Praktik Kebidanan

Tujuan utama dari CPD dalam kebidanan meliputi:

- Memastikan Kompetensi Profesional:** Meng-update keterampilan teknis dan non-teknis secara rutin.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan:** Menjamin pelayanan kebidanan yang aman, efektif, dan berbasis bukti ilmiah terbaru.
- Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi:** Mengikuti perkembangan teknologi dan metode terbaru dalam bidang kebidanan.

3. Strategi Efektif CPD

Berbagai strategi yang efektif dalam implementasi CPD antara lain:

- Pelatihan Simulasi dan Workshop**
 - Memungkinkan bidan untuk mempraktikkan keterampilan baru dalam lingkungan simulasi yang aman sebelum menerapkannya di lapangan.
- E-learning dan Webinar**
 - Menghadirkan materi pembelajaran secara fleksibel yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
- Konferensi dan Seminar Ilmiah**
 - Memberikan kesempatan kepada bidan untuk bertukar pengalaman dan mendapatkan wawasan baru melalui interaksi dengan ahli di bidang kebidanan.

E. Pentingnya Etika dan Legal dalam Praktik Kebidanan

Etika dan aspek legal adalah komponen krusial dalam praktik kebidanan kontemporer. Meningkatnya tuntutan hukum terhadap tenaga kebidanan menuntut pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban bidan serta implikasi etis dalam setiap tindakan klinis.

1. Prinsip Etika dalam Kebidanan

Prinsip-prinsip etika dasar dalam praktik kebidanan meliputi:

- a. **Autonomi:** Menghormati hak pasien dalam mengambil keputusan terkait pelayanan kesehatannya.
- b. **Beneficence (berbuat baik):** Menjamin bahwa semua tindakan yang dilakukan bertujuan untuk kesejahteraan pasien.
- c. **Non-maleficence (tidak merugikan):** Menghindari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau risiko bagi pasien.
- d. **Justice (keadilan):** Menyediakan pelayanan yang adil dan setara bagi semua pasien tanpa diskriminasi.

2. Isu Legal yang Sering Muncul dalam Praktik Kebidanan

Beberapa isu legal umum yang dihadapi bidan adalah:

a. Informed Consent

- Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan tertulis atau verbal pasien setelah memberikan informasi lengkap tentang risiko dan manfaat tindakan yang akan dilakukan.

b. Malpraktik

- Kasus malpraktik sering muncul akibat kegagalan dalam mematuhi SOP atau kurangnya komunikasi efektif.

c. Privasi dan Kerahasiaan Data Pasien

- Perlindungan data pribadi pasien yang bersifat sensitif menjadi isu penting dengan meningkatnya penggunaan sistem digital dalam kebidanan.

3. Strategi Penguatan Pemahaman Etika dan Legal

a. Pelatihan Etika dan Hukum secara Berkala

- Menyelenggarakan pelatihan khusus untuk meningkatkan pemahaman bidan mengenai aspek etika dan legal dalam praktik klinis.

b. Peningkatan Komunikasi Interpersonal

- Mendorong penguatan komunikasi interpersonal yang baik antara bidan dan pasien guna mencegah kesalahpahaman.

c. Peningkatan Kesadaran tentang Dokumentasi Klinis

- Edukasi terkait pentingnya dokumentasi yang akurat dan detail sebagai bukti hukum apabila terjadi tuntutan hukum.

4. Strategi Menghadapi Tren dan Isu dalam Praktik Kebidanan

a. Penguatan Kompetensi Digital

Dalam era digitalisasi, bidan dituntut untuk menguasai teknologi digital dan telehealth agar dapat memberikan layanan secara virtual yang efektif dan efisien. Kompetensi digital yang kuat tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga memperluas akses terhadap pelayanan kebidanan, khususnya di daerah terpencil.

b. Pentingnya Kompetensi Digital bagi Bidan

- **Efisiensi Pelayanan:** Memungkinkan bidan memberikan konsultasi dan edukasi secara real-time melalui platform digital.
- **Akses Pelayanan yang Luas:** Menjangkau pasien di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas.
- **Peningkatan Kualitas Dokumentasi:** Menggunakan sistem digital dalam pencatatan data pasien, rekam medis elektronik, dan komunikasi antar tim medis.

5. Strategi Implementasi Pelatihan Kompetensi Digital

a. Pelatihan Reguler dan Simulasi Digital

- Pelaksanaan pelatihan rutin berbasis simulasi digital untuk melatih bidan menggunakan berbagai teknologi dan aplikasi kesehatan terbaru.

b. Pemanfaatan Platform E-learning

- Menyediakan materi pembelajaran digital yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, termasuk modul video tutorial dan webinar interaktif.

c. Pendampingan Teknis Berkelanjutan

- Menyediakan layanan dukungan teknis dan mentor digital untuk memastikan penerapan teknologi yang efektif dalam praktik klinis.

F. Advokasi Kebijakan dan Kemitraan

Peran advokasi kebijakan merupakan aspek penting yang perlu ditingkatkan dalam praktik kebidanan. Advokasi kebijakan bertujuan memperbaiki akses, kualitas pelayanan, dan pengakuan profesi bidan melalui kemitraan yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan komunitas.

1. Strategi Efektif dalam Advokasi Kebijakan dan Kemitraan

a. Kolaborasi Interprofesional

- Menjalinkan kerja sama lintas profesi untuk membangun kekuatan kolektif dalam merancang kebijakan kesehatan.

b. Pelibatan Aktif dalam Forum Kebijakan

- Mengikutsertakan bidan secara aktif dalam forum atau diskusi yang membahas kebijakan kesehatan.

c. **Penguatan Kapasitas Advokasi**

- Memberikan pelatihan advokasi kebijakan secara berkala agar bidan dapat secara efektif menyuarakan kebutuhan dan tantangan di lapangan.

G. Pendekatan Multidisipliner dan Kolaborasi Tim

Kolaborasi tim multidisipliner menjadi penting untuk mengatasi berbagai tantangan kompleks dalam pelayanan kebidanan. Kolaborasi ini melibatkan berbagai profesional kesehatan seperti bidan, dokter spesialis kandungan, perawat, ahli gizi, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk memberikan pelayanan holistik.

1. Manfaat Pendekatan Multidisipliner

- a. **Peningkatan Kualitas Pelayanan:** Memastikan pasien menerima perawatan komprehensif dan terintegrasi.
- b. **Optimalisasi Keputusan Klinis:** Kolaborasi berbagai ahli memungkinkan keputusan klinis yang lebih efektif dan tepat.
- c. **Pengurangan Risiko Komplikasi:** Identifikasi dini dan intervensi cepat melalui kerja sama tim yang efektif.

2. Strategi Efektif untuk Kolaborasi Multidisipliner

- a. **Komunikasi Efektif:** Pertemuan rutin tim multidisipliner untuk mendiskusikan kasus dan perencanaan perawatan pasien.
- b. **Peningkatan Kompetensi Interprofesional:** Pelatihan interprofesional untuk memahami peran masing-masing profesi kesehatan dalam tim.
- c. **Penggunaan Teknologi Kolaboratif:** Platform digital untuk memudahkan komunikasi, dokumentasi, dan koordinasi antar anggota tim.

H. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat penting dalam menghadapi tantangan baru dalam praktik kebidanan. Dengan mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap tren terkini, serta memfasilitasi pelatihan dan seminar, bidan dapat secara efektif meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Strategi Implementasi Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

1. Pengembangan Kurikulum yang Adaptif

- a. Mengintegrasikan isu-isu terbaru dan teknologi terkini ke dalam kurikulum pendidikan kebidanan.

2. Pelatihan Praktik Klinis Berbasis Simulasi

- a. Menyediakan pelatihan simulasi untuk menghadapi skenario klinis kompleks secara aman dan efektif.

3. Seminar dan Workshop Berkala

- a. Mengadakan seminar dan workshop secara rutin dengan melibatkan pakar nasional maupun internasional guna berbagi wawasan dan pengalaman terkini.

I. Latihan Soal

Kasus 1: Seorang ibu hamil berusia 27 tahun, tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas ke layanan kesehatan. Ia kesulitan dalam memantau kondisi kehamilannya secara rutin. Anda sebagai bidan ingin menerapkan telehealth untuk membantunya.

Apa langkah pertama yang paling tepat untuk Anda lakukan sebelum memulai konsultasi telehealth?

- A. Mengirimkan perangkat medis canggih ke rumah pasien
- B. Memastikan infrastruktur teknologi yang memadai
- C. Menyarankan pasien segera datang ke klinik terdekat
- D. Menghubungi dokter spesialis kandungan untuk meminta pendampingan
- E. Melakukan konsultasi psikologi terlebih dahulu

Jawaban: B

Pembahasan: Sebelum mengimplementasikan telehealth, langkah penting pertama adalah memastikan adanya infrastruktur teknologi yang memadai sehingga proses telekomunikasi digital dapat berjalan lancar dan efektif.

Kasus 2: Seorang bidan di klinik desa ingin mengadopsi pendekatan kebidanan berbasis bukti dalam praktiknya. Namun, ia merasa kesulitan mengakses sumber literatur terbaru.

Strategi apa yang paling efektif untuk membantu bidan tersebut memperoleh literatur ilmiah terkini?

- A. Mengikuti seminar rutin di kota besar setiap minggu
- B. Melakukan langganan jurnal internasional secara mandiri
- C. Menggunakan database penelitian online gratis atau berbiaya rendah
- D. Menghindari perubahan praktik dan mengandalkan pengalaman klinis semata
- E. Membentuk komunitas diskusi klinis di media sosial tanpa akses ke jurnal ilmiah

Jawaban: C

Pembahasan: Strategi paling efektif adalah menggunakan database penelitian online yang mudah diakses, gratis atau berbiaya rendah sehingga memungkinkan bidan memperoleh informasi terbaru tanpa terkendala biaya.

Kasus 3: Seorang ibu hamil mengalami kecemasan tinggi dan tanda-tanda depresi ringan selama kehamilannya. Bidan menyadari pentingnya kesehatan mental selama kehamilan.

Tindakan utama apa yang sebaiknya dilakukan bidan dalam kasus ini?

- A. Memberikan obat penenang kepada ibu
- B. Melakukan skrining kesehatan mental secara rutin dengan instrumen standar
- C. Merujuk ibu ke fasilitas kesehatan jiwa secara langsung
- D. Menghindari diskusi tentang kesehatan mental karena khawatir menambah kecemasan
- E. Menyarankan ibu untuk istirahat di rumah tanpa intervensi lanjut

Jawaban: B

Pembahasan: Langkah utama adalah melakukan skrining kesehatan mental secara rutin dengan instrumen terstandar seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), yang memungkinkan deteksi dini gangguan mental dan intervensi tepat waktu.

Kasus 4: Anda bekerja sebagai bidan di puskesmas yang mulai mengintegrasikan pelayanan kebidanan dengan pelayanan kesehatan primer.

Manfaat utama dari integrasi tersebut bagi pasien adalah:

- A. Pasien harus melakukan perjalanan lebih jauh untuk layanan spesialis
- B. Terbatasnya interaksi pasien dengan bidan
- C. Pelayanan kesehatan yang lebih mahal
- D. Kontinuitas pelayanan yang lebih baik dari masa kehamilan hingga pascanifas
- E. Bidan memiliki beban kerja yang meningkat drastis tanpa dukungan tambahan

Jawaban: D

Pembahasan: Integrasi praktik kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer memberikan manfaat utama berupa kontinuitas pelayanan yang holistik dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas dan perawatan bayi.

Kasus 5: Di sebuah daerah terpencil, angka komplikasi kebidanan masih tinggi karena keterbatasan tenaga kesehatan terlatih. Pemerintah setempat ingin menerapkan pelatihan kebidanan berbasis simulasi digital.

Apa keuntungan utama dari pelatihan berbasis simulasi digital tersebut?

- A. Membutuhkan biaya yang sangat tinggi
- B. Meningkatkan risiko kesalahan klinis pada bidan
- C. Memberikan pengalaman praktis tanpa risiko nyata bagi pasien
- D. Mengurangi kompetensi komunikasi interpersonal bidan
- E. Hanya cocok digunakan di pusat kesehatan besar

Jawaban: C

Pembahasan: Pelatihan berbasis simulasi digital memberikan keuntungan utama yaitu memungkinkan bidan memperoleh pengalaman praktis dalam lingkungan simulasi yang aman dan bebas risiko bagi pasien.

J. Rangkuman Materi

Tren terkini dalam praktik kebidanan berkembang akibat pengaruh kemajuan teknologi, perubahan demografi, kebijakan kesehatan, dan tuntutan masyarakat. Salah satu tren yang menonjol adalah pemanfaatan telehealth atau kebidanan virtual. Telehealth merupakan penggunaan teknologi digital dalam memberikan layanan kesehatan jarak jauh, seperti konsultasi prenatal, edukasi kesehatan, dan pemantauan kehamilan secara virtual. Tren ini semakin berkembang pesat sejak pandemi COVID-19 karena memungkinkan akses layanan yang lebih mudah, efisiensi waktu dan biaya transportasi, kontinuitas pelayanan meski terbatasnya kunjungan tatap muka, serta edukasi prenatal yang lebih efektif. Meski demikian, implementasi telehealth menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi terutama di daerah terpencil, risiko keamanan data, dan perlunya pelatihan khusus bagi bidan. Untuk optimalisasi penggunaannya, diperlukan kebijakan dan dukungan pendidikan yang jelas.

Pendekatan berbasis bukti (Evidence-Based Midwifery) juga menjadi tren penting, yaitu praktik kebidanan yang mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terkini, pengalaman klinis bidan, serta preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis. Manfaat dari pendekatan ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya kesehatan, serta meningkatnya kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan. Implementasi pendekatan ini mencakup identifikasi masalah klinis, pencarian bukti ilmiah, evaluasi kritis terhadap bukti tersebut, penerapannya dalam praktik, dan evaluasi secara rutin terhadap efektivitas intervensi. Namun, pendekatan ini menghadapi kendala seperti akses terbatas terhadap literatur ilmiah, kurangnya keterampilan dalam menilai bukti, serta resistensi terhadap perubahan praktik yang sudah ada. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu mendukung penguatan kurikulum dan pelatihan khusus.

Integrasi pelayanan kebidanan ke dalam pelayanan kesehatan primer juga menjadi fokus dalam praktik kebidanan modern. Integrasi ini bertujuan meningkatkan akses, kontinuitas, kualitas layanan, dan kolaborasi interprofesional, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Implementasi integrasi meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur pelayanan, pengembangan sistem rujukan yang efisien, serta penyusunan kebijakan yang mendukung. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan tenaga

kesehatan yang terlatih, infrastruktur yang tidak merata, dan resistensi budaya kerja. Untuk mengatasi ini diperlukan advokasi, edukasi, pelatihan berkelanjutan, serta komitmen dari semua pihak terkait.

Perhatian terhadap kesehatan mental ibu selama kehamilan dan setelah melahirkan juga semakin meningkat dalam praktik kebidanan. Kesehatan mental yang baik sangat penting bagi kesejahteraan ibu dan perkembangan bayi. Praktik ini melibatkan skrining rutin dengan instrumen standar seperti EPDS, pemberian edukasi tentang tanda-tanda gangguan mental, kolaborasi dengan profesional kesehatan mental, serta dukungan konseling berkelanjutan. Tantangan utama dalam implementasi ini adalah stigma sosial, kurangnya tenaga profesional kesehatan mental, dan akses layanan yang terbatas terutama di daerah terpencil. Pendidikan kesehatan mental dan dukungan kebijakan menjadi solusi penting untuk tantangan ini.

Selain tren terkini, praktik kebidanan juga menghadapi isu kontemporer seperti kesenjangan akses layanan kebidanan, terutama di wilayah terpencil. Faktor yang menyebabkan kesenjangan meliputi kendala geografis, kurangnya tenaga kesehatan terlatih, infrastruktur dan transportasi yang buruk, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dampaknya sangat serius seperti meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, komplikasi persalinan, serta keterbatasan pelayanan preventif. Strategi mengatasi kesenjangan ini mencakup penguatan sistem kesehatan primer, penggunaan teknologi digital, pelatihan khusus, advokasi kebijakan proaktif, dan mobilisasi komunitas.

Keselamatan pasien juga menjadi perhatian utama dalam praktik kebidanan, mencakup komunikasi yang efektif, kepatuhan terhadap prosedur klinis, dan pengawasan ketat kondisi pasien. Tantangan dalam pengelolaan risiko mencakup variasi kompetensi bidan, keterbatasan sumber daya medis, serta keterlambatan identifikasi risiko. Strategi efektif yang digunakan adalah penguatan sistem dokumentasi, pendekatan kolaboratif tim, dan menanamkan budaya keselamatan.

Pengembangan profesional berkelanjutan (Continuous Professional Development atau CPD) adalah hal penting dalam menjaga kompetensi bidan agar relevan dengan perkembangan terkini. CPD mencakup pelatihan simulasi, e-learning, webinar, serta seminar ilmiah. Isu etika dan legal juga krusial, mencakup prinsip seperti otonomi, berbuat baik, tidak merugikan, dan keadilan, serta isu hukum seperti informed consent, malpraktik, dan privasi data pasien. Pelatihan rutin mengenai etika dan hukum serta komunikasi interpersonal menjadi penting.

Menghadapi tren dan isu ini, kompetensi digital, advokasi kebijakan, kolaborasi tim multidisipliner, serta pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan. Kompetensi digital memungkinkan perluasan akses pelayanan dan peningkatan

efisiensi. Advokasi kebijakan bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan pengakuan profesi bidan. Kolaborasi tim multidisipliner penting untuk memberikan layanan holistik dan terintegrasi, sedangkan pendidikan berkelanjutan menjamin kesiapan bidan menghadapi tantangan klinis terkini secara efektif.

K. Glosarium

Advokasi Kebijakan: Upaya sistematis untuk mempengaruhi kebijakan publik guna meningkatkan akses, kualitas layanan, dan pengakuan profesi kebidanan melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Evidence-Based Midwifery: Praktik pengambilan keputusan klinis berdasarkan hasil penelitian ilmiah terbaru, pengalaman klinis praktisi, serta nilai dan preferensi pasien untuk memastikan efektivitas dan keselamatan pelayanan.

Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer: Penggabungan praktik kebidanan ke dalam sistem pelayanan kesehatan primer, bertujuan memberikan pelayanan holistik, berkelanjutan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keselamatan Pasien: Tindakan preventif dalam praktik kebidanan yang bertujuan untuk mencegah cedera, infeksi, atau komplikasi lain pada pasien selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas.

Kompetensi Digital: Kemampuan bidan dalam menggunakan teknologi digital, seperti telehealth, untuk memberikan layanan kesehatan secara virtual yang efisien, aman, dan efektif.

Kolaborasi Multidisipliner: Kerjasama antara berbagai profesional kesehatan seperti bidan, dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, dan tenaga medis lainnya untuk memberikan pelayanan holistik dan terkoordinasi secara efektif.

Kontinuitas Pelayanan: Prinsip penyediaan layanan kebidanan yang berkelanjutan mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan hingga masa nifas untuk menjaga kualitas layanan.

Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Continuous Professional Development - CPD): Proses sistematis untuk memastikan bidan secara terus-menerus memperbarui pengetahuan dan keterampilan profesionalnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Pendekatan Berbasis Bukti: Metode pengambilan keputusan klinis yang menggabungkan bukti ilmiah terbaik dengan pengalaman klinis serta preferensi pasien, untuk menghasilkan intervensi yang aman dan efektif.

Privasi dan Kerahasiaan Data Pasien: Perlindungan informasi pribadi pasien, khususnya dalam konteks digitalisasi rekam medis dan komunikasi virtual, dari penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran privasi.

Telehealth: Pemanfaatan teknologi komunikasi digital dalam memberikan layanan kesehatan jarak jauh, termasuk konsultasi prenatal, edukasi kesehatan, dan pemantauan kondisi kehamilan.

Skrining Kesehatan Mental: Proses evaluasi kesehatan mental ibu secara rutin menggunakan instrumen terstandar untuk deteksi dini gangguan mental selama kehamilan dan masa nifas.

L. Daftar pustaka

- Acosta, D. F., Gomes, E. T., Fonseca, D. L., Guedes, A. C., & Souza, C. L. (2021). Telehealth in obstetric care: Trends, opportunities, and challenges post COVID-19 pandemic. *International Journal of Medical Informatics*, 151, 104458. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2021.104458>
- Chen, J., & Allaire, C. (2022). Evidence-based midwifery practice: Benefits, challenges, and recommendations for implementation. *Midwifery*, 104, 103165. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103165>
- Coxon, K., Turienzo, C. F., Kweekel, L., Goodarzi, B., Brigante, L., & Simon, A. (2020). The impact of integrating midwifery services into primary health care: A systematic review. *Health Policy*, 124(12), 1280–1290. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.10.004>
- Fenwick, J., Sidebotham, M., Gamble, J., & Creedy, D. K. (2018). Promoting effective care through midwifery-led continuity: A narrative review. *Midwifery*, 62, 17–22. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.03.012>
- Jones, A., & Johnstone, M.-J. (2019). Managing safety and risk in midwifery practice: Promoting a safety culture. *Journal of Advanced Nursing*, 75(6), 1234–1242. <https://doi.org/10.1111/jan.13950>
- Kingston, D., McDonald, S., Biringer, A., & Austin, M. P. (2015). Perinatal mental health: Prioritizing maternal wellbeing. *Journal of Affective Disorders*, 186, 75–85. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2015.07.014>
- Levy, V., & McCandlish, R. (2021). Ethical and legal issues in midwifery practice: An integrated approach. *Midwifery*, 95, 102951. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102951>
- Mocumbi, S., Högberg, U., Lampa, E., Saco, C., Valá, A., Bergström, A., & Hanson, C. (2019). Mothers' satisfaction with care during facility-based childbirth: A cross-sectional survey in Southern Mozambique. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(1), 303. <https://doi.org/10.1186/s12884-019-2449-6>

- Renfrew, M. J., Cheyne, H., Craig, J., Duff, E., Dykes, F., Hunter, B., & Downe, S. (2020). Sustaining quality midwifery care: Priorities and strategies for global practice and education. *The Lancet Global Health*, 8(8), e1027–e1039. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30237-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30237-3)
- Shorey, S., Chan, V., Chong, Y. S., & He, H. G. (2021). Digital health interventions for maternal mental health: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 23(3), e27647. <https://doi.org/10.2196/27647>
- Simpson, K. R., & Lyndon, A. (2021). Improving patient safety in midwifery care through effective communication and documentation. *Nursing for Women's Health*, 25(1), 65–74. <https://doi.org/10.1016/j.nwh.2020.12.001>
- World Health Organization (WHO). (2021). WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550505>

BAB 3

SOCIAL MODEL VS MEDICAL MODEL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Pendahuluan

Praktik kebidanan secara umum terdiri dari dua pendekatan utama yaitu social model dan medical model. Kedua model ini memiliki pandangan dan implementasi yang berbeda dalam menangani proses kehamilan dan kelahiran. Buku ajar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep dasar social model, menyoroti pentingnya menghormati proses alami kehamilan dan persalinan, serta peran komunitas, seni dalam pelayanan, dan penggunaan teknologi secara bijaksana.

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)

Mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip social model dalam praktik kebidanan untuk mendukung proses fisiologis alami kehamilan dan persalinan dengan pendekatan berbasis komunitas dan pemberdayaan perempuan.

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Mahasiswa mampu memahami perbedaan antara social model dan medical model dalam praktik kebidanan serta mengimplementasikan konsep-konsep social model untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.

Sub-CPMK

- Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya antisipasi keadaan normal dalam social model kebidanan.
- Mahasiswa mampu menggambarkan kebidanan sebagai seni dalam konteks social model.
- Mahasiswa mampu menjelaskan peran komunitas dan budaya lokal dalam praktik kebidanan.
- Mahasiswa mampu menggunakan teknologi sebagai penolong secara bijaksana dalam social model.

A. Antisipasi Keadaan Normal

Dalam pendekatan social model, kebidanan berfokus pada prinsip bahwa kehamilan dan persalinan adalah peristiwa fisiologis alami yang sebagian besar berlangsung normal tanpa intervensi medis. Model ini berusaha menciptakan lingkungan yang tenang, nyaman, dan positif untuk mendukung kondisi alami tubuh ibu yang mampu menjalani kehamilan dan melahirkan secara sehat.

Pendekatan ini menekankan pada pemberian edukasi yang menyeluruh kepada ibu tentang perubahan fisiologis selama kehamilan, tanda-tanda persalinan alami, manajemen rasa sakit non-farmakologis, serta bagaimana merespons proses kelahiran secara percaya diri. Edukasi yang diberikan oleh bidan berfungsi sebagai dasar pemberdayaan perempuan, membantu mereka merasa percaya pada tubuh dan kemampuan alami mereka sendiri dalam menghadapi kelahiran.

Sebaliknya, medical model menempatkan kehamilan dan persalinan sebagai proses yang berpotensi mengalami komplikasi dan cenderung mengantisipasi kemungkinan masalah melalui pengawasan yang intensif serta intervensi medis rutin. Meskipun pendekatan ini dapat bermanfaat dalam situasi darurat, pemakaian yang berlebihan sering kali menyebabkan ibu merasa kurang mampu dan bergantung pada intervensi medis. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko komplikasi akibat intervensi medis yang tidak diperlukan, seperti induksi persalinan atau operasi caesar tanpa indikasi medis yang jelas.

Pendekatan social model mengajarkan bidan untuk mengenali tanda-tanda normal, memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi proses persalinan berlangsung secara alami, serta meminimalisir intervensi medis kecuali ada indikasi klinis yang kuat. Ini juga melibatkan pengembangan rencana persalinan yang fleksibel bersama ibu, berdasarkan pilihan-pilihan yang sudah diinformasikan secara jelas sebelumnya.

B. Seni dalam Praktik Kebidanan

Pendekatan social model dalam kebidanan memandang praktik kebidanan sebagai suatu seni yang membutuhkan sensitivitas emosional, empati yang mendalam, dan kreativitas dalam memberikan pelayanan yang unik dan individual kepada setiap ibu. Kebidanan sebagai seni menekankan bahwa setiap pengalaman kelahiran adalah unik dan sangat personal, sehingga menuntut bidan untuk mampu memahami, mendukung, dan merespons kebutuhan emosional, psikologis, dan spiritual setiap ibu secara spesifik.

Dalam praktik kebidanan sebagai seni, kemampuan interpersonal sangatlah penting. Bidan tidak hanya menjalankan peran klinis tetapi juga membangun hubungan yang hangat, saling percaya, dan empati dengan ibu dan keluarganya. Ini melibatkan komunikasi yang efektif, yang mencakup keterampilan mendengarkan aktif, merespons secara empati terhadap kekhawatiran dan kebutuhan ibu, serta memberikan dukungan emosional secara efektif selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.

Bidan dituntut memiliki sensitivitas emosional yang tinggi untuk memahami dan mengenali perasaan serta kecemasan ibu. Mereka harus mampu mengelola situasi secara emosional dengan memberikan dukungan yang menenangkan, mengurangi rasa takut, dan membantu ibu merasa lebih percaya diri menghadapi persalinan. Keterampilan ini penting karena pengalaman emosional yang positif berkontribusi besar terhadap hasil persalinan yang baik dan kepuasan ibu.

Kreativitas juga merupakan elemen penting dalam seni kebidanan. Kreativitas ini ditunjukkan dalam cara bidan menyesuaikan pendekatan dan dukungannya berdasarkan kebutuhan unik setiap ibu. Misalnya, menggunakan teknik relaksasi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan ibu, menciptakan lingkungan persalinan yang nyaman dan hangat, atau menemukan cara-cara inovatif untuk melibatkan keluarga dalam proses persalinan.

Lebih lanjut, seni kebidanan mencakup kemampuan intuitif bidan dalam mengenali kebutuhan tersembunyi atau emosi yang tidak terucapkan oleh ibu. Bidan dituntut mampu membaca ekspresi, bahasa tubuh, serta tanda-tanda emosional lainnya, yang kemudian digunakan untuk memberikan dukungan yang lebih personal dan efektif.

Seni dalam kebidanan juga melibatkan penggunaan teknik komunikasi terapeutik, di mana bidan dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan melalui kata-kata yang menenangkan, sentuhan fisik yang tepat, serta sikap yang penuh perhatian. Keterampilan ini tidak hanya membantu ibu dalam menghadapi stres selama persalinan tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik oleh ibu dan keluarganya.

Sebaliknya, medical model sering kali kurang memperhatikan aspek seni dalam kebidanan. Fokus utama dalam medical model biasanya berada pada prosedur klinis, intervensi medis, dan penggunaan teknologi. Akibatnya, aspek emosional dan personal dari persalinan sering terabaikan, yang dapat menyebabkan pengalaman kelahiran kurang memuaskan secara emosional bagi ibu dan keluarganya.

C. Lokal/Komunitas dalam Praktik Kebidanan

Social model menempatkan komunitas dan budaya lokal sebagai aspek inti dalam pelayanan kebidanan. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap komunitas memiliki nilai, norma, kepercayaan, dan tradisi yang unik, yang sangat mempengaruhi bagaimana kehamilan dan persalinan dialami oleh ibu dan keluarganya. Oleh karena itu, praktik kebidanan yang efektif harus mampu beradaptasi dengan konteks sosial, budaya, dan spiritual masyarakat tempat layanan kebidanan tersebut diberikan.

Keterlibatan komunitas dalam social model kebidanan mencakup berbagai aspek penting. Pertama, komunitas berperan dalam memberikan dukungan sosial yang kuat kepada ibu, yang merupakan elemen krusial dalam menjaga kesehatan mental dan emosional ibu selama kehamilan dan persalinan. Dukungan ini dapat berupa kehadiran keluarga besar, kelompok ibu hamil, serta jaringan sosial informal yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman.

Selain itu, komunitas juga menyediakan sarana penting yang mendukung kesehatan ibu dan bayi, seperti fasilitas kesehatan berbasis komunitas, pendidikan kehamilan, pelatihan keterampilan hidup sehat, serta penyediaan nutrisi dan sumber daya lain yang dibutuhkan ibu hamil dan menyusui. Dukungan komunitas juga mencakup penyebaran informasi yang akurat dan relevan tentang kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi baru lahir melalui berbagai kegiatan seperti kelas ibu hamil, pertemuan komunitas, dan program edukasi yang melibatkan tokoh lokal.

Praktik kebidanan berbasis komunitas juga menuntut bidan untuk aktif dalam menjalin kolaborasi yang kuat dengan tokoh masyarakat seperti pemimpin adat, pemuka agama, serta tokoh masyarakat lainnya. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa praktik kebidanan yang diberikan sejalan dengan nilai-nilai budaya setempat dan memperoleh dukungan penuh dari komunitas. Tokoh masyarakat dapat membantu dalam menyampaikan pesan kesehatan yang penting, memobilisasi sumber daya komunitas, serta memperkuat legitimasi praktik kebidanan di tengah masyarakat.

Sebaliknya, medical model cenderung kurang memperhatikan aspek komunitas dan budaya lokal. Pendekatan ini seringkali menempatkan standar medis universal tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya spesifik, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau resistensi dari masyarakat. Dalam medical model, praktik kebidanan biasanya dilakukan secara klinis dan teknis, dengan sedikit ruang untuk keterlibatan komunitas, yang berpotensi menyebabkan praktik tersebut menjadi kurang relevan dan efektif dalam konteks lokal.

D. Teknologi sebagai Penolong

Dalam social model, teknologi dipandang sebagai alat bantu yang digunakan secara selektif dan bijaksana dalam mendukung proses alami kehamilan dan persalinan. Prinsip utama dari penggunaan teknologi dalam social model adalah mendukung, bukan mendominasi. Teknologi dipakai hanya jika memang diperlukan secara klinis dan dalam kondisi yang tidak mengganggu atau mengubah proses alami persalinan secara signifikan.

Teknologi kebidanan seperti ultrasonografi (USG), monitor janin elektronik (Electronic Fetal Monitoring atau EFM), dan alat diagnostik lainnya dipilih berdasarkan kebutuhan yang jelas dan digunakan secara hati-hati serta proporsional. Sebagai contoh, ultrasonografi digunakan untuk mendeteksi komplikasi dini yang membutuhkan penanganan lebih lanjut tanpa secara otomatis mengarah pada intervensi yang tidak perlu. Demikian juga, monitor janin elektronik digunakan secara selektif, khususnya dalam kondisi yang memang berisiko, untuk memastikan keselamatan janin tanpa mengurangi kepercayaan ibu terhadap proses alami persalinannya.

Pendekatan ini mengutamakan penilaian klinis bidan yang cermat dan mendalam, yang tidak hanya bergantung pada teknologi tetapi juga mempertimbangkan informasi lain seperti riwayat medis, kondisi psikologis ibu, dan dinamika emosional keluarga. Ini memastikan bahwa penggunaan teknologi bersifat mendukung dan bukan mengintervensi proses alami secara berlebihan.

Sebaliknya, medical model sering menempatkan teknologi sebagai pusat perhatian utama dalam pelayanan kebidanan. Pendekatan ini cenderung mengandalkan intervensi teknologi secara luas dan rutin untuk memonitor dan mengelola proses kehamilan dan persalinan. Penggunaan teknologi dalam medical model bertujuan untuk mengontrol dan mengantisipasi komplikasi secara dini, namun pendekatan ini sering kali menyebabkan proses persalinan yang sebenarnya normal berubah menjadi sangat medis. Akibatnya, ibu sering kali mengalami kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, mengurangi kepercayaan diri, dan meningkatkan ketergantungan pada intervensi medis.

Kelebihan penggunaan teknologi secara berlebihan dalam medical model juga dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti meningkatnya angka intervensi yang tidak perlu seperti operasi caesar, induksi persalinan yang tidak didasarkan pada indikasi medis yang jelas, serta meningkatnya tingkat stres dan kecemasan pada ibu.

Dalam konteks social model, teknologi harus digunakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Bidan perlu memahami secara jelas kapan teknologi benar-benar diperlukan, mengedukasi ibu tentang tujuan dan dampak dari penggunaan

teknologi tersebut, serta memastikan bahwa penggunaannya mendukung pengalaman persalinan yang positif, aman, dan nyaman bagi ibu.

E. Latihan Soal

Kasus 1:

Ibu Dewi, usia 25 tahun, sedang hamil anak pertama dengan usia kehamilan 38 minggu. Ia tampak cemas menghadapi persalinan karena sering mendengar cerita tentang komplikasi persalinan dari teman-temannya. Sebagai seorang bidan yang menerapkan social model, tindakan apa yang paling tepat Anda lakukan untuk mendukung Ibu Dewi?

- A. Menyarankan induksi persalinan segera untuk menghindari komplikasi.
- B. Memberikan edukasi tentang proses persalinan normal dan teknik relaksasi non farmakologis.
- C. Memasang monitor janin secara rutin tanpa indikasi klinis yang jelas.
- D. Merekomendasikan ibu segera dirujuk ke dokter spesialis kandungan untuk operasi caesar.
- E. Meminta ibu menjalani ultrasonografi secara intensif menjelang persalinan.

Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Dalam pendekatan social model, penting untuk memberikan edukasi secara menyeluruh tentang proses persalinan normal, menenangkan kecemasan ibu, serta menekankan penggunaan teknik relaksasi non-farmakologis. Hal ini bertujuan memberdayakan ibu agar percaya diri terhadap kemampuan alami tubuhnya.

Kasus 2:

Ibu Siti, usia 30 tahun, melahirkan anak keduanya secara normal dengan lancar di fasilitas kesehatan komunitas. Ia didampingi keluarga dan merasa nyaman sepanjang proses persalinan. Faktor utama apa yang paling berperan dalam mendukung kelancaran proses persalinan tersebut menurut social model?

- A. Penggunaan teknologi monitor janin intensif selama proses persalinan.
- B. Lingkungan persalinan yang nyaman, positif, dan didukung keluarga serta komunitas.
- C. Pemberian obat-obatan pereda nyeri secara rutin selama persalinan.
- D. Pemantauan klinis yang sangat ketat dan rutin tanpa indikasi jelas.
- E. Induksi persalinan dini untuk menghindari risiko komplikasi.

Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Social model menekankan pentingnya menciptakan lingkungan persalinan yang nyaman, positif, serta melibatkan keluarga dan komunitas untuk memberikan dukungan emosional yang kuat, yang terbukti dapat mempermudah proses persalinan.

Kasus 3:

Ibu Rina, usia 28 tahun, sedang hamil anak pertamanya. Ia merasa takut menghadapi persalinan, dan sering tampak gelisah saat konsultasi kebidanan. Sebagai seorang bidan, bagaimana pendekatan terbaik yang mencerminkan seni dalam praktik kebidanan untuk mengatasi kekhawatiran Ibu Rina?

- A. Menyarankan operasi caesar untuk menghilangkan kecemasan ibu.
- B. Memberikan resep obat penenang untuk ibu.
- C. Menggunakan komunikasi terapeutik, empati, serta teknik relaksasi untuk menenangkan ibu.
- D. Memasang monitor janin secara rutin sejak awal kehamilan.
- E. Merujuk ibu ke psikolog secara langsung tanpa pendekatan interpersonal.

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Seni dalam praktik kebidanan mencakup penggunaan komunikasi terapeutik, empati mendalam, serta teknik relaksasi non-farmakologis untuk membantu ibu mengelola kecemasan dan merasa lebih percaya diri menghadapi persalinan.

Kasus 4:

Di desa Sukamakmur, masyarakat memiliki tradisi melibatkan keluarga besar dalam proses persalinan. Sebagai bidan yang mengaplikasikan social model, tindakan apa yang paling tepat dalam memberikan layanan kebidanan di desa ini?

- A. Melarang keterlibatan keluarga selama persalinan demi menjaga sterilitas ruang persalinan.
- B. Mengabaikan tradisi lokal dan menerapkan standar medis universal secara ketat.
- C. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi dan mendukung keterlibatan keluarga secara aman.
- D. Melakukan induksi persalinan rutin kepada semua ibu hamil di desa tersebut.
- E. Merujuk semua persalinan ke rumah sakit kota agar sterilitas terjamin.

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Pendekatan social model menekankan pentingnya adaptasi terhadap budaya lokal dan keterlibatan aktif komunitas dalam proses persalinan, termasuk kolaborasi erat dengan tokoh masyarakat setempat.

Kasus 5:

Ibu Yuni, usia 26 tahun, kehamilan kedua, datang ke klinik kebidanan pada usia kehamilan 39 minggu tanpa keluhan. Bidan menggunakan ultrasonografi hanya untuk memastikan kondisi janin. Penggunaan teknologi dalam kasus ini mencerminkan prinsip apa dalam social model?

- A. Teknologi sebagai pusat utama dalam proses persalinan.
- B. Teknologi digunakan secara selektif dan proporsional berdasarkan indikasi klinis.
- C. Teknologi harus digunakan rutin pada setiap kunjungan antenatal.
- D. Teknologi yang dominan dalam menentukan proses persalinan.
- E. Penggunaan teknologi intensif sejak awal kehamilan.

Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Dalam pendekatan social model, teknologi seperti ultrasonografi dipilih berdasarkan kebutuhan klinis yang jelas dan digunakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi agar mendukung, bukan mendominasi proses alami kehamilan dan persalinan.

F. Rangkuman Materti

Pendekatan social model dalam kebidanan menekankan pentingnya mengantisipasi keadaan normal selama kehamilan dan persalinan, yang dipandang sebagai peristiwa fisiologis alami yang umumnya berjalan lancar tanpa perlu intervensi medis berlebihan. Bidan dalam pendekatan ini bertugas menciptakan lingkungan yang nyaman dan positif serta memberikan edukasi yang menyeluruh agar ibu mampu memahami dan percaya terhadap kemampuan alami tubuhnya. Berbeda dengan social model, medical model lebih memandang kehamilan dan persalinan sebagai proses yang rentan terhadap komplikasi, sehingga mengandalkan pengawasan intensif dan intervensi medis yang rutin. Pendekatan ini, meskipun penting dalam kondisi tertentu, dapat menyebabkan ibu menjadi kurang percaya diri dan terlalu bergantung pada tindakan medis, bahkan meningkatkan risiko komplikasi akibat intervensi yang tidak diperlukan.

Lebih jauh, pendekatan social model dalam kebidanan dipandang sebagai suatu seni yang melibatkan sensitivitas emosional tinggi, empati yang mendalam, dan kreativitas dalam memberikan pelayanan individual. Setiap ibu dianggap unik, dengan kebutuhan emosional, psikologis, dan spiritual yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang bidan dituntut mampu menjalin hubungan interpersonal yang erat, menggunakan komunikasi yang efektif, serta memberikan dukungan emosional selama proses kehamilan hingga pasca persalinan. Kemampuan intuitif dalam membaca emosi dan ekspresi ibu serta menerapkan teknik komunikasi terapeutik juga menjadi bagian integral dari seni praktik kebidanan. Sebaliknya,

medical model kurang memperhatikan aspek seni ini dan lebih menitikberatkan pada prosedur klinis dan penggunaan teknologi, sehingga sering kali menyebabkan pengalaman persalinan menjadi kurang memuaskan secara emosional bagi ibu.

Aspek komunitas dan budaya lokal juga menjadi elemen kunci dalam pendekatan social model. Praktik kebidanan dalam pendekatan ini sangat memperhatikan konteks sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Keterlibatan komunitas melalui dukungan sosial, penyediaan fasilitas kesehatan berbasis komunitas, dan edukasi kesehatan ibu menjadi hal utama yang diintegrasikan dalam layanan kebidanan. Bidan aktif bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk memastikan praktik kebidanan selaras dengan nilai dan tradisi setempat, sehingga mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Di sisi lain, medical model cenderung kurang memperhatikan konteks budaya lokal dan lebih mengutamakan standar medis universal, yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan dapat memunculkan resistensi atau ketidaknyamanan.

Dalam penggunaan teknologi, social model menerapkan prinsip kehati-hatian tinggi, menggunakan alat diagnostik seperti ultrasonografi atau monitor janin secara selektif dan proporsional sesuai kebutuhan klinis. Teknologi diposisikan sebagai alat penunjang yang mendukung proses alami, bukan mendominasinya. Sebaliknya, medical model menggunakan teknologi secara rutin dan ekstensif dengan tujuan mengantisipasi komplikasi, sehingga berisiko menyebabkan proses persalinan alami berubah menjadi sangat medis. Pendekatan yang berlebihan ini dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan intervensi yang tidak diperlukan bagi ibu. Oleh karena itu, social model lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi secara bijaksana untuk mendukung pengalaman persalinan yang aman, nyaman, dan positif bagi ibu.

G. Glosarium

Antisipasi keadaan normal:

Pendekatan kebidanan yang memperlakukan kehamilan dan persalinan sebagai peristiwa alami tanpa intervensi medis yang tidak perlu.

Social Model:

Model pelayanan kebidanan yang menekankan pada proses alami kehamilan dan persalinan, melibatkan dukungan komunitas, seni, budaya lokal, serta penggunaan teknologi secara bijaksana.

Medical Model:

Pendekatan kebidanan yang berfokus pada kemungkinan komplikasi dan cenderung menggunakan pengawasan intensif dan intervensi medis rutin.

Manajemen rasa sakit non-farmakologis:

Teknik pengelolaan nyeri tanpa penggunaan obat-obatan, seperti teknik relaksasi, pernapasan, atau pijatan selama proses persalinan.

Pemberdayaan perempuan:

Proses mendukung ibu untuk memahami dan mempercayai kemampuan alami tubuhnya dalam menghadapi persalinan melalui edukasi dan dukungan emosional.

Seni dalam kebidanan:

Pendekatan pelayanan kebidanan yang melibatkan empati, sensitivitas emosional, kreativitas, dan kemampuan interpersonal untuk menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan spesifik setiap ibu.

Komunikasi terapeutik:

Teknik komunikasi khusus yang bertujuan memberikan dukungan emosional, menenangkan, dan membantu ibu merasa nyaman dan percaya diri.

Sensitivitas emosional:

Kemampuan bidan dalam mengenali dan memahami perasaan, kecemasan, dan kebutuhan emosional ibu selama kehamilan dan persalinan.

Kreativitas dalam kebidanan:

Kemampuan bidan untuk menggunakan metode dan pendekatan yang inovatif serta adaptif dalam mendukung proses persalinan yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu secara individual.

Praktik berbasis komunitas:

Pelayanan kebidanan yang melibatkan komunitas dan budaya setempat secara aktif dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi melalui penyediaan sarana kesehatan, edukasi, dan dukungan sosial.

Kolaborasi dengan tokoh masyarakat:

Kerja sama yang dijalin oleh bidan dengan pemimpin adat, agama, atau masyarakat untuk memastikan layanan kebidanan relevan dengan nilai-nilai budaya setempat.

Penggunaan teknologi secara selektif:

Penerapan alat-alat medis seperti USG atau monitor janin berdasarkan kebutuhan klinis tertentu, tanpa mendominasi atau mengubah proses persalinan alami secara signifikan.

Medicalisasi:

Kondisi di mana proses persalinan alami menjadi sangat tergantung pada intervensi medis rutin yang tidak selalu diperlukan.

Ultrasonografi (USG):

Teknologi diagnostik yang menggunakan gelombang suara untuk memeriksa kondisi janin selama kehamilan secara visual.

Electronic Fetal Monitoring (EFM):

Teknologi untuk memantau kondisi detak jantung janin selama proses persalinan guna memastikan keselamatan bayi secara selektif.

H. Daftar Pustaka

- Bradfield, Z., Duggan, R., Hauck, Y., & Kelly, M. (2018). Midwives' perceptions of being "with woman": A phenomenological study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 18(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12884-018-1733-9>
- Downe, S., Finlayson, K., Oladapo, O., Bonet, M., & Gülmezoglu, A. M. (2018). What matters to women during childbirth: A systematic qualitative review. *PLOS ONE*, 13(4), e0194906. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194906>
- Fahy, K., Foureur, M., & Hastie, C. (2008). *Birth Territory and Midwifery Guardianship: Theory for Practice, Education and Research*. Elsevier Health Sciences.
- Homer, C. S. E., Friberg, I. K., Bastos Dias, M. A., ten Hoop-Bender, P., Sandall, J., Speciale, A. M., & Bartlett, L. A. (2014). The projected effect of scaling up midwifery. *The Lancet*, 384(9948), 1146–1157. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60790-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60790-X)
- Hunter, B., Berg, M., Lundgren, I., Ólafsdóttir, Ó. A., & Kirkham, M. (2008). Relationships: The hidden threads in the tapestry of maternity care. *Midwifery*, 24(2), 132–137. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2008.02.003>
- Kennedy, H. P., Shannon, M. T., Chuahorm, U., & Kravetz, M. K. (2004). The landscape of caring for women: A narrative study of midwifery practice. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 49(1), 14–23. <https://doi.org/10.1016/j.jmwh.2003.09.015>
- Leap, N., & Hunter, B. (2016). *Supporting Women for Labour and Birth: A Thoughtful Guide*. Routledge.
- Lothian, J. A. (2004). Do not disturb: The importance of privacy in labor. *The Journal of Perinatal Education*, 13(3), 4–6. <https://doi.org/10.1624/105812404X1721>
- Reed, R., Sharman, R., & Inglis, C. (2017). Women's descriptions of childbirth trauma relating to care provider actions and interactions. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 17(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s12884-016-1197-0>
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., ... Declercq, E. (2014). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129–1145. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60789-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3)

Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2016(4). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub5>

BAB 4

SOCIAL MODEL VS MEDICAL MODEL: MENGHARGAI PERBEDAAN, KEPERCAYAAN, INTUISI/MEMAKNAI INTUISI, HUBUNGAN, AKTUALISASI DIRI

Pendahuluan

Pendekatan sosial dalam kebidanan merupakan paradigma alternatif dari pendekatan medis tradisional yang cenderung berorientasi pada patologi dan intervensi teknis. Social model mengedepankan pandangan bahwa kehamilan dan persalinan merupakan proses alami yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis. Model ini menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam perawatan, menghormati haknya untuk menentukan pilihan dan mendapatkan pengalaman melahirkan yang positif dan bermakna.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu menerapkan pendekatan sosial dalam praktik kebidanan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, emosional, dan budaya dalam memberikan pelayanan kebidanan yang holistik dan memberdayakan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan social model dalam praktik kebidanan dengan menekankan aspek menghargai perbedaan, kepercayaan, intuisi, hubungan interpersonal, dan aktualisasi diri.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan dalam praktik kebidanan.
- Mengembangkan keterampilan membangun kepercayaan dengan klien dalam konteks praktik kebidanan.
- Mengenali dan memaknai intuisi dalam proses pelayanan kebidanan.
- Mengembangkan hubungan interpersonal yang positif dengan klien.

- Menunjukkan peran bidan dalam mendukung aktualisasi diri perempuan selama kehamilan dan persalinan.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Social Model dalam Praktik Kebidanan

Social model dalam praktik kebidanan memiliki landasan filosofis bahwa kehamilan dan persalinan adalah proses alami, sosial, dan personal, bukan hanya peristiwa medis yang perlu intervensi teknologi tinggi. Model ini menghargai bahwa pengalaman setiap perempuan unik dan dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan emosional yang perlu diperhatikan secara mendalam.

1. Prinsip-Prinsip Social Model dalam Kebidanan

a. Perempuan sebagai Pusat Perhatian

Prinsip ini menegaskan bahwa perempuan harus menjadi subjek aktif dalam seluruh proses kehamilan dan persalinan. Mereka diberikan ruang untuk mengungkapkan kebutuhan, harapan, dan kekhawatirannya, serta didukung untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan lengkap.

b. Proses Alami dan Sosial

Social model menegaskan bahwa kehamilan dan persalinan bukan penyakit, melainkan proses kehidupan yang alami. Model ini memandang pentingnya dukungan sosial dan emosional dari keluarga, teman, dan komunitas selama proses tersebut.

c. Menghormati Keberagaman dan Budaya

Setiap perempuan memiliki latar belakang budaya, agama, sosial, dan nilai-nilai yang berbeda. Social model menempatkan penghormatan terhadap keberagaman sebagai prinsip utama dalam pelayanan kebidanan, memastikan bahwa pendekatan layanan bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individu.

d. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan dalam konteks kebidanan berarti membantu perempuan mengembangkan kepercayaan diri, kesadaran akan hak-haknya, dan kemampuan membuat keputusan mandiri. Social model mendukung perempuan dalam proses ini melalui edukasi, dukungan emosional, dan pendampingan yang berkelanjutan.

e. Hubungan Interpersonal yang Kuat

Hubungan yang baik antara bidan dan perempuan didasarkan pada komunikasi terbuka, kepercayaan, empati, dan respek. Hubungan ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengurangi kecemasan serta tekanan selama proses kehamilan dan persalinan.

2. Perbedaan Social Model dan Medical Model

a. Fokus Perawatan

Social model memfokuskan perhatian pada perempuan dan aspek sosial dari pengalaman kehamilan dan persalinan. Sebaliknya, medical model lebih berorientasi pada aspek patologi, risiko, dan intervensi medis.

b. Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Dalam social model, perempuan dianggap mampu membuat keputusan yang tepat terkait kehamilan dan persalinannya. Medical model cenderung memposisikan perempuan sebagai penerima pasif dari perawatan medis yang ditentukan oleh tenaga kesehatan.

c. Pendekatan terhadap Teknologi

Social model menggunakan teknologi medis secara minimal, hanya jika benar-benar diperlukan dan dengan persetujuan perempuan. Medical model umumnya lebih agresif dalam penggunaan teknologi medis, sering kali tanpa melibatkan perempuan secara aktif dalam pengambilan keputusan.

d. Sifat Hubungan antara Bidan dan Perempuan

Social model mendorong hubungan yang dekat, personal, dan berkelanjutan antara bidan dan perempuan. Medical model cenderung menciptakan hubungan yang bersifat formal, impersonal, dan terfokus pada aspek klinis semata.

3. Manfaat Social Model dalam Praktik Kebidanan

a. Pengalaman Positif bagi Perempuan

Perempuan merasa dihormati, didengarkan, dan dihargai, yang menghasilkan pengalaman yang lebih memuaskan dan bermakna.

b. Penurunan Intervensi Medis yang Tidak Perlu

Mengurangi risiko intervensi yang tidak diperlukan, sehingga meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

c. Peningkatan Kesejahteraan Emosional dan Psikologis

Perempuan mendapatkan dukungan emosional yang dibutuhkan, sehingga merasa lebih siap secara psikologis menghadapi proses persalinan dan pemulihan setelahnya.

d. Pemberdayaan Perempuan

Perempuan menjadi lebih percaya diri dan merasa mampu mengendalikan proses kehamilan serta persalinannya.

B. Menghargai Perbedaan

Dalam konteks kebidanan, menghargai perbedaan berarti secara sadar dan aktif mengakui bahwa setiap perempuan memiliki latar belakang, kebutuhan, serta harapan yang berbeda terkait kehamilan dan persalinannya. Bidan perlu mengenali perbedaan ini tidak hanya dalam aspek medis tetapi juga dalam aspek emosional, budaya, sosial, serta spiritual. Dengan demikian, bidan mampu menciptakan ruang pelayanan yang inklusif, penuh empati, dan mendukung pemberdayaan perempuan.

1. Aspek-Aspek Menghargai Perbedaan dalam Kebidanan

- a. Budaya** Setiap budaya memiliki pandangan yang berbeda mengenai kehamilan dan persalinan. Beberapa budaya memiliki ritual atau praktik khusus yang dianggap penting dalam proses melahirkan. Bidan perlu memahami dan menghormati praktik-praktik ini, selama praktik tersebut tidak membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Menghormati budaya membantu perempuan merasa dihargai dan nyaman dalam proses perawatan.
- b. Keyakinan Agama** Keyakinan agama sering kali mempengaruhi keputusan dan preferensi perempuan dalam layanan kebidanan. Misalnya, beberapa perempuan mungkin memiliki preferensi tertentu terkait kehadiran tenaga kesehatan atau anggota keluarga selama persalinan. Bidan perlu memastikan bahwa pilihan perempuan berdasarkan keyakinan agamanya dihormati sepenuhnya, serta memastikan perempuan merasa aman dan diterima dalam proses kehamilan dan persalinan.
- c. Nilai-Nilai Individu** Nilai-nilai pribadi seorang perempuan seringkali mempengaruhi persepsi dan pilihannya selama proses kehamilan dan persalinan. Beberapa perempuan mungkin mengutamakan pendekatan alami, sementara yang lain lebih nyaman dengan adanya intervensi medis yang jelas. Bidan perlu bersikap fleksibel dan mendukung perempuan dalam memilih pendekatan yang sesuai dengan nilai pribadinya.
- d. Kebutuhan Emosional** Kehamilan dan persalinan merupakan peristiwa emosional yang intens bagi sebagian besar perempuan. Setiap perempuan memiliki kebutuhan emosional yang unik yang harus dikenali dan dipenuhi oleh bidan. Menghargai kebutuhan emosional berarti memberikan dukungan empati, menguatkan rasa percaya diri perempuan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung secara emosional.

2. Implementasi Menghargai Perbedaan dalam Praktik Kebidanan

- a. Komunikasi Terbuka dan Empatik** Bidan perlu menggunakan komunikasi terbuka, ramah, dan empatik untuk memastikan perempuan merasa nyaman dalam mengungkapkan kebutuhannya secara jujur.

- b. Pendidikan Budaya bagi Tenaga Kebidanan** Bidan perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan mengenai budaya yang beragam untuk meningkatkan sensitivitas dan pemahaman terhadap latar belakang klien.
- c. Pemberian Informasi yang Bersifat Personal** Informasi yang diberikan kepada klien harus disesuaikan dengan latar belakang budaya, agama, serta nilai-nilai individu perempuan, agar informasi tersebut relevan dan mudah dipahami.
- d. Kolaborasi dengan Keluarga dan Komunitas** Menghargai perbedaan juga berarti melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses perawatan, terutama jika praktik kebudayaan tertentu melibatkan keluarga secara intensif dalam proses persalinan.

3. Manfaat Menghargai Perbedaan dalam Praktik Kebidanan

- a. Pengalaman yang Lebih Positif bagi Perempuan** Menghargai perbedaan menghasilkan rasa dihargai dan diterima, yang meningkatkan kepuasan perempuan terhadap pelayanan kebidanan.
- b. Penurunan Tingkat Stres dan Kecemasan** Pendekatan empatik dan responsif mengurangi stres dan kecemasan, membantu perempuan menjalani proses kehamilan dan persalinan dengan lebih tenang.
- c. Hubungan yang Kuat antara Bidan dan Perempuan** Hubungan yang penuh penghormatan dan pemahaman terhadap perbedaan menciptakan kepercayaan yang kuat antara bidan dan perempuan.
- d. Peningkatan Hasil Kesehatan** Dengan pendekatan yang memperhatikan aspek budaya dan emosional, perempuan merasa lebih terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, yang secara positif berdampak pada hasil kehamilan dan persalinan.

C. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan inti dari hubungan antara bidan dan klien dalam social model. Model ini menekankan pentingnya membangun kepercayaan yang mendalam antara bidan dan ibu hamil. Kepercayaan memungkinkan ibu merasa aman, nyaman, dan terbuka dalam menyampaikan kekhawatiran, harapan, serta keinginannya. Dalam praktik, bidan membangun kepercayaan dengan pendekatan empati, transparansi, dan konsistensi, serta menghormati

1. Pentingnya Kepercayaan dalam Kebidanan

Dalam social model, kepercayaan menjadi inti karena tanpa kepercayaan, perempuan cenderung merasa tidak nyaman, cemas, atau bahkan takut. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi, kepatuhan terhadap rekomendasi,

dan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Oleh karena itu, bidan memiliki tanggung jawab untuk secara aktif membangun dan memelihara kepercayaan dengan klien, memastikan bahwa setiap perempuan menjalani proses kehamilan dan persalinan dengan rasa aman dan didukung sepenuhnya.

2. Prinsip-Prinsip Utama dalam Membangun Kepercayaan

- a. Empati** Empati adalah kemampuan bidan untuk memahami perasaan dan perspektif klien secara mendalam. Bidan yang empatik mampu menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi emosional dan fisik klien, membuat perempuan merasa dihargai dan dipahami.
- b. Transparansi** Transparansi melibatkan pemberian informasi yang jujur, jelas, dan akurat kepada klien mengenai kondisi kesehatan, pilihan perawatan, serta risiko yang mungkin terjadi. Hal ini penting agar klien merasa dihormati dalam haknya untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap.
- c. Konsistensi** Konsistensi dalam memberikan perawatan yang berkualitas serta sikap yang stabil dan dapat diandalkan dari bidan sangat penting dalam membangun kepercayaan. Klien akan merasa lebih percaya diri dan tenang jika mengetahui bahwa bidan dapat diandalkan setiap saat.
- d. Penghormatan terhadap Pilihan Klien** Menghormati keputusan dan preferensi klien adalah aspek penting dalam menjaga kepercayaan. Setiap perempuan memiliki hak penuh atas tubuhnya dan keputusan terkait perawatan kesehatannya, sehingga bidan perlu mendukung dan menghormati pilihan tersebut.

3. Strategi Efektif dalam Membangun Kepercayaan

- a. Komunikasi Terbuka dan Efektif** Komunikasi yang terbuka, jelas, dan penuh perhatian adalah dasar utama dalam membangun hubungan yang kuat dan dipercaya. Bidan perlu mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang relevan, serta memberikan umpan balik positif yang konstruktif.
- b. Menyediakan Ruang Aman untuk Berdiskusi** Memberikan ruang aman di mana perempuan merasa nyaman untuk berbicara secara terbuka mengenai kekhawatiran, ketakutan, dan harapan mereka, membantu memperkuat rasa percaya klien terhadap bidan.
- c. Menunjukkan Profesionalisme dan Kompetensi** Profesionalisme dan kompetensi bidan dalam memberikan perawatan dan mengambil keputusan klinis sangat penting. Klien lebih cenderung mempercayai bidan yang mampu menunjukkan keahlian dan kepercayaan diri dalam praktik kebidanan.
- d. Menjalinkan Hubungan Personal yang Positif** Hubungan personal yang hangat, penuh perhatian, dan tulus membantu mempererat kepercayaan klien.

Interaksi yang ramah dan personal membantu klien merasa lebih nyaman dan didukung secara emosional.

4. Dampak Positif dari Kepercayaan dalam Kebidanan

- a. Peningkatan Kepatuhan terhadap Rekomendasi** Klien yang percaya pada bidannya cenderung lebih patuh terhadap saran dan rekomendasi yang diberikan, menghasilkan hasil kesehatan yang lebih optimal.
- b. Pengalaman Kehamilan dan Persalinan yang Lebih Positif** Dengan adanya kepercayaan, perempuan cenderung mengalami proses kehamilan dan persalinan dengan rasa aman, tenang, dan puas terhadap layanan yang diterima.
- c. Mengurangi Stres dan Kecemasan** Hubungan berbasis kepercayaan membantu mengurangi stres, kecemasan, dan ketakutan, menciptakan kondisi mental yang lebih positif selama proses kehamilan dan persalinan.
- d. Memperkuat Hubungan antara Bidan dan Klien** Kepercayaan menciptakan fondasi hubungan yang kokoh dan berkelanjutan, memungkinkan bidan memberikan dukungan yang lebih efektif dan empatik sepanjang masa perawatan.

D. Intuisi/Memaknai Intuisi

Intuisi dalam konteks kebidanan dapat diartikan sebagai kemampuan alami atau naluri seseorang untuk memahami situasi secara instan tanpa proses analitis yang panjang. Intuisi sering kali digambarkan sebagai "perasaan yang tepat" atau "insting" yang muncul dari pengalaman, empati, dan kesadaran mendalam terhadap situasi yang sedang dihadapi. Dalam kebidanan, intuisi ini melibatkan pemahaman intuitif terhadap kebutuhan perempuan yang sedang hamil atau melahirkan, memungkinkan bidan untuk memberikan respon yang cepat, tepat, dan efektif.

1. Pentingnya Intuisi dalam Social Model Kebidanan

Dalam social model kebidanan, intuisi bukan hanya tambahan opsional, tetapi menjadi pusat dalam proses pengambilan keputusan yang sensitif terhadap kebutuhan individu. Intuisi membantu bidan dan perempuan hamil dalam:

- a. Mengidentifikasi Kebutuhan Emosional dan Fisik**

Intuisi membantu dalam mengenali tanda-tanda halus dari kebutuhan emosional dan fisik yang mungkin tidak terdeteksi oleh pendekatan medis konvensional.

- b. Meningkatkan Ketepatan dan Kecepatan Respon**

Dengan menggunakan intuisi, bidan mampu merespons secara cepat dan tepat terhadap situasi yang berubah dengan cepat selama proses persalinan.

c. Memfasilitasi Keputusan yang Holistik dan Personalisasi

Penggunaan intuisi membantu dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan tidak hanya aspek klinis, tetapi juga aspek emosional, sosial, dan budaya perempuan.

2. Cara Mengembangkan dan Memanfaatkan Intuisi dalam Praktik Kebidanan

a. Meningkatkan Kesadaran Diri Bidan perlu mengembangkan kesadaran diri yang tinggi untuk memahami kapan intuisi muncul dan bagaimana menggunakannya secara efektif dalam situasi klinis.

b. Melatih Empati dan Kepekaan Emosional Kepekaan emosional dan empati adalah landasan penting dalam mengembangkan intuisi. Melalui latihan empati, bidan dapat lebih mudah mengenali perasaan dan kebutuhan perempuan yang didampingi.

c. Refleksi Teratur Melakukan refleksi secara rutin terhadap pengalaman klinis membantu bidan mengenali pola-pola intuisi yang efektif, memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan intuisi secara optimal.

d. Membangun Hubungan yang Erat dengan Perempuan Hamil Hubungan interpersonal yang kuat meningkatkan kemampuan bidan dalam mengenali dan merespon kebutuhan secara intuitif.

3. Manfaat Penggunaan Intuisi dalam Praktik Kebidanan

a. Pengalaman Kelahiran yang Lebih Positif Penggunaan intuisi membantu menciptakan lingkungan yang lebih tenang, nyaman, dan mendukung, menghasilkan pengalaman kelahiran yang positif.

b. Peningkatan Kepuasan Klien Klien merasa lebih puas ketika kebutuhan mereka dipahami secara intuitif, yang menunjukkan empati dan perhatian mendalam dari bidan.

c. Penurunan Kebutuhan Intervensi Medis yang Tidak Perlu Intuisi dapat membantu mengenali situasi yang tidak memerlukan intervensi medis, sehingga mengurangi penggunaan teknologi yang berlebihan.

d. Memperkuat Kepercayaan Diri Bidan dan Perempuan Pengakuan dan penggunaan intuisi memperkuat kepercayaan diri bidan dalam mengambil keputusan klinis dan memperkuat keyakinan perempuan terhadap kemampuan alami tubuhnya dalam melahirkan.

4. Tantangan dalam Menggunakan Intuisi

Walaupun penting, penggunaan intuisi dalam praktik kebidanan juga menghadapi tantangan:

a. Skeptisisme dari Model Medis Intuisi seringkali dipandang skeptis dalam lingkungan medis yang menekankan bukti klinis dan teknologi tinggi.

- b. Kurangnya Pelatihan Formal** Kurangnya pelatihan formal dalam mengembangkan intuisi menyebabkan kesulitan bagi bidan untuk mengenali dan memanfaatkan intuisi secara efektif.
- c. Subjektivitas Intuisi** Intuisi bersifat sangat subjektif dan bervariasi antar individu, yang terkadang menyulitkan validasi dalam situasi klinis.

E. Hubungan

Hubungan interpersonal yang kuat dalam praktik kebidanan sangat penting karena kehamilan dan persalinan bukan hanya peristiwa fisik tetapi juga pengalaman emosional yang kompleks. Hubungan yang baik antara bidan dan perempuan memberikan dukungan emosional dan psikologis yang sangat dibutuhkan selama proses kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana perempuan merasa dihargai, aman, dan percaya diri untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul.

1. Karakteristik Hubungan yang Efektif dalam Kebidanan

- a. Hangat dan Ramah** Sikap hangat dan ramah dari bidan membantu perempuan merasa diterima dan nyaman untuk berbagi kekhawatiran serta kebutuhannya secara terbuka. Ini menciptakan suasana yang mendukung dan positif.
- b. Empati yang Mendalam** Empati adalah kemampuan bidan untuk memahami secara mendalam perasaan dan perspektif klien. Dengan empati, bidan dapat memberikan respons yang tepat dan penuh pengertian terhadap berbagai situasi emosional yang dialami perempuan selama proses kehamilan dan persalinan.
- c. Konsistensi dalam Perawatan** Hubungan yang konsisten dan berkelanjutan memungkinkan bidan mengenal perempuan secara lebih mendalam, memahami preferensi pribadi, serta memberikan dukungan yang lebih tepat dan efektif.
- d. Komunikasi Terbuka dan Jujur** Komunikasi yang terbuka dan transparan adalah kunci untuk membangun hubungan saling percaya. Perempuan perlu merasa bahwa mereka dapat berbicara dengan jujur tentang kekhawatiran mereka tanpa takut dihakimi atau disalahpahami.

2. Strategi Membangun Hubungan yang Kuat

- a. Pendekatan Personal dan Individual** Setiap perempuan memiliki kebutuhan unik dan berbeda. Bidan perlu mengenal perempuan secara pribadi dan menyesuaikan pendekatan berdasarkan preferensi, kebutuhan emosional, budaya, serta latar belakang sosialnya.

- b. **Ketersediaan dan Responsif** Menunjukkan ketersediaan untuk mendengarkan dan merespons pertanyaan atau kekhawatiran perempuan secara cepat dan efektif membangun rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan tersebut.
- c. **Membangun Kepercayaan Melalui Transparansi** Transparansi dalam memberikan informasi terkait pilihan perawatan, prosedur medis, serta kemungkinan risiko dan manfaat, membantu perempuan merasa terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan rasa percaya terhadap bidan.
- d. **Memberikan Dukungan Emosional** Dukungan emosional yang kuat dari bidan, berupa kata-kata yang menguatkan, perhatian, dan kehadiran fisik saat dibutuhkan, membantu perempuan merasa didukung secara penuh sepanjang proses kehamilan dan persalinan.

3. Dampak Positif Hubungan yang Kuat dalam Praktik Kebidanan

- a. **Peningkatan Kepuasan Klien** Hubungan yang baik secara langsung meningkatkan tingkat kepuasan perempuan terhadap layanan kebidanan yang diterimanya.
- b. **Pengalaman Melahirkan yang Lebih Positif** Perempuan yang merasa didukung secara emosional dan psikologis memiliki pengalaman melahirkan yang lebih positif dan bermakna.
- c. **Hasil Kesehatan yang Lebih Baik** Hubungan interpersonal yang kuat terkait dengan peningkatan hasil kesehatan, termasuk pengurangan tingkat stres, kecemasan, dan komplikasi selama kehamilan dan persalinan.
- d. **Meningkatkan Kepercayaan Diri Perempuan** Hubungan yang baik membantu perempuan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan selama kehamilan dan proses persalinan, yang berkontribusi pada pemberdayaan mereka.

4. Tantangan dalam Membangun Hubungan yang Efektif

- a. **Keterbatasan Waktu** Dalam praktik klinis yang sibuk, waktu sering kali terbatas, yang dapat menjadi tantangan dalam membangun hubungan yang mendalam dan berkelanjutan.
- b. **Perbedaan Budaya dan Bahasa** Perbedaan budaya dan bahasa bisa menjadi hambatan dalam komunikasi dan pemahaman yang efektif, membutuhkan upaya ekstra dari bidan untuk mengatasi tantangan ini.
- c. **Sikap Profesionalisme yang Salah Diartikan** Menjaga keseimbangan antara profesionalisme dan pendekatan yang hangat serta personal sering kali menjadi tantangan tersendiri.

F. Aktualisasi Diri

Aktualisasi diri dalam kebidanan sosial adalah sebuah proses di mana perempuan secara aktif mengenali, menerima, dan mengembangkan kemampuan serta kekuatannya selama masa kehamilan dan proses persalinan. Proses ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan secara individu, tetapi juga memberikan dampak positif secara luas, termasuk meningkatkan kualitas hubungan interpersonal, kesejahteraan emosional, dan kesiapan mental menghadapi tantangan selama kehamilan dan persalinan.

1. Peran Bidan dalam Mendukung Aktualisasi Diri

- a. Fasilitator dalam Pengambilan Keputusan** Bidan bertugas untuk memberikan informasi yang akurat dan mendalam, sehingga perempuan mampu membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi, keyakinan, dan harapannya. Dengan demikian, perempuan merasa berdaya dan memiliki kendali penuh atas proses kehamilan dan persalinan mereka.
- b. Pemberi Dukungan Emosional** Dukungan emosional yang tulus dan berkelanjutan membantu perempuan mengelola kecemasan, ketakutan, dan tantangan emosional lainnya selama kehamilan dan persalinan. Dukungan ini memperkuat kepercayaan diri dan keyakinan perempuan dalam menghadapi proses kelahiran.
- c. Mendorong Kesadaran dan Kepercayaan Diri** Melalui komunikasi positif dan penguatan, bidan membantu perempuan menyadari potensi dan kekuatannya dalam menjalani kehamilan dan persalinan. Hal ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri yang kuat.
- d. Memfasilitasi Pengalaman Positif dalam Melahirkan** Bidan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, aman, dan nyaman sehingga perempuan mampu menjalani proses persalinan dengan rasa percaya diri dan kepuasan yang tinggi.

2. Proses Aktualisasi Diri dalam Kebidanan Sosial

- a. Mengenali Potensi Diri** Perempuan diajak untuk mengenali kemampuan alami dan kekuatannya sendiri, seperti kemampuan fisik, emosional, dan mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan.
- b. Mengambil Keputusan yang Mandiri** Perempuan didorong untuk mengambil keputusan yang mencerminkan nilai pribadi, kepercayaan, dan preferensi mereka, menciptakan rasa berdaya yang kuat.
- c. Pengalaman Kelahiran sebagai Proses Transformasional** Persalinan dipandang sebagai peristiwa yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga transformasional secara personal dan emosional, memberikan makna yang mendalam bagi perempuan.

d. Refleksi dan Pembelajaran dari Pengalaman Setelah proses kelahiran, perempuan didukung untuk melakukan refleksi mengenai pengalaman yang telah dilalui, membantu mereka mengambil pelajaran dan memperkuat rasa percaya diri serta kebanggaan terhadap pencapaian mereka.

3. Manfaat Aktualisasi Diri dalam Praktik Kebidanan

a. Peningkatan Kepercayaan Diri Perempuan yang berhasil mencapai aktualisasi diri melalui proses kehamilan dan persalinan memiliki kepercayaan diri yang lebih kuat dalam menjalani perannya sebagai ibu.

b. Peningkatan Kesejahteraan Emosional dan Mental Proses aktualisasi diri membantu perempuan merasa lebih puas, bahagia, dan terpenuhi secara emosional, mengurangi risiko depresi pascapersalinan.

c. Pengalaman Kelahiran yang Lebih Positif dan Memuaskan Dengan dukungan penuh dari bidan, perempuan menjalani pengalaman persalinan yang lebih positif, memberdayakan, dan memuaskan secara emosional.

d. Dampak Positif pada Hubungan Keluarga Aktualisasi diri membantu perempuan memiliki hubungan yang lebih baik dan kuat dengan pasangan dan keluarga karena merasa didukung, dihargai, dan berdaya.

4. Tantangan dalam Mengimplementasikan Aktualisasi Diri

a. Keterbatasan Pemahaman terhadap Konsep Aktualisasi Diri Tidak semua perempuan atau tenaga kesehatan memahami sepenuhnya pentingnya aktualisasi diri dalam proses kelahiran.

b. Lingkungan yang Tidak Mendukung Lingkungan klinis atau sosial yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan besar dalam proses aktualisasi diri perempuan selama kehamilan dan persalinan.

c. Hambatan Budaya dan Sosial Beberapa perempuan mungkin mengalami hambatan budaya atau sosial yang membatasi peran aktif mereka dalam pengambilan keputusan terkait kehamilan dan persalinannya.

G. Latihan Soal

Kasus 1

Seorang ibu hamil usia 28 tahun berasal dari latar belakang budaya yang sangat menghargai ritual khusus dalam proses melahirkan. Ia berharap bidan dapat menghormati praktik budaya tersebut selama proses persalinan. Sikap bidan yang paling tepat sesuai social model adalah:

- A. Menjelaskan bahwa praktik medis lebih aman dan efisien
- B. Menyarankan ibu untuk menyesuaikan diri dengan praktik umum rumah sakit
- C. Mengakomodasi praktik budaya selama tidak membahayakan ibu dan bayi
- D. Mengabaikan praktik budaya demi alasan medis

E. Menyarankan praktik budaya di rumah saja tanpa pengawasan medis

Jawaban: C

Pembahasan: Social model mengutamakan penghormatan terhadap keberagaman budaya, sehingga praktik budaya harus dihormati dan diakomodasi selama tidak membahayakan ibu maupun bayi.

Kasus 2

Ibu hamil berusia 35 tahun menyampaikan ketakutannya terhadap proses persalinan. Bidan ingin membantu ibu ini dengan cara yang paling efektif berdasarkan prinsip social model. Tindakan bidan yang tepat adalah:

- A. Menyediakan ruang terbuka dan aman untuk berdiskusi
- B. Memfokuskan intervensi medis agar ibu tenang
- C. Mengurangi komunikasi untuk menghindari kecemasan lebih lanjut
- D. Meminta ibu mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan rumah sakit
- E. Memberikan keputusan tanpa melibatkan ibu untuk menghindari kebingungan

Jawaban: A

Pembahasan: Social model menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan empatik untuk membangun kepercayaan, mengurangi kecemasan, dan memastikan ibu merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan ketakutannya.

Kasus 3

Seorang ibu merasa lebih nyaman dengan pendekatan alami tanpa intervensi medis selama persalinan. Sikap bidan yang mencerminkan prinsip pemberdayaan dalam social model adalah:

- A. Mengajukan ibu untuk menerima prosedur medis rutin
- B. Menginformasikan secara jujur dan lengkap mengenai risiko dan manfaat berbagai pendekatan
- C. Menolak secara tegas keinginan ibu demi keselamatan bayi
- D. Mengabaikan preferensi ibu karena dianggap kurang rasional
- E. Mendorong intervensi medis standar tanpa mempertimbangkan pilihan ibu

Jawaban: B

Pembahasan: Prinsip pemberdayaan menekankan pentingnya memberikan informasi yang jujur dan lengkap agar ibu dapat membuat keputusan yang mandiri dan sesuai dengan preferensinya.

Kasus 4

Seorang ibu yang baru pertama kali melahirkan sangat mempercayai intuisi dan instingnya tentang proses kelahiran yang akan dialaminya. Sikap bidan yang sesuai social model dalam memandang intuisi adalah:

- A. Mengabaikan intuisi karena dianggap kurang ilmiah
- B. Menyuruh ibu untuk tidak terlalu percaya pada perasaan subjektif
- C. Menghormati dan mempertimbangkan intuisi ibu sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan
- D. Mengarahkan ibu sepenuhnya mengikuti panduan medis yang ketat
- E. Membatasi penggunaan intuisi hanya pada situasi darurat

Jawaban: C

Pembahasan: Social model menghormati intuisi perempuan sebagai aspek penting dalam proses kelahiran, membantu bidan dan ibu mengambil keputusan yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan ibu.

Kasus 5

Seorang ibu menyatakan rasa nyaman dan aman ketika bidan menunjukkan sikap yang ramah, empatik, dan selalu hadir saat dibutuhkan. Hubungan interpersonal yang kuat menurut social model dapat memberikan dampak berikut, kecuali:

- A. Mengurangi stres dan kecemasan ibu
- B. Meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi bidan
- C. Menciptakan pengalaman kelahiran yang lebih positif
- D. Mengurangi peran aktif ibu dalam pengambilan keputusan
- E. Meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam menghadapi persalinan

Jawaban: D

Pembahasan: Hubungan interpersonal yang kuat justru meningkatkan peran aktif ibu dalam pengambilan keputusan, bukan menguranginya, karena social model mengedepankan pemberdayaan dan partisipasi aktif perempuan dalam proses kehamilan dan persalinan.

H. Rangkuman materi

Social model dalam praktik kebidanan memandang kehamilan dan persalinan sebagai proses alami, sosial, dan personal, bukan sekadar kondisi medis yang memerlukan intervensi teknologi tinggi. Setiap perempuan dihargai sebagai individu unik yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, sosial, emosional, dan spiritualnya. Dalam pendekatan ini, perempuan ditempatkan sebagai subjek utama yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai proses kehamilan dan

persalinannya, dengan dukungan penuh dari keluarga, komunitas, serta bidan yang mendampingi.

Social model secara mendalam menghormati keberagaman perempuan, baik dari sisi budaya, agama, nilai individu, maupun kebutuhan emosional. Bidan yang menggunakan pendekatan ini wajib bersikap empatik, fleksibel, serta mampu mengadaptasi pelayanan yang diberikan sesuai preferensi perempuan yang dilayaninya. Dalam praktiknya, menghormati perbedaan diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka, ramah, penuh empati, serta dengan memberikan informasi personal yang relevan, sesuai dengan latar belakang perempuan tersebut. Dukungan dari keluarga dan komunitas juga menjadi bagian integral dalam memastikan perempuan merasa nyaman dan didukung selama proses kehamilan dan persalinan.

Kepercayaan adalah elemen inti dalam social model, karena tanpa adanya kepercayaan yang kuat antara bidan dan perempuan, proses pelayanan kebidanan tidak berjalan optimal. Kepercayaan dibangun melalui sikap empati, transparansi informasi, konsistensi dalam pelayanan, serta penghormatan terhadap keputusan perempuan. Hal ini menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan terbuka, sehingga perempuan merasa lebih percaya diri dan berani menyampaikan kekhawatiran serta harapan mereka secara jujur.

Penggunaan intuisi dalam social model juga sangat dihargai. Intuisi dianggap sebagai kemampuan alami bidan maupun perempuan untuk mengenali kebutuhan fisik dan emosional selama proses persalinan, tanpa melalui proses analitis yang panjang. Bidan didorong untuk mengembangkan intuisi melalui peningkatan kesadaran diri, empati yang mendalam, refleksi rutin atas pengalaman klinis, serta hubungan interpersonal yang erat dengan perempuan hamil. Pemanfaatan intuisi yang efektif ini membantu menciptakan pengalaman melahirkan yang positif, mengurangi intervensi medis yang tidak perlu, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan diri perempuan.

Hubungan interpersonal yang hangat, ramah, dan empatik antara bidan dan perempuan juga menjadi karakteristik utama dalam social model. Hubungan ini memberikan dukungan emosional dan psikologis yang penting dalam proses kehamilan dan persalinan, menciptakan pengalaman yang lebih positif, dan mengurangi stres serta kecemasan. Hubungan tersebut dibangun melalui komunikasi terbuka dan jujur, sikap responsif dan tersedia, serta pemberian dukungan emosional secara konsisten.

Social model juga mendorong aktualisasi diri perempuan selama kehamilan dan persalinan. Aktualisasi diri merupakan proses di mana perempuan secara aktif mengenali, menerima, dan mengembangkan potensinya secara penuh, sehingga

merasa lebih percaya diri, puas, dan berdaya dalam menghadapi proses persalinan. Bidan berperan sebagai fasilitator dalam memberikan informasi mendalam dan dukungan emosional yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, perempuan menjalani pengalaman kelahiran sebagai peristiwa transformasional yang bermakna, memperkuat kesejahteraan emosional serta hubungan interpersonal dengan keluarga dan komunitas.

Meskipun banyak manfaatnya, penerapan social model juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan waktu dalam praktik klinis, hambatan budaya dan bahasa, kurangnya pemahaman mengenai aktualisasi diri, serta lingkungan sosial atau klinis yang kurang mendukung. Namun, ketika berhasil diterapkan, social model memberikan pengalaman kehamilan dan persalinan yang memberdayakan, positif, dan bermakna secara mendalam bagi perempuan.

I. Glosarium

Aktualisasi Diri

Proses pengembangan dan realisasi potensi penuh seseorang selama pengalaman kehamilan dan persalinan, memungkinkan perempuan merasa berdaya, percaya diri, dan mampu mengatasi tantangan secara efektif.

Empati

Kemampuan untuk memahami secara mendalam perasaan, pikiran, dan perspektif perempuan hamil, memungkinkan bidan memberikan dukungan emosional yang tepat dan efektif.

Hubungan Interpersonal

Interaksi sosial yang kuat, hangat, empatik, dan saling percaya antara bidan dan klien, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kepuasan dan hasil positif dalam praktik kebidanan.

Intuisi

Kemampuan alami atau insting yang memungkinkan seseorang untuk memahami situasi atau kebutuhan secara langsung tanpa proses analitis yang panjang. Dalam kebidanan, intuisi digunakan untuk mengenali kebutuhan fisik dan emosional perempuan secara cepat dan tepat.

Komunikasi Empatik

Teknik komunikasi yang melibatkan pendengaran aktif, pemahaman mendalam terhadap perasaan klien, dan penyampaian informasi secara terbuka serta penuh perhatian untuk mendukung perempuan dalam membuat keputusan mandiri.

Medical Model

Pendekatan yang lebih menekankan pada aspek klinis, patologi, intervensi medis, dan penggunaan teknologi tinggi dalam proses kehamilan dan persalinan, sering kali menempatkan perempuan dalam posisi penerima pasif.

Pemberdayaan Perempuan

Proses meningkatkan kepercayaan diri, kesadaran hak-hak, serta kemampuan perempuan untuk membuat keputusan secara mandiri dalam konteks kehamilan dan persalinan melalui edukasi, dukungan emosional, dan pendampingan secara kontinu.

Pendekatan Holistik

Cara pandang yang memandang kehamilan dan persalinan secara menyeluruh, tidak hanya secara medis tetapi juga mempertimbangkan aspek emosional, sosial, budaya, dan spiritual perempuan.

Pengambilan Keputusan Mandiri

Proses di mana perempuan diberdayakan untuk membuat keputusan tentang perawatan kehamilan dan persalinannya berdasarkan informasi yang akurat, lengkap, dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi serta preferensinya.

Social Model

Pendekatan dalam praktik kebidanan yang menempatkan perempuan sebagai pusat perhatian, menganggap kehamilan dan persalinan sebagai proses alami, sosial, dan personal, serta menghargai perbedaan budaya, agama, dan nilai-nilai individu secara mendalam.

Transparansi

Praktik penyampaian informasi yang jelas, jujur, dan akurat mengenai kondisi kesehatan dan berbagai pilihan perawatan kepada perempuan, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan serta memberdayakan perempuan dalam pengambilan keputusan.

J. Daftar Pustaka

- Bryers, H. M., & van Teijlingen, E. (2010). Risk, safety, and trust in childbirth: Midwifery narratives. *Social Science & Medicine*, 70(4), 500-507. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.10.034>
- Fahy, K., Foureur, M., & Hastie, C. (Eds.). (2008). *Birth Territory and Midwifery Guardianship: Theory for Practice, Education, and Research*. Butterworth-Heinemann Elsevier.
- Kitzinger, S. (2011). *Rediscovering Birth*. Pinter & Martin Publishers.
- Leap, N., & Hunter, B. (2016). *Supporting Women for Labour and Birth: A Thoughtful Guide*. Routledge.

- Macdonald, S., & Magill-Cuerden, J. (Eds.). (2017). *Mayes' Midwifery* (15th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Mander, R., & Murphy-Lawless, J. (Eds.). (2013). *The Politics of Maternity*. Routledge.
- McCourt, C. (Ed.). (2009). *Childbirth, Midwifery, and Concepts of Time*. Berghahn Books.
- Pairman, S., Tracy, S., Dahlen, H., & Dixon, L. (2018). *Midwifery: Preparation for Practice* (4th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Walsh, D. (2012). *Evidence-based Care for Normal Labour and Birth: A Guide for Midwives*. Routledge.
- World Health Organization. (2018). *WHO Recommendations: Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/>

BAB 5

PARTNERSHIP

Pendahuluan

Perempuan merupakan makhluk Bio-Psiko-Sosial-Kultural dan Spritual yang utuh dan unik, serta mempunyai dasar yang bermacam-macam berdasarkan tingkat perkembangannya. Setiap perempuan memiliki pribadi yang mempunyai hak, kebutuhan dan harapan.

Perempuan juga mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatannya dan keluarganya melalui pendidikan dan konseling dalam mengambil keputusan. Selain itu juga perempuan juga mempunyai hak dalam memilih dan memutuskan siapa yang dapat memberikan asuhan dan pelayanan untuk mendapatkan pendidikan dan informasi dalam menjalankan tugasnya.

Seorang bidan dalam hal ini mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, kepada masyarakat khususnya bagi perempuan. Bidan diakui sebagai tenaga kesehatan yang profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk mendukung, memberikan asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir. Asuhan ini mencakup pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis dan bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan.

Dalam pelayanan kebidanan mempunyai khusus yaitu pelayanan kebidanan dengan penerapan ilmu kebidanan yaitu memberikan asuhan kebidanan pada klien yang menjadi tanggung jawab bidan mulai dari kehamilan sampai dengan keluarga berencana (KB) termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2014 pertama kali dikenalkan aplikasi pelayanan dasar yang digunakan sebagai alat bantu untuk mengimput dan mengalihkan pelayanan BPJS Kesehatan non kapitasi pada Faskes tingkat satu yaitu *Primary Care*. *Primary Care* merupakan aplikasi pelayanan dasar berbasis web (Web Base) dibangun untuk mendukung bisnis dalam proses pelayanan program BPJS kesehatan.

Tujuan Instruksional:

Mampu memahami Pengantar Praktik Kebidanan tentang *Partnership* yaitu:

- Memahami tentang *Primary Care*
- Memahami tentang *Women Centered Care*
- Memahami tentang *Empowering*
- Memahami tentang *Trust*

Capaian Pembelajaran:

Mampu menjelaskan Pengantar Praktik kebidanan tentang *Partnership* yaitu:

- Mampu menjelaskan tentang *Primary Care*
- Mampu menjelaskan tentang *Women Centered Care*
- Mampu Menjelaskan tentang *Empowering*
- Mampu menjelaskan tentang *Trust*

Uraian Materi

A. *Primary Care*

1. Pengertian *Primary care*

Primary care (Pelayanan Utama) merupakan pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan pada metode dan teknologi praktis, ilmiah dan sosial yang dapat diterima secara umum baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat melalui partisipasi mereka sepenuhnya, serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam semangat untuk hidup mandiri dan menentukan nasib sendiri.

Istilah *primary care* atau perawatan primer telah dikenalkan sejak 1961. Beberapa orang mendefinisikan perawatan primer kedalam beberapa kategori. Menurut IOM tahun 1978, perawatan primer mengacu pada penyediaan layanan perawatan kesehatan terpadu dan mudah diakses oleh dokter yang bertanggung jawab untuk menangani sebagian besar kebutuhan perawatan kesehatan pribadi, mengembangkan kemitraan berkelanjutan dengan pasien, dan memberikan pelayanan dalam konteks keluarga maupun masyarakat.

Pada tahun 1978, *World Health Organization* (WHO) and *United Nations International Children's Emergency Fund* bersama-sama merumuskan definisi dari perawatan primer yakni level pertama terjadinya kontak antara individu, keluarga, dan masyarakat dengan sistem kesehatan nasional yang menyediakan perawatan kesehatan sedekat mungkin dengan tempat tinggal dan tempat bekerja, dan merupakan elemen pertama dari proses perawatan kesehatan yang berkelanjutan. Perawatan primer menangani masalah kesehatan utama di masyarakat, menyediakan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang sesuai. Perawatan primer bergantung pada level merujuk pada tingkat pelayanan yang berbeda, petugas kesehatan termasuk didalamnya adalah dokter, perawat, bidan, pembantu dan pekerja masyarakat, serta praktisi tradisional sebagaimana diperlukan, yang terlatih secara sosial dan teknis untuk bekerja sebagai tim kesehatan dan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang diinginkan.

Menurut *Pew Health Professions Commission* tahun 1994, perawatan primer diartikan sebagai bentuk perawatan yang disediakan oleh klinisi, diantaranya oleh kedokteran keluarga, dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter obstetri dan ginekologi, serta kelompok praktisi dari perawat, bidan dan asisten dokter. Perawatan primer merupakan seperangkat kegiatan atau aktivitas yang bertujuan menyembuhkan atau meringankan penyakit umum dan disabilitas yang

dilaksanakan di pusat medis yang mudah diakses, komprehensif, terkoordinasi, berkelanjutan, dan akuntabel.

Perawatan primer yang komprehensif adalah perawatan yang diberikan pada seseorang terhadap masalah kesehatan apapun pada tahap tertentu. Masalah pasien didasarkan atas kebutuhan individu tertentu, keselamatan, atau pertimbangan efisiensi. Masalah yang timbul ini tidak semua dapat dikelola oleh klinis di layanan perawatan primer, sebagian mungkin memerlukan keahlian profesional kesehatan lain seperti spesialis lain, atau subspesialis. Perawatan primer sangat penting dalam sistem kesehatan karena berfungsi sebagai pintu pertama dalam akses layanan kesehatan.

Perawatan primer dalam kebidanan adalah perawatan kesehatan dasar yang diberikan oleh bidan atau tenaga kesehatan lainnya yang berfokus pada kesehatan reproduksi perempuan, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan dan perawatan dasar selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Perawatan primer kebidanan berperan penting dalam mendeteksi dini risiko, memberikan edukasi, dan membantu menjaga kesehatan ibu dan bayi.

2. Komponen *Primary care*

Tiga komponen penting dalam perawatan primer meliputi:

- a. Pasien dan keluarga
- b. Masyarakat
- c. Sistem pemberian layanan terpadu.

3. Manfaat *Primary care*

Perawatan primer memiliki nilai kebermanfaatan bagi individu, terutama dalam hal-hal berikut:

- a. Menyediakan tempat bagi pasien untuk menyampaikan berbagai masalah kesehatan guna mendapatkan perhatian yang tepat dengan berharap masalah mereka akan teratasi tanpa rujukan.
- b. Memandu pasien melalui sistem kesehatan, termasuk rujukan yang tepat untuk layanan dari profesional kesehatan lainnya.
- c. Memfasilitasi hubungan yang berkelanjutan antara pasien dan dokter serta mendorong partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan tentang kesehatan dan perawatan mereka sendiri.
- d. Berpeluang dalam hal pencegahan penyakit dan promosi kesehatan serta deteksi dini masalah.
- e. Membantu membangun jembatan antara layanan perawatan kesehatan pribadi dan keluarga serta komunitas yang dapat membantu memenuhi kebutuhan kesehatan pasien.

Perawatan primer merupakan bentuk perawatan kesehatan dasar yang berfokus pada pencegahan, diagnosis awal, dan penanganan masalah kesehatan umum dengan ciri-ciri utama sebagai berikut:

- a. Perawatan primer haruslah mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa batasan yang signifikan, baik secara geografis maupun ekonomi.
- b. Perawatan primer mencakup layanan kesehatan umum yang melibatkan pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan perawatan berkelanjutan.
- c. Perawatan primer tidak hanya berfokus pada individu, namun juga mempertimbangkan kondisi kesehatan keluarga dan komunitas.
- d. Perawatan primer lebih mengutamakan upaya pencegahan penyakit, misalnya dengan imunisasi, edukasi kesehatan, skrining dini, dan gaya hidup sehat.
- e. Pasien biasanya memiliki hubungan jangka panjang dengan tenaga medis, seperti dokter keluarga atau perawat atau bidan, yang dapat memberikan pelayanan berkelanjutan.
- f. Perawatan primer berfungsi sebagai pusat koordinasi yang menghubungkan pasien dengan layanan kesehatan lainnya, seperti spesialis atau rumah sakit, jika diperlukan.
- g. Perawatan yang diberikan berkelanjutan dan tidak terbatas pada waktu tertentu, memungkinkan pemantauan dan manajemen kondisi pasien dalam jangka panjang.

B. *Women Centered Care*

1. Pengertian *Women Centered Care*

Women Centered Care adalah Asuhan yang berorientasi pada wanita. Perawatan yang berpusat pada wanita difokuskan pada kebutuhan individu wanita itu sendiri, bukan pada kebutuhan bidan ataupun institusi terkait. Dalam Hal ini Bidan difokuskan memberikan dukungan pada wanita dalam upaya memperoleh status yang sama di masyarakat untuk memilih dan memutuskan perawatan kesehatan dirinya. *Women Centered Care* adalah proses kemitraan, saling ketergantungan, dan saling keterhubungan antara wanita dengan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kebidanan.

Women Centered Care adalah istilah yang digunakan untuk filosofi asuhan maternitas yang memberi prioritas pada keinginan dan kebutuhan pengguna, dan menekankan pentingnya *informed choice*, kontinuitas perawatan, keterlibatan pengguna, efektivitas klinis, respon dan akseibilitas. *Women Centered Care* memberikan cita-cita filosofis bagi bidan yang berpraktik, apa pun model perawatan atau model praktiknya, dan telah menjadi dasar dalam mendefinisikan standar praktik dan ruang lingkup bidan. Istilah "woman centered" menunjukkan

bahwa wanita hamil melakukan perawatan yang berpusat pada dirinya. Sedangkan "*care*" memiliki bentuk aktif dan pasif, dimana seseorang dapat merawat orang lain, dan di sisi lain seseorang dapat dirawat orang lain. Berkaitan dengan "*care*", bidan bertindak sebagai bentuk aktif, sedangkan wanita dan anak bertindak sebagai pasif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh suatu badan yaitu *House of Commons Health Committee* tahun 1992, disimpulkan bahwa terdapat permintaan yang meluas pada kaum wanita untuk memiliki pilihan yang lebih besar dalam menentukan jenis asuhan maternitas yang mereka dapatkan dan bahwa struktur pelayanan maternitas saat ini membuat mereka frustrasi bukan memfasilitasi mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya asuhan yang berorientasi pada wanita dimana mereka punya peran dalam menentukan pilihan sehingga terpenihi kebutuhannya dan timbul kepuasan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Asuhan yang berorientasi pada wanita atau *Women Centered Care* amat penting untuk kemajuan Praktik kebidanan.

Women centred care ini sangat sesuai dengan keinginan ICM (*International Confederation Of Midwifery*) yang tertuang dalam visi-nya, yaitu:

- a. Bidan memberikan asuhan pada wanita yang membutuhkan asuhan kebidanan.
- b. Bidan mempunyai otonomi sebagai pemberi asuhan yang menghargai kerjasama team dalam memberikan asuhan untuk seluruh kebutuhan wanita dan keluarga.
- c. Bidan memegang kunci dalam menentukan asuhan di masa mendatang termasuk pelayanan kesehatan utama pada komunitas untuk seluruh wanita dan keluarga.

Women Centered Care harus melibatkan hubungan baik antara wanita dan bidan dalam pemberian perawatan. Hubungan tersebut berfungsi sebagai peluang untuk membangun hubungan jangka panjang antara perempuan dan penyedia layanan kesehatan; memungkinkan pemberian perawatan sesuai kebutuhan; menghormati hak perempuan untuk mengambil keputusan terkait perawatan mereka dan mendukung otonomi mereka dalam membuat pilihan atau keputusan yang mereka anggap terbaik; memahami dan menghormati latar belakang budaya, nilai-nilai pribadi, dan keyakinan perempuan, serta menyediakan perawatan yang sensitif dan responsif terhadap aspek-aspek tersebut; menawarkan peluang untuk menetapkan batasan bagi wanita dan bidan serta untuk mengenali kendala yang dapat memengaruhi tanggung jawab mereka.

Dalam memberikan asuhan yang baik terhadap wanita, bidan harus menerapkan hal-hal berikut ini:

- a. Melakukan intervensi minimal
- b. Memberikan asuhan yang sesuai kebutuhan Melakukan segala tindakan sesuai dengan standar, wewenang dan kompetensi
- c. Memberikan inform konsen
- d. Memberikan asuhan yang nyaman, aman, logis dan berkualitas
- e. Menerapkan asuhan sayang ibu.

Asuhan sayang ibu adalah pendekatan dalam pelayanan kesehatan yang berfokus pada pemberian perawatan holistik dan berempati bagi ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.

2. Tujuan

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, serta memberikan pengalaman perawatan yang lebih aman dan menyenangkan.

3. Prinsi *Women Centred Care*

Prinsip utama asuhan sayang ibu meliputi:

- a. Asuhan yang berorientasi pada kebutuhan ibu dengan saling menghargai budaya dan kepercayaan dari keinginan sang ibu pada asuhan yang aman.
- b. Asuhan yang tidak menimbulkan penderitaan bagi ibu.
- c. Ibu mempunyai otonomi dalam setiap pengambilan keputusan, baik yang melibatkan ibu saja atau melibatkan keluarga sebagai pembuat keputusan dan tidak emosional.
- d. Asuhan yang mendukung pemberdayaan ibu dan keluarga dalam rangka menurunkan angka kematian maternal dan neonatal.

4. Bentuk *Women Centered Care*

Pelayanan terpusat pada ibu dengan sifat holistic (Menyeluruh) dalam kebutuhan dan ekspektasi, sosial, emosional, fisik, psikologis, spritual, dan kebudayaan ibu. Bentuk dar women centered cer di Indonesia merupakan program untuk menurunkan angka kematian ibu yang menunjukkan pada program seduniayang didukung oleh WHO yaitu:

- a. *Safe Motherhood*
- b. *The mother friendly Movement* tahun 1996 yang diterjemah sebagai Gerakan Sayang Ibu (GSI)
- c. *Live Saving Skill*
- d. Komunikasi Interpersonal dan konseling
- e. Asuhan Persalinan Dasar (APD) yang kemudian berkembang menjadi Asuhan Persalinan Normal (APN) Tahun 2000
- f. *Making Pregnancy Safer* (MPS) Tahun 2000
- g. IBI mengeluarkan standar asuhan kebidanan dan usulan peningkatan pendidikan Kebidanan dari D1,D3,D4, S1 S2

5. Sasaran pelayanan *Women Centered Care*

Yang menjadi sasaran pelayanan kebidanan adalah masyarakat khususnya perempuan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

a. Upaya promotif

- 1) Meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat
- 2) Meningkatkan proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih,
- 3) Melakukan upaya penyuluhan kesehatan baik dengan menggunakan media maupun langsung kepada masyarakat

b. Upaya Preventif

- 4) Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
- 5) Melakukan kunjungan antenatal secara rutin
- 6) Mengonsumsi makanan gizi seimbang
- 7) Meningkatkan cakupan imunisasi dasar
- 8) Meningkatkan pertolongan yang aman, dan bersih
- 9) Meningkatkan pemberian ASI eksklusif

c. Upaya kuratif

- 1) Meningkatkan sistem rujukan dan kolaborasi yang berkesinambungan
- 2) melakukan pengobatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab

d. Upaya Rehabilitatif

- 1) Pasien penderita lumpuh melakukan rehabilitasi dengan mengikuti fisioterapi
- 2) Pasien pasca operasi gangguan reproduksi (Kanker rahim, kista, dll)

C. *Empowering*

1. Pengertian *Empowering*

Empowering atau pemberdayaan adalah suatu proses pemberian kekuatan dan kekuasaan melalui pendekatan bidan dalam memberikan dukungan. Pemberdayaan dianggap melibatkan perubahan dalam hubungan kekuasaan antara pasien atau orang dan tenaga kesehatan. Hal ini dapat dipahami sebagai pendekatan hak asasi manusia atau keadilan sosial terhadap pemberdayaan. Pemberdayaan sebagai proses sosial dalam mengenali, mempromosikan, dan meningkatkan kemampuan orang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, memecahkan masalah mereka, dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan agar mereka mampu mengendalikan hidup mereka. Secara sederhana,

pemberdayaan merupakan proses membantu orang untuk menegaskan kendali atas faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mereka.

Gagasan pemberdayaan berawal dari ideologi aksi sosial tahun 1960-an dan konsep pemberdayaan mulai dikenalkan pada tahun 1981 dalam upaya untuk memberi energi dan memengaruhi kebijakan kesehatan mental. Pemberdayaan adalah konsep pengembangan yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan dan potensi individu, keluarga, dan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kode etik bidan yang dipaparkan oleh ICM tahun 1993 dimana 'Bidan bekerja dengan perempuan, mendukung hak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam keputusan tentang perawatan mereka dan memberdayakan perempuan untuk mengenali sendiri tentang masalah yang memengaruhi kesehatan mereka dan keluarga di masyarakat. Berdasarkan kode Etik Bidan menurut ICM, pemberdayaan ditempatkan sebagai salah satu prinsip utama, yang bertujuan agar bidan dapat membantu wanita untuk membuat keputusan sendiri terkait kesehatan reproduksi dan kehamilan.

2. Prinsip *Empowering*

Dalam hal pemberdayaan, terdapat prinsip-prinsip yang dikembangkan dengan tujuan kesejahteraan. Prinsip tersebut diantaranya:

a. *Respect for culture* atau penghargaan terhadap budaya

Penghargaan terhadap budaya berarti menghormati dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan keyakinan pribadi setiap individu, terutama dalam praktik kebidanan. Penghargaan terhadap budaya ini adalah prinsip penting karena mempengaruhi cara seorang wanita dan keluarganya memandang kesehatan, kehamilan, persalinan, dan perawatan anak. Dalam hal penghargaan budaya, bidan mengakui bahwa setiap wanita berasal dari latar belakang budaya yang unik yang mungkin memengaruhi preferensi dan harapannya dalam perawatan kesehatan. Menghargai keunikan ini berarti tidak mengabaikan atau menghakimi praktik-praktik budaya tersebut, tetapi memandangnya sebagai bagian penting dari identitas wanita.

b. Program yang ada memiliki nilai kepekaan terhadap budaya dan konteks lokal masyarakat

Program pemberdayaan disesuaikan dengan nilai dan keyakinan masyarakat setempat, sehingga mereka relevan dan dapat diterima secara budaya. Ini bisa mencakup bagaimana masyarakat memandang kesehatan, kehamilan, dan praktik-praktik tradisional. Dengan cara ini, masyarakat merasa program tersebut sejalan dengan norma dan adat yang sudah ada, dan lebih mudah untuk berpartisipasi secara aktif.

c. Adanya rasa kebersamaan dan ikatan lokal

Rasa kebersamaan dan ikatan lokal akan menumbuhkan ikatan sosial dan rasa kebersamaan di dalam komunitas, sehingga anggotanya saling mendukung dalam mencapai tujuan kesehatan yang lebih baik. Hal ini begitu penting karena rasa saling memiliki dan dukungan antarwarga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan positif, peningkatan kesejahteraan, dan keberlanjutan program kesehatan. Contoh nyata yang dapat dilihat adalah terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman individu yang dapat dengan mudah dibagikan pada komunitas, sehingga memperluas pemahaman dan keterampilan masyarakat terkait kesehatan. Contohnya, seorang ibu yang telah mengikuti pelatihan tentang perawatan bayi dapat membagikan informasi ini kepada tetangganya, membantu menyebarkan kesadaran kesehatan dalam hal perawatan bayi.

- d. Adanya peningkatan keterampilan masyarakat dan kontrol atas sumber daya
Peningkatan keterampilan dalam pemberdayaan kesehatan berarti memberikan pengetahuan, keterampilan, dan akses kepada sumber daya yang memungkinkan individu dan komunitas untuk mengelola kesehatan mereka secara mandiri dan efektif. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami cara meningkatkan kesehatan, tetapi juga memiliki kapasitas dan kendali untuk mengambil tindakan dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pengembangan kemampuan advokasi dan kepemimpinan
Pemberdayaan kesehatan bertujuan untuk membangun keterampilan kepemimpinan dan advokasi di dalam komunitas agar mereka mampu memperjuangkan akses dan layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan mengembangkan kemampuan advokasi dan kepemimpinan, individu dan kelompok dalam masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan yang mempengaruhi kebijakan dan memimpin inisiatif kesehatan di lingkungan mereka.
- f. Terdapat mekanisme untuk mengatasi hambatan struktural dalam pelaksanaan pemberdayaan.
Mekanisme yang akan dilakukan memberikan kesempatan bagi komunitas dan pemimpin program untuk mengidentifikasi hambatan struktural yang menghalangi pemberdayaan serta faktor pendukung yang dapat membantu pencapaian tujuan kesehatan. Prinsip ini penting dalam pemberdayaan kesehatan karena memungkinkan program lebih responsif dan efektif dalam mengatasi akar permasalahan yang memengaruhi kesehatan masyarakat.
- g. Paham akan kendala yang mendasari kesehatan. Hal ini mencakup pemahaman terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan individu

dan masyarakat, baik yang bersifat sumber fisik (material) maupun yang berkaitan dengan interaksi sosial dan lingkungan.

3. Tingkatan

Terdapat empat tingkatan pemberdayaan berdasarkan keterlibatan aktif seseorang:

a. Berpartisipasi

Pada tingkat ini, individu atau kelompok mulai ikut serta dalam kegiatan, program, atau diskusi tanpa memiliki kendali penuh atas keputusan.

b. Memilih

Di tahap ini, individu atau kelompok sudah mulai memiliki hak untuk memilih di antara beberapa opsi, yang memberikan mereka rasa tanggung jawab dalam keputusan yang diambil.

c. Mendukung

Pada tingkat mendukung, individu atau kelompok tidak hanya berpartisipasi atau memilih, tetapi juga mulai memberikan kontribusi atau sumber daya untuk mendukung keputusan atau program yang telah dipilih.

d. Bernegosiasi

Tingkat tertinggi dalam pemberdayaan ini adalah ketika individu atau kelompok bisa bernegosiasi, memengaruhi keputusan, serta memperjuangkan kepentingan mereka dalam proses pengambilan Keputusan.

D. Trust

Trust atau kepercayaan merupakan kejadian saling percaya yang melibatkan seseorang untuk bertindak laku tertentu karena keyakinan akan seseorang untuk memberikan apa yang ia harapkan sesuai pernyataan yang sudah ia percaya. *Trust* merupakan elemen kunci yang memengaruhi hubungan antara bidan dan klien, serta kualitas layanan yang diberikan. Kepercayaan ini berperan penting dalam mendukung kesehatan fisik dan emosional klien selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Beberapa cara kepercayaan terwujud dalam praktik kebidanan diantaranya:

1. Komunikasi Terbuka

Bidan perlu membangun komunikasi yang jujur, empatik, dan tanpa penghakiman dengan klien. Dengan komunikasi terbuka, klien merasa nyaman berbicara tentang kebutuhan, kekhawatiran, dan harapan mereka, yang merupakan dasar untuk kepercayaan.

2. Memberikan Informasi yang Jelas Informasi yang akurat dan lengkap mengenai kondisi kesehatan, prosedur medis, dan opsi perawatan perlu diberikan secara

transparan. Ini membuat klien merasa dimampukan untuk membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan pengetahuan penuh.

3. Pendekatan Kolaboratif

Bidan yang melibatkan klien dalam pengambilan keputusan memberikan rasa kendali dan menunjukkan bahwa keinginan serta hak klien dihargai. Pendekatan kolaboratif ini juga membantu membangun rasa percaya karena klien merasa menjadi bagian penting dalam proses perawatan.

4. Konsistensi dan Keandalan

Konsistensi dalam tindakan dan tanggung jawab menunjukkan kepada klien bahwa mereka bisa mengandalkan bidan. Keandalan dalam memberikan perawatan yang aman, tepat waktu, dan profesional memperkuat rasa percaya, karena klien yakin bidan akan hadir di saat mereka membutuhkannya.

5. Penghormatan terhadap Privasi dan Otonomi Klien

Menjaga privasi dan menghormati keputusan serta otonomi klien menunjukkan rasa hormat bidan terhadap klien sebagai individu. Penghargaan ini membangun kepercayaan dan rasa aman bagi klien untuk menjalani pengalaman persalinan dengan tenang

E. Latihan

1. Seorang bidan memberikan asuhan yang berorientasi pada perempuan, dalam upaya memperoleh status yang sama dimasyarakat untuk memilih dan memutuskan perawatan sendiri.

Disebut apakah Model pelayanan kebidanan yang diterapkan bidan tersebut?

- A. Gerakan sayang ibu
- B. *Woman centred care*
- C. *Safe motherhood*
- D. *Live saving skill*
- E. *Midwifery care*

2. Seorang Bidan sebagai Pemberi asuhan bertanggung jawab dalam memberikan asuhan yang berkesinambungan sejak hamil, melahirkan dan post partum sesuai kewenangannya.

Termasuk apakah model praktik Bidan berdasarkan kasus diatas?

- A. *Primary Care*
- B. *Continuity Of Care*
- C. *Collaborative Care*
- D. *Partnership*
- E. *Women Center Care*

F. Kunci Jawaban

1. B
2. A

G. Rangkuman Materi

Partnership merupakan layanan kesehatan yang konteksnya mengarah ke model kolaborasi yang penyediaan layanan kesehatannya berfokus pada layanan primer yang akses layanannya muda dan komprehensif pada kebutuhan dasar kesehatan (Primary care), serta memberikan perhatian khusus pada kebutuhan dan preferensi kesehatan wanita (woman centered care), dan mengedepankan pemberdayaan pasien dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan (empowering), serta menjaga hubungan yang didasari rasa saling percaya antara pasien dan tenaga kesehatan (trust).

Pelayanan prima atau sering dikenal dengan excellent service merupakan proses memberi pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan klien serta memberikan fokus pelayanan kepada pasien sebagai upaya meningkatkan kepuasan klien terhadap layanan yang diberikan. Pelayanan prima memberikan dampak positif baik bagi klien maupun bidan dan instansi layanan kesehatan.

Women centered care merupakan model dalam layanan kebidanan yang memposisikan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan untuk mengatasi masalahnya dan penerapannya women centered care memungkinkan adanya keterlibatan pihak-pihak lain yang berpengaruh pada kondisi klien.

H. Glosarium

APD: Asuhan Persalinan Dasar

APN: Asuhan Persalinan Normal

ASI: Air Susu Ibu

GSI: Gerakan Sayang Ibu

IBI: Ikatan Bidan Indonesia

IOM: *Institute of Medicine*

ICM: *International Confederation of Midwife*

MPS: *Making Pregnancy Safer*

UNICEF: *United Nations International Children's Emergency Fund*

WHO: *World Health Organization*

I. Daftar Pustaka

Astuti, E. W. (2016). Konsep Kebidanan dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan.

- Brady, S., Bogossian, F., & Gibbons, K. S. (2024). Defining woman-centred care: A concept analysis. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2024.103954> *Midwifery*, 131.
- Donaldson, M. S., Yordy, K. D., Lohr, K. N., & Vanselow, N. A. (1996). Primary Care America's Health in a New Era. <http://www.nap.edu/catalog/5152.html>
- Fontein-Kuipers, Y., de Groot, R., & van Staa, A. (2018). Woman-centered care 2.0: Bringing the concept into focus. *European Journal of Midwifery*, 2(May). <https://doi.org/10.18332/ejm/91492> concept
- Hermansson, E., & Mårtensson, L. (2011). Empowerment in the midwifery context a analysis. *Midwifery*, <https://doi.org/10.1016/j.midw.2010.08.005> 27(6), 811–816.
- Nagineviciute, M., Bartuseviciene, E., & Blazeviciene, A. (2023). Woman-Centered Care: Standardized Outcomes Measure. *Medicina (Lithuania)*, 59(9). <https://doi.org/10.3390/medicina59091537>
- Nieuwenhuijze, M., & Leahy-Warren, P. (2019). Women's empowerment in pregnancy and childbirth: A concept analysis. In *Midwifery* (Vol. 78, pp. 1–7). Churchill Livingstone. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2019.07.015>
- Phillippi, J. C., & Barger, M. K. (2015). Midwives as Primary Care Providers for Women. *Journal of Midwifery and Women's Health*, 60(3), 250–257. <https://doi.org/10.1111/jmwh.12295>
- Pulvirenti, M., Mcmillan, J., & Lawn, S. (2014). Empowerment, patient centred care and self-management. *Health Expectations*, 17(3), 303–310 <https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2011.00757.x>.

BAB 6

LINGKUP PRAKTIK BIDAN, PARADIGMA KEBIDANAN, REGULASI YANG MENGATUR SERTIFIKASI, LISENSI BIDAN INDONESIA

Pendahuluan:

Bidan memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memastikan bahwa wanita dan keturunannya mendapatkan layanan kebidanan yang baik. Antenatal Care (ANC), Intranatal Care (INC), Postnatal Care (PNC), asuhan Bayi Baru Lahir (BBL), persiapan menjadi orang tua, gangguan kehamilan dan reproduksi, serta Keluarga Berencana (KB) secara mandiri adalah contoh tugas penting bagi bidan dalam konsultasi dan pendidikan kesehatan bagi wanita sebagai pusat keluarga maupun masyarakat umumnya. Bidan juga dapat praktik kebidanan di puskesmas, rumah sakit, klinik bersalin, dan fasilitas kesehatan lokal lainnya. (Anggraini et al., 2021).

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan dan memahami lingkup praktik bidan.
- Menjelaskan dan memahami paradigma dan kompetensi bidan.
- Menjelaskan regulasi yang mengatur sertifikasi, lisensi bidan indonesia

Capaian Pembelajaran:

- Mampu menguasai lingkup praktik bidan
- Mampu menguasai paradigma dan kompetensi bidan
- Mampu menguasai regulasi yang mengatur sertifikasi, lisensi bidan indonesia

Uraian Materi

A. Lingkup Praktik Bidan

Standar kompetensi bidan disusun berdasarkan penyempurnaan dari standar kompetensi bidan dan ruang lingkup praktik kebidanan yang tertuang dalam keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor HK.01.07/ menkes /320/2020 tentang standar propesi bidan dan peraturan menteri kesehatan nomor 28 tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan praktik bidan. pelayanan yang diberikan oleh seorang ibu dan anak melalui praktik asuhan kebidanan.

Sistematika daftar keterampilan klinik disusun berdasarkan lingkup asuhan kebidanan. Ruang lingkup asuhan kebidanan termasuk konseling, penyuluhan, persalinan, melahirkan, nifas, bayi baru lahir, deteksi dini penyakit, pengobatan ginekologi yang terbatas, pertolongan gawat darurat, pengawasan tumbuh kembang, dan pengawasan.

Bidan harus memahami falsafah, kode etik, dan regulasi yang terkait dengan praktis kebidanan untuk memberikan pelayanan yang mutu dan berkesinambungan. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan bahwa dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, Bidan memberikan pelayanan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, serta pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, dan dalam Pasal 47 mengatakan Bidan dapat berperan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, pengelola pelayanan kebidanan, penyuluh dan konselor, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan/atau peneliti dalam penyelenggaraan praktik kebidanan

Pada poin 5 area keterampilan klinis dalam melakukan praktik kebidanan, bidan diharapkan memiliki keterampilan sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk merawat bayi baru lahir (neonatus), kondisi gawat darurat, dan rujukan.
2. Kemampuan untuk memberikan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi, balita, dan anak prasekolah, kondisi gawat darurat, dan rujukan.
3. Kemampuan untuk menyediakan layanan tanggap budaya untuk mendorong kesehatan reproduksi remaja perempuan.
4. Memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan tanggap budaya yang membantu menjaga kesehatan reproduksi wanita pada masa sebelum kehamilan
5. Memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan ANC yang menyeluruh untuk memaksimalkan kesehatan ibu hamil dan janin, serta untuk memberikan asuhan kegawatdaruratan dan rujukan

6. Kemampuan untuk memberikan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada ibu hamil, kondisi gawat darurat, dan rujukan.
7. Kemampuan untuk memberikan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada pasca keguguran, kondisi gawat darurat, dan rujukan.
8. Kemampuan untuk memberikan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada anak-anak pasca keguguran, kondisi gawat darurat, dan rujukan.
9. Kemampuan untuk memberikan asuhan kebidanan yang menyeluruh dan berkualitas pada masa antara, klimakterium, keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan, dan keterampilan dasar kebidanan.

Kompetensi bidan merupakan acuan Bidan dalam melakukan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat Kompetensi Bidan terbentuk dari 7 area kompetensi dalam memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas secara komprehensif, efektif, efisien dan aman berdasarkan evidence based kepada klien. Ruang lingkup pelayanan kebidanan berfokus pada upaya promotif, preventif, pertolongan persalinan, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, pelaksanaan tindakan asuhan sesuai dengan kewenangan serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan yang dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.

Pada poin 4, dari tujuh area kompetensi bidan, dijelaskan bahwa bidan harus memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan asuhan yang berkualitas dan tanggap budaya sesuai ruang lingkup asuhan. Ruang lingkup asuhan ini mencakup asuhan bayi baru lahir (neonates), bayi balita, dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, dan masa klimakterium, pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.

B. Standar dan Tempat Praktik Bidan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan praktik Bidan menjelaskan Bidan dapat menjalankan praktik kebidanan secara mandiri atau difasilitasi pelayanan kesehatan. Praktik kebidanan secara mandiri disebut dengan tempat praktik mandiri bidan dan adapun fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud klinik, puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kewenangan bidan dalam melakukan praktik kebidanan diantara lain pelayanan kesehatan ibu, anak dan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Kewajiban dalam menjalankan praktik kebidanan diharapkan bidan untuk menghormati hak pasien; memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan; merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu; meminta persetujuan untuk tindakan

yang akan dilakukan; menjaga rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; mencatat secara sistematis asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya yang diberikan; dan mematuhi standar profesional. mencatat dan melaporkan praktik kebidanan, termasuk laporan kelahiran dan kematian, pembuatan surat rujukan, dan surat keterangan kelahiran; dan meningkatkan kualitas pelayanan profesinya dengan mengikuti kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. Hak dalam menjalankan praktik kebidanan diharapkan bidan untuk memberikan perlindungan hukum selama pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat dari pasien dan/atau keluarganya; melakukan pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan mereka; dan menerima kompensasi untuk jasa yang diberikan oleh profesinya.

C. Ruang Lingkup Praktik Kebidanan

Ruang lingkup praktik kebidanan terdiri dari beberapa area penting sebagai berikut:

1. Pelayanan Antenatal

Pelayanan antenatal mencakup pemeriksaan rutin ibu hamil, deteksi dini komplikasi kehamilan, edukasi mengenai nutrisi, persiapan persalinan, serta konseling kesehatan. Bidan juga berperan dalam memberikan imunisasi kepada ibu hamil serta melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk memantau kondisi ibu dan bayi. Persalinan Bidan memiliki peran utama dalam membantu proses persalinan normal. Bidan harus memastikan bahwa proses persalinan berlangsung dengan aman dan membantu menangani komplikasi yang mungkin terjadi. Tugas bidan pada tahap ini termasuk memberikan dukungan emosional, memantau kondisi ibu dan bayi, serta melakukan tindakan yang diperlukan apabila terjadi komplikasi.

2. Pasca Persalinan (Postnatal Care)

Setelah persalinan, bidan bertanggung jawab untuk memantau kondisi ibu dan bayi, serta memberikan perawatan yang diperlukan untuk memastikan pemulihan ibu dan bayi. Hal ini termasuk pemberian ASI, pemantauan tanda-tanda vital, serta memberikan edukasi kepada ibu mengenai perawatan bayi dan kesehatan reproduksi.

3. Perawatan Bayi Baru Lahir

Perawatan bayi baru lahir meliputi pengawasan kesehatan bayi, pemberian imunisasi, serta memberikan edukasi kepada orang tua mengenai cara merawat bayi yang baru lahir dengan benar.

D. Peran dan Tanggung Jawab Bidan

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh seseorang didalam masyarakat. Setiap profesi kesehatan memiliki perannya masing-masing didalam masyarakat. Peran bidan berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 2019 adalah memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat secara mandiri maupun difasilitas kesehatan lainnya (puskesmas, RS, Klinik atau tempat pelayanan kesehatan lainnya). Peran bidan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan sebagai wadah pengembangan ilmu dan teknologi guna menyelesaikan permasalahan kesehatan ibu dan anak dimasyarakat. (Rosita, 2024).

Bidan memegang peran kunci dalam memberikan perawatan yang aman dan berkualitas bagi ibu dan bayi. Pada setiap tahap kehidupan, bidan harus mampu mengenali dan menangani setiap kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko. Pengetahuan yang luas tentang tanda-tanda bahaya kehamilan, persalinan, serta komplikasi postnatal adalah kunci utama dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

E. Standar dan Tempat Praktik Bidan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan praktik Bidan menjelaskan Bidan dapat menjalankan praktik kebidanan secara mandiri atau difasilitas pelayanan kesehatan. Praktik kebidanan secara mandiri disebut dengan tempat praktik mandiri bidan dan adapun fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud klinik, puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kewenangan bidan dalam melakukan praktik kebidanan diantara lain pelayanan kesehatan ibu, anak dan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Kewajiban dalam menjalankan praktik kebidanan diharapkan bidan untuk menghormati hak pasien. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan; merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu; meminta persetujuan untuk tindakan yang akan dilakukan; menjaga rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; mencatat secara sistematis asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya yang diberikan; dan mematuhi standar profesional. mencatat dan melaporkan praktik kebidanan, termasuk laporan kelahiran dan kematian, pembuatan surat rujukan, dan surat keterangan kelahiran; dan meningkatkan kualitas pelayanan profesinya dengan mengikuti kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. Hak dalam menjalankan praktik kebidanan diharapkan bidan untuk memberikan perlindungan hukum selama pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; mendapatkan

informasi yang lengkap dan akurat dari pasien dan/atau keluarganya; melakukan pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan mereka; dan menerima kompensasi untuk jasa yang diberikan oleh profesinya.

F. Definisi Paradigma Bidan

Asal kata paradigma dari bahasa Latin (Yunani), paradigma yang berarti model atau pola dan juga disebut sebagai pandangan hidup. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, paradigma disebut dengan kerangka berpikir. Keberhasilan bidan memberikan pelayanan berpegang pada paradigma. Paradigma adalah pedoman atau acuan bagi bidan saat memberikan asuhan kebidanan dan dipengaruhi filosofi asuhan kebidanan. Sedangkan, paradigma kebidanan dapat diartikan sebagai cara pandang bidan dalam memberi pelayanan kepada pasien.

Paradigma Kebidanan terdiri dari beberapa komponen yaitu wanita, lingkungan, perilaku, pelayanan kebidanan, dan keturunan:

1. Wanita adalah makhluk biologis, psikologis, sosial dan kultural dan spiritual yang utuh dan unik serta mempunyai kebutuhan dasar yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangannya. Wanita merupakan orang pertama dan utama dalam keluarga yang berperan sebagai penerus garis keturunan keluarga dan bangsa. Oleh sebab itu, wanita harus sehat baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
2. Lingkungan merupakan tempat di mana individu berada dan berinteraksi dengan individu lain. Lingkungan terbagi menjadi lingkungan fisik, lingkungan psikososial, lingkungan biologis, dan lingkungan budaya. Seorang ibu atau wanita selalu terlibat dalam interaksi baik antara keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat.
3. Perilaku merupakan sebuah hasil dari berbagai pengalaman serta hasil interaksi individu dengan lingkungannya, dapat berupa pengetahuan, sikap, maupun tindakan, serta bersifat holistik atau menyeluruh. Perilaku pada ibu hamil dapat mempengaruhi kehamilannya, perilaku ibu bersalin yang sedang menentukan penolong persalinannya akan mempengaruhi kesejahteraan ibu dan janinnya, demikian pula perilaku ibu pada masa nifas.
4. Pelayanan Kebidanan Pelayanan kebidanan merupakan suatu layanan yang diberikan oleh bidan yang sesuai dengan kewenangan bidan. Pelayanan kebidanan bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak sehingga dapat tercapainya keluarga yang berkualitas, bahagia, dan sejahtera.
5. Kualitas individu sangat ditentukan oleh keturunan, di mana wanita atau ibu yang sehat dapat melahirkan keturunan yang sehat. Kesehatan wanita harus dipersiapkan sejak sebelum perkawinan, sebelum kehamilan (pra-konsepsi), dan

selama kehamilannya, saat proses melahirkan, dan juga saat masa nifas. Suatu kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan proses fisiologi bagi wanita yang harus dipersiapkan dan ditangani dengan akurat dan benar. Di zaman post modern sekarang, terdapat pergeseran paradigma dalam melakukan asuhan kebidanan. Sebelumnya, fokus utama asuhan kebidanan adalah menunggu dan menangani komplikasi, namun saat ini fokus utama asuhan kebidanan adalah mencegah terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan, nifas, maupun pada bayi baru lahir.

Bidan dalam bekerja memberikan pelayanan keprofesiannya berpegang pada paradigma, berupa pandangan terhadap manusia/perempuan, lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan/kebidanan dan keturunan.

1. Perempuan Perempuan sebagaimana halnya manusia adalah makhluk bio-psiko-sosio-kultural yang utuh dan unik, mempunyai kebutuhan dasar yang unik, dan bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangan. Perempuan sebagai penerus generasi, sehingga keberadaan perempuan yang sehat jasmani, rohani, dan sosial sangat diperlukan. Perempuan sebagai sumber daya insani merupakan pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Kualitas manusia sangat ditentukan oleh keberadaan/kondisi perempuan/Ibu dalam keluarga. Para perempuan di masyarakat adalah penggerak dan pelopor peningkatan kesejahteraan keluarga.

2. Lingkungan

Lingkungan merupakan semua yang terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan aktifitasnya, baik lingkungan fisik, psikososial, biologis maupun budaya. Lingkungan psikososial meliputi keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat. Ibu selalu terlibat dalam interaksi keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok paling penting dan kompleks yang telah dibentuk oleh manusia sebagai lingkungan sosial yang terdiri dari individu, keluarga dan komunitas yang mempunyai tujuan dan sistem nilai. Perempuan merupakan bagian dari anggota keluarga dari unit komunitas. Keluarga yang dalam fungsinya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Keluarga dapat menunjang kebutuhan sehari-hari dan memberikan dukungan emosional kepada ibu sepanjang siklus kehidupannya. Keadaan sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan lokasi tempat tinggal keluarga sangat menentukan derajat kesehatan reproduksi perempuan.

3. Perilaku

Perilaku merupakan hasil seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan.

4. Pelayanan Kebidanan

Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan yang telah terdaftar (terdaftar) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan. Pelayanan Kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga, sesuai dengan kewenangan dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan pelayanan kebidanan dapat dibedakan menjadi:

- a. Layanan Primer ialah layanan Bidan yang sepenuhnya menjadi
- b. Tanggung jawab Bidan.
- c. Layanan Kolaborasi adalah layanan yang dilakukan oleh Bidan
- d. sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara
- e. bersamaan atau sebagai salah satu dari sebuah proses kegiatan
- f. pelayanan kesehatan.
- g. Layanan Rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh Bidan
- h. dalam rangka rujukan ke sistem layanan yang lebih tinggi atau
- i. sebaliknya yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam
- j. menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga
- k. layanan yang dilakukan oleh Bidan ke tempat/ fasilitas pelayanan
- l. kesehatan lain secara horizontal maupun vertikal atau
- m. meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu serta bayinya

G. Komponen Kompetensi

1. Area Etik Legal dan Keselamatan Klien

- a. Memiliki perilaku profesional.
- b. Mematuhi aspek etik-legal dalam praktik kebidanan.
- c. Menghargai hak dan privasi perempuan serta keluarganya.
- d. Menjaga keselamatan klien dalam praktik kebidanan.

2. Area Komunikasi Efektif

- a. Berkomunikasi dengan perempuan dan anggota keluarganya.
- b. Berkomunikasi dengan masyarakat.
- c. Berkomunikasi dengan rekan sejawat.
- d. Berkomunikasi dengan profesi lain/tim kesehatan lain.
- e. Berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

3. Area Pengembangan Diri dan Profesionalisme

- a. Bersikap mawas diri.
- b. Melakukan pengembangan diri sebagai bidan profesional.

- c. Menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang praktik kebidanan dalam rangka pencapaian kualitas kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat.

4. Area Landasan Ilmiah Praktik Kebidanan

- a. Bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan asuhan yang berkualitas dan tanggap budaya sesuai ruang lingkup asuhan:
 - 1) Bayi Baru Lahir (Neonatus).
 - 2) Bayi, Balita dan Anak Prasekolah.
 - 3) Remaja.
 - 4) Masa Sebelum Hamil.
 - 5) Masa Kehamilan.
 - 6) Masa Persalinan.
 - 7) Masa Pasca Keguguran.
 - 8) Masa Nifas.
 - 9) Masa Antara.
 - 10) Masa Klimakterium.
 - 11) Pelayanan Keluarga Berencana.
 - 12) Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan.
- b. Bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan penanganan situasi kegawatdaruratan dan sistem rujukan.
- c. Bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk dapat melakukan Keterampilan Dasar Praktik Klinis Kebidanan.

5. Area Keterampilan Klinis Dalam Praktik Kebidanan

- a. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi baru lahir (neonatus), kondisi gawat darurat, dan rujukan.
- b. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi, balita dan anak pra sekolah, kondisi gawat darurat, dan rujukan.
- c. Kemampuan memberikan pelayanan tanggap budaya dalam upaya promosi kesehatan reproduksi pada remaja perempuan.
- d. Kemampuan memberikan pelayanan tanggap budaya dalam upaya promosi kesehatan reproduksi pada masa sebelum hamil.
- e. Memiliki ketrampilan untuk memberikan pelayanan ANC komprehensif untuk memaksimalkan, kesehatan Ibu hamil dan janin serta asuhan kegawatdaruratan dan rujukan.
- f. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada ibu bersalin, kondisi gawat darurat dan rujukan.
- g. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada pasca keguguran, kondisi gawat darurat dan rujukan.

- h. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada ibu nifas, kondisi gawat darurat dan rujukan.
- i. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada masa antara.
- j. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada masa klimakterium.
- k. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada pelayanan Keluarga Berencana.
- l. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.
- m. Kemampuan melaksanakan keterampilan dasar praktik klinis kebidanan

H. Pengertian Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, Lembaga (organisasi), dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.

Kebidanan memiliki Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2019. Undang-Undang 4/2019 tentang Kebidanan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56 dan Penjelasan Atas UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 15 Maret 2019 di Jakarta.

1. Dasar Hukum

- a. UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. UU No.4 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- c. UU 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- d. UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- e. PP No.32 tahun 2006 tentang Tenaga Kesehatan
- f. PP 61 Tahun 2014 ttg Pelayanan Kesehatan Reproduksi
- g. Permenkes 28 tahun 2011 tentang Klinik
- h. Permenkes nomor 1796 tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga
- i. Permenkes 28 Th 2017 tentang izin Penyelenggaraan Praktek Bidan
- j. Permenkes 1464 Tahun 2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
- k. Permenkes nomor 900 tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan
- l. Kepmenkes nomor 836 tahun 2005 tentang Pedoman pengembangan manajemen kinerja perawat dan bidan
- m. Kepmenkes nomor 369 tahun 2007 tentang Asuhan Kebidanan

- n. Kepmenkes nomor 1134 tahun 2010 tentang Keanggotaan, Organisasi Tata Kerja Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

2. Surat Tanda Registrasi (STR) Surat Tanda Registrasi (STR)

- a. Pasal 21: setiap bidan yang menjalankan Praktik Kebidanan memiliki STR
- b. Pasal 22: STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi setelah memenuhi persyaratan
- c. pasal 23: Konsil menerbitkan STR paling lama 30 hari kerja terhitung sejak pengajuan diterima
- d. pasal 25: Bidan yang akan menjalankan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki izin praktik--> SIPB
- e. pasal 26: Bidan palingn banyak mendapatkan 2 SIPB (SIPB ditempat praktik mandiri dan difasilitas pelayanan kesehatan) mandiri dan difasilitas pelayanan kesehatan)
- f. Pasal 27: SIPB tidak berlaku apabila: bidan meninggal dunia, habis masa berlaku, dicabut, atau permintaan sendiri
- g. Pasal 28 bidan harus menjalankan praktik kebidanan di tempat harus menjalankan praktik kebidanan di tempat praktik sesuai praktik sesuai SIPB, SIPB, jika tidak sesuai akan dikenakan sanksi administratif
- h. Pasal 30: Penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendayagunakan bidan yang memiliki STR dan SIPB--> jika tidak mendayagunakan bidan yang memiliki STR dan SIPB--> jika tidak akan kena sanksi administrative akan kena sanksi administrative.
- i. UU no 4 tahun 2019 tentang Kebidanan
- j. Pendidikan Kebidanan
- k. Registrasi dan izin praktik
- l. Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri
- m. Bidan warga negara Asing Bidan warga negara Asing
- n. Praktik Kebidanan
- o. Hak dan kewajiban
- p. Organisasi profesi Bidan
- q. Pendayagunaan Bidan
- r. Pembinaan dan pengawasan dan pengawasan
- s. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Bidan yang telah memiliki
- t. Sertifikat Kompetensi kebidanan yang telah mempunyai kualifikasi tertentu, lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik kebidanan. Surat tanda registrasi berlaku selama 5 tahun.

3. Registrasi bidan

Registrasi bidan oleh pemerintah melalui registrasi yang dilakukan oleh Konsil/Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Hal ini berdasarkan Konsil/Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.36 Tenaga Kesehatan, pasal 44 yang berbunyi "Setiap tenaga kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang tenaga kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil"

4. Legislasi proses pembuatan UU

Atau penyempurnaan perangkat yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi, dan registrasi.

Tujuannya:

- a. Menjamin kualitas pelayanan
- b. memberikan kewenangan
- c. menjamin perlindungan hukum
- d. Meningkatkan profesionalisme

5. Sertifikasi

Yaitu dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui pendidikan formal maupun non formal.

Bentuk sertifikasi: Bentuk sertifikasi:

- a. Ijazah
- b. Sertifikasi LISENSI

Yaitu proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah profesi yang telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri Setiap tenaga kesehatan yang praktik harus yang praktik harus memiliki izin (Undang-Undang Np. 36 Tahun 2014, pasal 46)

6. Lisensi

Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Lisensi adalah pemberian ijin praktik sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan.

Tujuan lisensi adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan kejelasan batas wewenang.
- b. Menetapkan sarana dan prasarana.
- c. Meyakinkan klien.

Aplikasi Lisensi dalam praktik kebidanan adalah dalam bentuk SIPB (Surat Ijin Praktik Bidan). SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Depkes RI kepada tenaga bidan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan yang

ditetapkan. Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB, yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: fotokopi SIB yang masih berlaku, fotokopi ijazah bidan, surat persetujuan atasan, surat keterangan sehat dari bidan, rekomendasi dari organisasi profesi, pas foto. Rekomendasi yang telah diberikan organisasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik serta kesanggupan melakukan praktik bidan.

Bentuk penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan inilah yang diaplikasikan dengan rencana diselenggarakannya Uji Kompetensi bagi bidan yang mengurus SIPB atau lisensi. Meskipun Uji Kompetensi sekarang ini baru pada tahap uji coba di beberapa wilayah, termasuk Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, sehingga memang belum dibakukan.

SIPB berlaku sepanjang SIB belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali. Syarat Lisensi:

- a. fotokopi SIB yang masih berlaku;
- b. surat keterangan sehat;
- c. rekomendasi dari organisasi profesi;
- d. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

I. Latihan

1. Dalam lingkup praktik bidan terdapat tiga point penting adalah?
 - A. Perawatan antenatal
 - B. Kesehatan perempuan
 - C. Keluarga binaan
 - D. Kesehatan remaja
 - E. Pranikah dan prakonsepsi
2. Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh seseorang didalam masyarakat. Undang-undang yang mengatur peran bidan adalah
 - A. UU nmor 369 tahun 2007
 - B. UU No. 4 tahun 2019
 - C. UU No. 44 tahun 2020
 - D. UU No. 19 tahun 2019
 - E. UU No. 28 Tahun 2017
3. Kompetensi bidan adalah acuan bagi bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada kliennya. Berapakah jumlah area pada standar kompetensi bidan di Indonesia?

- A. Tiga
 - B. Empat
 - C. Lima
 - D. Enam
 - E. Tujuh
4. Jenis pelayanan yang diberikan oleh seorang ibu dan anak melalui praktik asuhan kebidanan. Merupakan definisi dari...
- A. Asuhan Kebidanan
 - B. Praktik Kebidanan
 - C. Ruang lingkup Bidan
 - D. Kompetensi Bidan
 - E. Standar Profesi Bidan
5. Kemampuan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan profesi Bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memberikan pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir/neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, pelayanan keluarga berencana, masa klimakterium, kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan, serta keterampilan dasar praktik klinis kebidanan. Merupakan pengertian dari.....
- A. Asuhan Kebidanan
 - B. Praktik Kebidanan
 - C. Ruang lingkup Bidan
 - D. Kompetensi Bidan
 - E. Standar Profesi Bidan
6. Peraturan yang mengatur tentang standar kompetensi kerja bidang kebidanan, adalah sebagai berikut...
- A. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938/ Menkes/ SK/ VIII/ 2007
 - B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
 - C. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017
 - D. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ Menkes/ 320/ 2020
 - E. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ Menkes/ 1261/ 2022
7. Area Komunikasi Efektif dalam kompetensi bidan adalah
- A. Berkomunikasi dengan suami
 - B. berkomunikasi dengan lansia
 - C. berkomunikasi dengan teman sejawat

- D. berkomunikasi dengan teman
 - E. berkomunikasi dengan tim
8. Bidan dalam bekerja memberikan pelayanan keprofesiannya berpegang pada paradigma berupa ...
- A. Perilaku
 - B. etik legal
 - C. Landasan Ilmiah
 - D. keterampilan klinis
 - E. profesionalisme
9. Suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, Lembaga (organisasi), dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi merupakan pengertian dari....
- A. Lisensi
 - B. regulasi
 - C. sertifikat
 - D. legislasi
 - E. registrasi
10. Proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Tujuan lisensi yang tepat adalah ..
- A. Menetapkan sarana dan prasarana.
 - B. Menjamin kualitas pelayanan
 - C. memberikan kewenangan
 - D. menjamin perlindungan hukum
 - E. Meningkatkan profesionalisme
11. Bidan harus menjalankan praktik kebidanan di tempat harus menjalankan praktik kebidanan di tempat praktik sesuai praktik sesuai SIPB, SIPB, jika tidak sesuai akan dikenakan sanksi administratif. Pernyataan tersebut Merupakan pasal
- A. pasal 39
 - B. pasal 32
 - C. pasal 30
 - D. pasal 28
 - E. pasal 29

J. Kunci Jawaban

1. A

2. B
3. E
4. B
5. B
6. D
7. C
8. A
9. A
10. A
11. D

K. Rangkuman Materi

Berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan, asuhan kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai wewenang dan ruang lingkup praktiknya. Dalam melakukan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat, kompetensi bidan merupakan acuan. Bidan memiliki 7 area kompetensi untuk memberikan pelayanan kebidanan yang komprehensif, efektif, efisien, dan aman kepada klien berdasarkan bukti.

L. Glosarium

ANC: Antenatal Care
 INC: Intranatal Care
 PNC: Postnatal Care
 BBL: asuhan Bayi Baru Lahir (BBL),

M. Daftar Pustaka

Anggraini Dina Dewi. (2020), Konsep Kebidanan. Medan : Yayasan Kita Menulis.
 Farelya, G., & Nurrobikha. (2015). Etikolegal dalam Pelayanan Kebidanan. Yogyakarta: Deepublish.
 Herlinda. (2021). Modul Pengantar Asuhan Kebidanan. STIKes Sapta Bengkulu : Bengkulu.
 Kepmenkes RI. (2020). Standar Profesi Bidan : Jakarta.
 Kusumastuti, I., dkk. 2024. Buku Ajar Pengantar Praktik Kebidanan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi.
 Medika.
 Prawirohardjo, S. (2018). Ilmu Kebidanan: Buku Ajar Kebidanan Jilid I. Jakarta: Bina

Pustaka.

Ristica, O. D., & Julianti, W. (2014). Prinsip Etika dan Moralitas dalam Pelayanan Kebidanan. Yogyakarta: Deepublish.

Rosita, E., dkk. 2024. Buku Ajar Konsep Kebidanan. PT Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi.

Rosita, E., dkk. 2024. Buku Ajar Konsep Kebidanan. PT Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi.

Rukiyah, S., & Amalia, I. (2019). Kebidanan: Praktik dan Etika Profesi. Yogyakarta: Nuha

Sartika, D., dkk 2024. Konsep dan Pelayanan Kebidanan (Peran dan Fungsi Kebidanan). Selat Media: Jakarta.

Surya Dewi. 2018. Buku Ajar Kebidanan .Jakarta; Rineka Cipta

Umar, S., dkk. 2023. Buku Ajar Konsep Kebidanan. PT Nas Media Indonesia: Makassar.

BAB 7

ISU PROFESIONAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN, ETIK DALAM KEBIDANAN, DAN KONSEP BERUBAH

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu mengintegrasikan pemahaman tentang isu profesional, prinsip etika dalam kebidanan, dan dinamika perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan yang aman dan efektif.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, serta mengaplikasikan konsep isu profesional, prinsip etika kebidanan, dan strategi adaptasi terhadap perubahan dalam konteks pelayanan kebidanan secara profesional.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan berbagai isu profesional dalam praktik kebidanan terkini.
- Mengidentifikasi prinsip-prinsip etika yang mendasari praktik kebidanan.
- Menguraikan konsep perubahan dalam pelayanan kebidanan dan implikasinya terhadap praktik profesional.

Pendahuluan

Profesi kebidanan terus mengalami perkembangan signifikan seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, serta dinamika sosial dan budaya. Perkembangan ini tidak hanya menuntut bidan untuk memiliki kompetensi klinis, tetapi juga menegaskan pentingnya pemahaman tentang isu-isu profesional, etika dalam praktik kebidanan, dan kesiapan menghadapi perubahan. Pemahaman yang komprehensif terhadap isu profesional, etika, dan konsep perubahan akan mendukung bidan dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, serta sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Uraian Materi

A. Isu Profesional dalam Praktik Kebidanan

Praktik kebidanan modern saat ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan ini dipicu oleh perubahan lingkungan sosial, kemajuan teknologi kesehatan, peningkatan tuntutan kualitas layanan oleh masyarakat, serta dinamika sistem kesehatan yang semakin berkembang. Para bidan sebagai tenaga profesional diharapkan mampu merespons dan mengelola tantangan-tantangan tersebut dengan baik guna memastikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman, efektif, efisien, serta berkualitas tinggi.

Praktik kebidanan saat ini menghadapi sejumlah isu penting yang memerlukan perhatian khusus dari para profesional. Beberapa isu utama di antaranya adalah:

1. Tantangan Kompetensi

Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi medis, serta perubahan kebijakan kesehatan mengharuskan seorang bidan memiliki kompetensi profesional yang selalu diperbarui dan ditingkatkan secara terus-menerus. Kompetensi yang dimaksud bukan hanya keterampilan klinis dasar, melainkan juga kemampuan adaptasi terhadap metode pelayanan terbaru berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice).

Kompetensi profesional dalam kebidanan mencakup penguasaan berbagai teknologi terbaru seperti ultrasonografi, penggunaan rekam medis elektronik (Electronic Health Record/EHR), dan alat-alat penunjang diagnosis yang semakin canggih. Sejalan dengan ini, para bidan juga diharuskan mengikuti pelatihan, seminar, workshop, atau pendidikan formal lanjutan secara rutin guna memperbarui pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional.

Pendidikan berkelanjutan ini juga memastikan bahwa para bidan tidak hanya menguasai teknik klinis yang terbaru tetapi juga mampu menerapkan pendekatan yang berpusat pada pasien (patient-centered care). Pendekatan ini mengutamakan pemberdayaan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan kesehatan serta memahami aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual pasien dalam memberikan pelayanan.

2. Perubahan Peran Bidan

Dalam konteks sistem pelayanan kesehatan saat ini, peran seorang bidan mengalami perluasan yang signifikan dibandingkan era sebelumnya. Dahulu, peran bidan utamanya terfokus pada pelayanan kebidanan dasar seperti perawatan antenatal, persalinan normal, dan pelayanan postnatal dasar. Kini,

peran bidan semakin diperluas dan diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan primer yang lebih kompleks dan bersifat interprofesional.

Perubahan ini mengharuskan bidan memiliki keahlian tambahan dalam pengelolaan kasus yang lebih rumit seperti kehamilan berisiko, penyulit kehamilan, gangguan kesehatan reproduksi, dan berbagai kondisi medis ibu dan anak yang memerlukan penanganan lanjutan atau kolaborasi dengan spesialis lain seperti dokter obstetri-ginekologi, dokter anak, ahli gizi, psikolog, maupun tenaga kesehatan masyarakat.

Untuk memenuhi peran baru ini, bidan dituntut tidak hanya memiliki kompetensi klinis yang tinggi tetapi juga keterampilan komunikasi yang baik serta kemampuan kerja sama antarprofesi. Kerja sama interprofesional penting untuk memastikan bahwa setiap pasien menerima pelayanan yang terintegrasi, efektif, aman, serta berkualitas tinggi. Peran kolaboratif ini termasuk merujuk pasien tepat waktu, berbagi informasi secara efektif dengan tim multidisiplin, serta mampu berkontribusi dalam diskusi klinis secara profesional.

3. Tuntutan Akuntabilitas

Dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi, masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam praktik kebidanan. Akuntabilitas ini mengacu pada kewajiban profesional bidan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil dalam pelayanan kebidanan kepada pasien, institusi kesehatan, organisasi profesi, maupun masyarakat secara luas.

Tuntutan akuntabilitas ini mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

- a. Akuntabilitas Klinis, yang berarti setiap tindakan klinis yang dilakukan oleh bidan harus sesuai standar praktik yang berlaku, berbasis bukti ilmiah terkini, dan memenuhi prinsip keselamatan pasien.
- b. Akuntabilitas Hukum, mengharuskan setiap praktik kebidanan dilakukan dalam batasan hukum dan regulasi profesi yang berlaku, serta terdokumentasi secara lengkap dan akurat untuk mencegah terjadinya tuntutan hukum atau sengketa medis.
- c. Akuntabilitas Etik, yakni menjalankan profesi dengan patuh pada kode etik profesi bidan, menghargai hak-hak pasien, menjaga kerahasiaan pasien, serta bertindak profesional dalam segala situasi.

Dokumentasi praktik kebidanan menjadi elemen yang sangat krusial dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas. Dokumentasi yang lengkap dan akurat bukan hanya menjadi alat komunikasi antarprofesi dan tenaga kesehatan lain tetapi juga sebagai dasar pertanggungjawaban apabila terjadi permasalahan hukum atau

audit klinis. Dalam konteks ini, bidan harus terampil dalam pencatatan klinis, baik melalui sistem dokumentasi manual maupun digital yang terstandarisasi.

B. Etik dalam Kebidanan

Etika dalam kebidanan merupakan sebuah kerangka moral dan nilai-nilai dasar yang menjadi panduan utama bagi bidan dalam menjalankan praktiknya sehari-hari. Sebagai seorang tenaga kesehatan yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi, seorang bidan harus memiliki landasan etika yang kuat agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Etika ini menjadi pegangan bagi para bidan dalam setiap pengambilan keputusan klinis dan non-klinis, serta dalam menjaga hubungan terapeutik yang baik dan saling percaya dengan pasien dan keluarganya.

Etika profesional kebidanan merupakan landasan moral dalam memberikan pelayanan kepada klien. Prinsip etika kebidanan mencakup:

1. Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi dalam kebidanan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak setiap klien (ibu hamil, ibu bersalin, maupun ibu nifas) untuk membuat keputusan sendiri terkait kesehatan dan perawatan dirinya berdasarkan informasi yang cukup, jelas, dan tepat. Dalam konteks ini, seorang bidan bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi kesehatan klien, berbagai pilihan tindakan medis atau kebidanan yang tersedia, beserta konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari masing-masing tindakan tersebut.

Implementasi prinsip otonomi juga berarti bahwa bidan harus mendukung keputusan klien sekalipun keputusan tersebut berbeda dari rekomendasi profesional, selama klien telah memperoleh semua informasi yang dibutuhkan dan mampu secara mental dan emosional untuk mengambil keputusan tersebut. Dengan kata lain, peran bidan adalah memberikan dukungan penuh kepada klien, menghargai pilihan individu, dan tidak melakukan intervensi tanpa persetujuan eksplisit dari klien.

Menghormati hak klien dalam mengambil keputusan tentang perawatan dirinya sendiri berdasarkan informasi yang cukup dan jelas.

2. Benefisensi

Prinsip benefisensi berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh bidan harus bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi klien dan bayi yang dilahirkan. Dalam kebidanan, prinsip ini menegaskan bahwa kesejahteraan dan keselamatan ibu dan bayi harus selalu menjadi prioritas utama.

Dalam praktiknya, prinsip ini diwujudkan melalui penerapan praktik kebidanan yang berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice), memastikan bahwa setiap tindakan medis atau kebidanan yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan terbukti efektif serta aman. Selain itu, bidan juga diharapkan selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya secara terus-menerus agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai dengan standar terbaik yang ada. Prinsip benefisensi juga melibatkan aspek empati dan kepedulian, di mana bidan tidak hanya berorientasi pada aspek klinis tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial klien, demi terciptanya rasa aman dan nyaman selama proses asuhan kebidanan berlangsung.

3. Non-malefisensi

Prinsip non-malefisensi mengandung makna bahwa setiap bidan wajib menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan klien secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini sejalan dengan sumpah profesi kesehatan yang secara tegas menyatakan bahwa seorang tenaga kesehatan wajib untuk tidak menyakiti atau merugikan pasiennya.

Implementasi prinsip ini mencakup keharusan bagi bidan untuk berhati-hati dalam setiap tindakan, baik dalam prosedur invasif maupun non-invasif, serta selalu mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku agar risiko bahaya terhadap klien bisa diminimalisir. Bidan juga harus secara aktif melakukan tindakan preventif untuk menghindari komplikasi atau kejadian tidak diinginkan selama proses asuhan kebidanan, seperti infeksi, cedera akibat intervensi yang tidak tepat, atau kelalaian profesional. Dalam konteks yang lebih luas, prinsip non-malefisensi juga berarti bahwa bidan wajib melakukan evaluasi diri secara terus menerus terhadap praktik profesionalnya agar mampu mencegah kesalahan atau kecelakaan yang bisa berdampak negatif terhadap keselamatan klien.

4. Keadilan

Prinsip keadilan dalam kebidanan berarti bahwa seorang bidan harus mampu memberikan pelayanan secara adil dan setara kepada semua klien tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama, ras, atau faktor-faktor diskriminatif lainnya. Dengan kata lain, setiap klien memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas tinggi, dan bidan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada bentuk diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara dalam pemberian layanan kebidanan.

Prinsip keadilan juga berarti bahwa seorang bidan harus mampu mengelola sumber daya secara bijaksana, sehingga semua klien dapat memperoleh pelayanan yang efektif, tepat waktu, serta sesuai kebutuhan mereka. Dalam situasi tertentu, bidan juga perlu mengadvokasi klien yang menghadapi kendala akses

terhadap layanan kesehatan, dengan tujuan memastikan bahwa keadilan dalam pelayanan kesehatan dapat diwujudkan secara nyata. Dalam praktiknya, bidan harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, menghormati hak asasi manusia, serta memberikan asuhan secara objektif dan bebas dari prasangka.

C. Konsep Berubah dalam Praktik Kebidanan

Dalam bidang kebidanan, perubahan adalah sebuah realitas yang tidak bisa dihindari. Perubahan ini didorong oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi kesehatan, kemajuan penelitian ilmiah, perubahan kebijakan kesehatan, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap kualitas layanan kebidanan. Oleh karena itu, seorang bidan dituntut memiliki kemampuan adaptasi, kesiapan menerima perubahan, serta keterbukaan terhadap inovasi agar tetap relevan dengan tuntutan zaman.

Adanya perubahan yang terus-menerus dalam dunia kebidanan memerlukan kesiapan mental, intelektual, dan keterampilan yang terus diperbaharui dari para bidan. Mereka harus siap untuk terus belajar dan berkembang guna menjamin pemberian asuhan kebidanan yang terbaik bagi ibu dan bayi. Beberapa area utama perubahan dalam praktik kebidanan adalah:

1. Perkembangan Teknologi

Salah satu aspek perubahan yang sangat signifikan dalam praktik kebidanan modern adalah perkembangan teknologi kesehatan. Saat ini, kebidanan tidak bisa dipisahkan dari integrasi teknologi informasi dalam berbagai aspek pelayanan. Teknologi yang dimaksud meliputi implementasi sistem pencatatan medis elektronik atau Electronic Health Record (EHR), telemedicine, dan berbagai aplikasi digital yang digunakan untuk mendukung asuhan kebidanan.

Electronic Health Record (EHR) memungkinkan pencatatan data medis pasien secara elektronik, yang dapat diakses dengan mudah oleh tenaga kesehatan. Hal ini memberikan kemudahan bagi bidan untuk melakukan dokumentasi klinis yang akurat, cepat, efisien, dan terstruktur. Dengan adanya EHR, proses dokumentasi praktik kebidanan menjadi lebih mudah diaudit, meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, serta memudahkan komunikasi antar-profesional dalam tim kesehatan. Selain itu, EHR juga mendukung pelaporan data klinis untuk keperluan riset, evaluasi kualitas layanan, dan pembuatan kebijakan.

Telemedicine adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan layanan kesehatan kebidanan diberikan dari jarak jauh melalui video conference atau konsultasi daring. Dalam konteks kebidanan, telemedicine membantu mengatasi kendala geografis, terutama bagi ibu hamil yang tinggal di daerah terpencil atau

sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan. Bidan dapat melakukan pemantauan kehamilan, memberikan edukasi kesehatan, konseling, bahkan penanganan kondisi darurat secara virtual. Penggunaan telemedicine semakin meningkat, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang menuntut layanan kesehatan minim kontak fisik.

Selain itu, berbagai aplikasi digital seperti aplikasi kehamilan, aplikasi pelacakan kesehatan ibu dan bayi, aplikasi edukasi kesehatan reproduksi, dan aplikasi manajemen praktik kebidanan semakin banyak digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital kini menjadi bagian integral dalam pelayanan kebidanan, yang tidak hanya memudahkan pekerjaan bidan tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan klien.

2. Paradigma Pelayanan Berbasis Bukti

Perubahan lain yang sangat penting dalam praktik kebidanan adalah pergeseran paradigma menuju pelayanan kesehatan yang berbasis bukti (Evidence-Based Practice). Konsep ini menekankan bahwa setiap keputusan klinis dalam praktik kebidanan harus didasarkan pada hasil penelitian ilmiah yang valid, akurat, dan terkini. Dengan demikian, tindakan atau intervensi yang dilakukan oleh bidan tidak semata-mata mengandalkan kebiasaan lama atau pengalaman pribadi saja, melainkan berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang teruji.

Paradigma ini mengharuskan seorang bidan memiliki kemampuan literasi ilmiah yang baik, yaitu kemampuan membaca, memahami, dan mengevaluasi hasil penelitian terkini untuk kemudian diterapkan dalam praktik klinisnya. Implementasi Evidence-Based Practice membantu para bidan untuk memberikan asuhan yang lebih efektif, efisien, aman, serta sesuai dengan perkembangan terbaru dalam ilmu kebidanan.

Dengan paradigma ini, bidan juga dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan penelitian, baik sebagai pengguna hasil penelitian maupun sebagai kontributor dalam riset kebidanan. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan profesional yang terus berkembang, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Adaptasi terhadap Kebijakan Baru

Perubahan kebijakan kesehatan nasional dan global seringkali memiliki dampak langsung terhadap praktik kebidanan. Perubahan tersebut bisa berupa pembaruan regulasi praktik kebidanan, pedoman klinis terbaru, kebijakan akreditasi fasilitas kesehatan, hingga program nasional yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak.

Seorang bidan harus memiliki kesiapan dan kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai kebijakan baru yang muncul. Kemampuan

adaptasi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tetap relevan, efektif, serta selaras dengan kebijakan terkini yang berlaku. Ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru bisa berdampak negatif, baik dari aspek kualitas layanan maupun kepatuhan hukum.

Adaptasi terhadap kebijakan baru juga berarti bidan harus proaktif dalam mengikuti informasi terbaru mengenai perubahan-perubahan tersebut melalui media resmi seperti pelatihan, lokakarya, seminar, sosialisasi regulasi, atau pertemuan profesional yang diselenggarakan oleh lembaga kesehatan atau organisasi profesi kebidanan. Dengan cara ini, bidan akan selalu siap dalam menyesuaikan pelayanan kebidanan sesuai dengan tuntutan kebijakan terbaru dan memastikan bahwa pelayanan tetap berada dalam koridor hukum dan standar profesi yang berlaku.

D. Latihan Soal

Soal 1: Tantangan Kompetensi Profesional

Seorang bidan, Susi, yang bertugas di klinik desa menghadapi kesulitan dalam menggunakan alat ultrasonografi (USG) terbaru yang disediakan oleh dinas kesehatan. Klinik tempatnya bekerja meminta semua bidan mengikuti pelatihan untuk menguasai alat tersebut agar mampu memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan lebih baik. Tindakan profesional apa yang harus dilakukan oleh Susi?

- A. Menolak menggunakan alat tersebut karena merasa tidak terbiasa.
- B. Mengikuti pelatihan secara aktif agar kompetensi meningkat.
- C. Meminta bidan senior untuk selalu mendampingi tanpa perlu pelatihan khusus.
- D. Menggunakan alat USG dengan pengetahuan seadanya secara otodidak.
- E. Menyerahkan pemeriksaan USG kepada tenaga kesehatan lain saja.

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Bidan wajib meningkatkan kompetensi secara profesional dan mengikuti pelatihan yang disediakan agar mampu memberikan pelayanan berdasarkan perkembangan teknologi terbaru secara evidence-based practice.

Soal 2: Perubahan Peran Bidan

Seorang ibu hamil, usia 33 tahun, G3P2A0, datang ke praktik mandiri bidan dengan riwayat hipertensi kronis dan hasil pemeriksaan tekanan darah 160/100 mmHg. Bidan memahami bahwa kondisi ini memerlukan intervensi kolaboratif. Apa tindakan profesional bidan yang paling tepat dalam situasi ini?

- A. Menangani sendiri tanpa konsultasi karena merasa mampu.
- B. Memberikan obat antihipertensi langsung di tempat.

- C. Melakukan konseling tanpa merujuk ke tenaga medis lain.
- D. Merujuk pasien ke dokter spesialis untuk penanganan lebih lanjut.
- E. Menyarankan ibu untuk istirahat saja di rumah tanpa pengobatan.

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Kasus hipertensi kronis pada kehamilannya adalah kondisi berisiko tinggi yang memerlukan kolaborasi interprofesional. Bidan harus segera merujuk ke dokter spesialis agar ibu mendapatkan penanganan yang tepat, aman, dan sesuai kompetensi profesionalnya.

Soal 3: Tuntutan Akuntabilitas dalam Praktik Kebidanan

Seorang bidan baru saja menyelesaikan pemeriksaan antenatal lengkap dan menemukan hasil tekanan darah ibu hamil adalah 180/110 mmHg. Setelah tindakan dilakukan, bidan tidak mencatat hasil pemeriksaan tersebut secara lengkap di dalam catatan rekam medis. Akibatnya, pada audit klinis muncul ketidakjelasan tindakan yang telah dilakukan. Apa prinsip akuntabilitas yang dilanggar oleh bidan dalam kasus ini?

- A. Akuntabilitas sosial
- B. Akuntabilitas ekonomi
- C. Akuntabilitas klinis
- D. Akuntabilitas administratif
- E. Akuntabilitas moral pribadi

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Ketidaklengkapan dokumentasi klinis melanggar akuntabilitas klinis, di mana setiap tindakan harus dicatat secara detail, transparan, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Soal 4: Etik – Prinsip Otonomi

Seorang ibu bersalin menolak tindakan episiotomi yang direkomendasikan oleh bidan karena takut rasa sakit dan trauma. Bidan telah menjelaskan manfaat dan risikonya secara jelas dan rinci. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh bidan?

- A. Tetap melakukan episiotomi tanpa persetujuan pasien
- B. Menghormati keputusan pasien sambil tetap melakukan observasi ketat
- C. Mengabaikan kekhawatiran pasien demi keselamatan bayi
- D. Membujuk keluarga agar membujuk pasien menerima tindakan
- E. Menghentikan pendampingan persalinan karena pasien tidak kooperatif

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Prinsip otonomi menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan pasien, selama telah mendapatkan informasi yang cukup. Bidan harus menghormati keputusan pasien dan tetap memberikan pemantauan yang baik untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi.

Soal 5: Konsep Berubah dalam Praktik Kebidanan – Penggunaan Teknologi (Telemedicine)

Seorang bidan bertugas di wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh dokter spesialis. Ia menemukan ibu hamil dengan keluhan kontraksi prematur. Bidan kemudian memutuskan untuk berkonsultasi jarak jauh melalui telemedicine dengan dokter spesialis kandungan di rumah sakit rujukan. Tindakan bidan tersebut mencerminkan konsep perubahan praktik kebidanan dalam bentuk apa?

- A. Adaptasi terhadap perubahan kebijakan
- B. Implementasi paradigma pelayanan berbasis bukti
- C. Penggunaan teknologi telemedicine dalam praktik kebidanan
- D. Mengabaikan peran kolaborasi interprofesional
- E. Memprioritaskan kenyamanan pribadi bidan

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Pemanfaatan telemedicine mencerminkan adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi yang semakin penting dalam praktik kebidanan modern, guna memberikan pelayanan terbaik dan efektif bagi pasien di daerah terpencil atau sulit diakses.

E. Rangkuman Materi

Praktik kebidanan modern saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks yang membutuhkan kesiapan tinggi dari para bidan sebagai tenaga profesional. Tantangan tersebut mencakup pengembangan kompetensi profesional yang berkelanjutan untuk mengikuti pesatnya perkembangan teknologi kesehatan, perubahan kebijakan, serta kebutuhan masyarakat yang terus meningkat akan pelayanan berkualitas tinggi. Dalam menghadapi tantangan ini, para bidan harus mampu meningkatkan kompetensi klinis, mengadopsi teknologi terbaru seperti penggunaan rekam medis elektronik (EHR) dan telemedicine, serta senantiasa menerapkan pendekatan pelayanan berbasis bukti (evidence-based practice).

Peran bidan pun mengalami perubahan signifikan dari fokus pelayanan dasar menjadi lebih luas, kompleks, dan terintegrasi dengan layanan primer. Hal ini

menuntut keterampilan tambahan seperti kemampuan manajemen kasus kompleks, kolaborasi interprofesional, serta komunikasi efektif dengan berbagai profesi kesehatan lain untuk memastikan pelayanan kesehatan yang holistik dan aman bagi ibu dan bayi.

Selain itu, tuntutan terhadap akuntabilitas profesional menjadi semakin tinggi seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam pelayanan kesehatan. Para bidan dituntut untuk selalu mempertanggungjawabkan setiap tindakan secara klinis, hukum, dan etik dengan dokumentasi yang lengkap, jelas, serta akurat untuk menjamin transparansi dan keselamatan pasien.

Secara paralel, prinsip-prinsip etik seperti otonomi pasien, benefisensi, non-malefisensi, dan keadilan harus selalu menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan asuhan kebidanan sehari-hari. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pelayanan kebidanan tidak hanya secara klinis tepat, tetapi juga secara moral bertanggung jawab dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Akhirnya, dalam lingkungan pelayanan kesehatan yang terus berubah, bidan perlu memiliki kesiapan mental, intelektual, dan keterampilan adaptif untuk selalu merespons perubahan secara positif. Bidan harus aktif mengikuti perkembangan teknologi, literatur ilmiah, dan kebijakan baru, serta menerapkannya secara efektif dalam praktik sehari-hari. Dengan sikap yang terbuka terhadap perubahan, para bidan dapat terus memberikan pelayanan yang optimal, aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era modern ini.

F. Glosarium

Benefisensi

Prinsip etika dalam kebidanan yang mengharuskan bidan bertindak untuk memberikan manfaat maksimal bagi ibu dan bayi, dengan menempatkan keselamatan dan kesejahteraan mereka sebagai prioritas utama.

Bidan

Tenaga kesehatan profesional yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Electronic Health Record (EHR)

Sistem pencatatan medis elektronik yang memungkinkan penyimpanan, akses, serta pertukaran data pasien secara cepat, akurat, efisien, dan terstruktur untuk mendukung praktik kebidanan modern.

Evidence-Based Practice (EBP)

Pendekatan dalam praktik kebidanan yang mendasarkan setiap keputusan klinis pada bukti ilmiah terbaru, valid, dan teruji, sehingga asuhan yang diberikan efektif, aman, dan optimal bagi pasien.

Keadilan (Justice)

Prinsip etika yang mengharuskan bidan memberikan pelayanan kebidanan secara adil, merata, dan tanpa diskriminasi kepada semua pasien, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, atau ras.

Kompetensi Profesional

Kemampuan bidan yang mencakup keterampilan klinis, pengetahuan ilmiah terkini, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi, metode pelayanan baru, dan kebijakan kesehatan terbaru.

Kolaborasi Interprofesional

Kerja sama yang efektif antara bidan dengan berbagai profesi kesehatan lainnya, seperti dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, dan tenaga kesehatan masyarakat, dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi, komprehensif, dan optimal kepada pasien.

Non-malefisensi

Prinsip etika kebidanan yang mengharuskan bidan untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan pasien secara sengaja maupun tidak sengaja, serta berupaya aktif mencegah terjadinya komplikasi atau kejadian tidak diinginkan selama pemberian asuhan.

Otonomi

Prinsip etika yang menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan kesehatan dirinya secara bebas, mandiri, serta berdasarkan informasi yang lengkap, jelas, dan akurat.

Paradigma Pelayanan Berbasis Bukti

Konsep pelayanan kebidanan yang mengutamakan keputusan klinis berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang valid dan terkini, sehingga menghasilkan layanan yang efektif, aman, dan terstandar.

Patient-Centered Care

Pendekatan pelayanan kebidanan yang menempatkan pasien sebagai pusat perhatian dengan memberdayakan pasien serta keluarganya dalam pengambilan keputusan kesehatan, serta memperhatikan aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual pasien.

Pelayanan Primer

Pelayanan kesehatan dasar yang menjadi garda terdepan dalam sistem kesehatan, mencakup promotif, preventif, kuratif dasar, dan rehabilitatif, yang dalam praktik kebidanan modern mencakup peran bidan yang semakin luas dan kompleks.

Telemedicine

Penggunaan teknologi komunikasi digital yang memungkinkan bidan memberikan konsultasi, edukasi, serta pemantauan kondisi pasien secara virtual atau dari jarak jauh, terutama berguna di daerah terpencil atau situasi khusus seperti pandemi.

Teknologi Informasi dalam Kebidanan

Penggunaan berbagai aplikasi digital, telemedicine, dan pencatatan medis elektronik (EHR) dalam mendukung pelayanan kebidanan yang lebih cepat, akurat, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

G. Daftar Pustaka

- Alma Ata University. (2019). Prinsip etik dalam keperawatan. Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. <https://fikes.almaata.ac.id/prinsip-etik-dalam-keperawatan/>
- Kemendes RI. (2025). Tantangan di era digitalisasi angkatan 1. LMS Kemdes. <https://lms.kemdes.go.id/courses/1f6b2213-18b8-4e33-9caa-27308207a511>
- Makalah Ibu Ermi 1. (2024). Perkembangan sistem informasi dan teknologi dalam praktik kebidanan. Scribd. <https://id.scribd.com/document/717365312/Makalah-Ibu-Ermi-1>
- Mega Nopyanti II. (2021). Tanggung jawab dan akuntabilitas dalam asuhan kebidanan BU INA. Scribd. <https://id.scribd.com/presentation/467827728/Tanggung-jawab-dan-Akuntabilitas-dalam-Asuhan-Kebidanan-BU-INA>
- Ningsih, R., & Amra, R. N. (2023). Persepsi bidan tentang penerapan asuhan kebidanan berbasis evidence-based practice. *Majalah Ilmiah Methoda*, 13(3), 365–369.
- Nurhidayah, S., et al. (2020). Kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kebidanan. *Jurnal Maternitas Kebidanan*, 8(1), 45–50.
- Polkesraya. (2021). Evidence-based midwifery. <https://repo.polkesraya.ac.id/1866/1/MODUL%20EBM%20TEORI.pdf>
- Putri, W. (2022). Akuntabilitas pelayanan kebidanan. Scribd. <https://id.scribd.com/document/616272529/Akuntabilitas-pelayanan-kebidanan>
- STIKes Sapta Bakti. (2020). Buku ajar etika dalam praktik kebidanan. <https://repository.stikessaptabakti.ac.id/375/1/13.%20Modul%20Ajar%20-%20Etika%20dalam%20praktik%20kebidanan.pdf>

STIKes Yogyakarta. (2020). Konsep praktik kebidanan. <https://repository.stikes-yogyakarta.ac.id/406/13/BUKU%20ISBN%20KONSEP%20PRAKTIK%20KEBIDANAN.pdf>

PROFIL PENULIS



Yeti Yuwansyah., SST, M.Kes., M.Keb Lahir di Sumedang, 06 Agustus 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Bidan pendidik pada Program Studi DIV Bidan Pendidik Poltekkes Kemenkes tasikmalaya tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Respati Indonesia Jakarta Prodi Kesehatan Masyarakat dan lulus tahun pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan sebagai dosen di Universitas YPIB Majalengka Fakultas Ilmu Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Reviwer. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yetiyuwansyah@gmail.com
Motto: "Bersyukur dan Berbuat baik".



Bdn. Intan Azkia Paramitha, S.Tr.Keb., M.Keb., lahir di Padang Hangat tanggal 09 Mei 1995. Penulis berasal dari Provinsi Bengkulu, dan beralamat di Lenek Pasiraman, Lombok Timur kemudian saat ini berdomisili di Pekalongan Jawa Tengah. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Telah menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di Stikes Tri Mandiri Sakti Bengkulu, lanjut DIV Kebidanan di Universitas Indonesia Maju Jakarta kemudian melanjutkan S2 Ilmu Kebidanan dan Profesi Bidan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Penulis menekuni bidang menulis, dengan menerbitkan artikel dibidang kesehatan khususnya kebidanan, kemudian juga pernah menulis book chapter yang berjudul Aktivitas Fisik Penunjang Kebugaran pada Wanita, Cegah Stunting melalui pola makan, pola asuh dan sanitasi. Penulis banyak meneliti tentang balita, terutama gizi bagi balita stunting. Penulis pernah meng-Haki kan buku Menu harian berbahan lokal bagi balita stunting, serta penelitian mengenai PMT bagi balita stunting yang menggunakan bahan-bahan lokal. Adapun email penulis intanazkia09@gmail.com
Motto: "Doakan, Ikhtiarkan, dan Ikhlasikan. Allah perencana Terbaik".

PROFIL PENULIS



Katarina Iit, SST., M.Kes Lahir di Sei.Dangin, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Pada 27 Febuarri 2087. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma IV pada Program Studi Bidan Pendidik, di Universitas Respati Indonesia tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat pada Universitas Respati Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015. Saat ini

penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak sebagai dosen Diploma III Kebidanan dan mengampu mata kuliah: Pengantar Asuhan Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, Kespro & KB, Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui, Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: katarinaiit17@gmail.com



Diyanah Kumalasary

Lahir di Brebes, pada tanggal 20 Juni 1986. Bertempat tinggal di Taman Kota Ciperna Cluster Akasia Blok S2 No.4 Talun Cirebon. Penulis menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2007, DIV Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2010, dan S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia tahun 2014.

Tahun 2007-2008 penulis bekerja sebagai Bidan Pelaksana di TPMB, kemudian pada Tahun 2010-2014 menjadi Dosen di Akademi Kebidanan Al-Fathonah Jakarta, dan sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang menjadi Dosen di STIKes Muhammadiyah Cirebon yang saat ini berubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon (UMMADA).

Karya yang sudah dihasilkan berupa buku diantaranya yaitu Buku Metode Penelitian Kebidanan Edisi I & II, Buku Chapter Promosi Gema 3M, Buku Saku Promosi Gema 3M, Buku Sukses Ukom DIII Bidan 2023, Buku Teknologi Tepat Guna dalam Pelayanan Kebidanan, dan beberapa video pembelajaran dan edukasi, serta Artikel yang dipublish dalam jurnal Nasional Terakreditasi.

PROFIL PENULIS



Heni Setyowati.,S.SiT.,M.Kes Lahir di Tenganan, Kabupaten Semarang, 17 Maret 1980 Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang AKBID Depkes Semarang lulus D4 Bidan Pendidik tahun 2004 di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran Semarang, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro dan lulus tahun pada tahun 2013. Saat ini sedang menempuh pada jenjang doktoral UNNES. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 di RSIA Anugerah Semarang, dan tahun 2004-sekarang bekerja

sebagai dosen di Universitas Ngudi Waluyo diawali dari kariernya menjadi dosen, menjabat sebagai Pembantu Direktur bidang keuangan, Menjadi Dekan Fakultas Kesehatan tahun 2016-2021, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngudi Waluyo. Dalam bidang pendidikan penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Masa Nifas, Kegawatdaruratan Maternal Neonatal, Konsep Terapi Komplementer, Terapi Komplementer. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, workshop dll. Penulis juga memiliki sertifikat kompetensi sebagai asesor kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP. Penulis juga memiliki Certification International of Internal Quality Audit (CIIQA) yang dikeluarkan oleh LSP Quantum HRM International. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: heni.setyo80@gmail.com

Motto: "Bersyukur adalah pintu menuju kedamaian".



Megawati, S.ST., MKM, Lahir di: Pagarawan, 24 Januari 1991

Riwayat Pendidikan:

Penulis menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Ummi Khasanah Yogyakarta (2011),

D4 Kebidanan di Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta (2012)

S2 Kesehatan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (2018)

Memulai kerja di Srikes Citra Delima Bangka Belitung tahun 2019 yang mana sekarang sudah berubah nama menjadi Institut Citra Internasional sampai dengan sekarang ini.

Penulis aktif dalam melakukan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, jurnal ilmiah, penulisan buku.

Penulis dapat dihubungi melalui E-mail: megawati112411@gmail.com

PROFIL PENULIS



Bdn. Afritayeni, S.ST., M.Kes. adalah seorang akademisi dan praktisi kebidanan yang saat ini menjabat sebagai **Wakil Rektor Bidang Akademik di Institut Kesehatan Helvetia Pekanbaru**. Beliau merupakan lulusan **Program Magister Kesehatan Masyarakat di STIKes Helvetia Medan**, yang diselesaikan pada tahun 2015. Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, beliau telah mengabdikan diri di dunia pendidikan, khususnya dalam bidang kebidanan.

Dengan latar belakang yang kuat dalam asuhan kebidanan serta pengalaman mengajar dan memimpin di institusi pendidikan tinggi, Afritayeni memiliki komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan kebidanan di Indonesia. Buku *Pengantar Praktik Kebidanan* ini ditulis sebagai panduan dasar yang disusun secara holistik untuk membantu mahasiswa kebidanan memahami konsep dan ruang lingkup praktik kebidanan secara komprehensif.

Melalui buku ini, beliau berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam membentuk calon bidan yang tidak hanya kompeten dalam aspek teori dan praktik, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas.

Sinopsis

Buku Ajar Pengantar Praktik Kebidanan merupakan panduan komprehensif yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswa kebidanan dan praktisi kesehatan tentang berbagai aspek penting dalam kebidanan. Buku ini diawali dengan definisi dasar kebidanan, sejarah perkembangan profesi bidan, serta peran bidan dalam konteks nasional dan global, memberikan landasan kuat bagi pembaca untuk memahami urgensi dan cakupan profesi ini.

Lebih lanjut, buku ini secara rinci membahas tren terkini serta isu kontemporer yang relevan dengan praktik kebidanan, seperti keselamatan pasien, kebutuhan akan pengembangan profesional berkelanjutan, pentingnya aspek etika dan legal, serta pentingnya advokasi dan kolaborasi multidisipliner. Diskusi mengenai pendekatan Social Model dan Medical Model diulas secara mendalam, menekankan pentingnya memahami berbagai perspektif dalam memberikan pelayanan kebidanan yang efektif dan holistik.

Selain itu, buku ini juga menjelaskan mengenai pentingnya membangun kemitraan dalam perawatan kesehatan perempuan, meliputi konsep primary care, women-centered care, empowering, dan trust. Pembaca juga akan memahami ruang lingkup praktik kebidanan, paradigma kebidanan, serta regulasi yang mengatur sertifikasi dan lisensi bidan di Indonesia. Bab penutup menghadirkan diskusi mengenai isu profesional, etika dalam kebidanan, dan dinamika konsep yang terus berkembang, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas praktik profesional dalam kebidanan.

Buku Ajar Pengantar Praktik Kebidanan merupakan panduan komprehensif yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswa kebidanan dan praktisi kesehatan tentang berbagai aspek penting dalam kebidanan. Buku ini diawali dengan definisi dasar kebidanan, sejarah perkembangan profesi bidan, serta peran bidan dalam konteks nasional dan global, memberikan landasan kuat bagi pembaca untuk memahami urgensi dan cakupan profesi ini. Lebih lanjut, buku ini secara rinci membahas tren terkini serta isu kontemporer yang relevan dengan praktik kebidanan, seperti keselamatan pasien, kebutuhan akan pengembangan profesional berkelanjutan, pentingnya aspek etika dan legal, serta pentingnya advokasi dan kolaborasi multidisipliner. Diskusi mengenai pendekatan Social Model dan Medical Model diulas secara mendalam, menekankan pentingnya memahami berbagai perspektif dalam memberikan pelayanan kebidanan yang efektif dan holistik.

Selain itu, buku ini juga menjelaskan mengenai pentingnya membangun kemitraan dalam perawatan kesehatan perempuan, meliputi konsep primary care, women-centered care, empowering, dan trust. Pembaca juga akan memahami ruang lingkup praktik kebidanan, paradigma kebidanan, serta regulasi yang mengatur sertifikasi dan lisensi bidan di Indonesia. Bab penutup menghadirkan diskusi mengenai isu profesional, etika dalam kebidanan, dan dinamika konsep yang terus berkembang, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas praktik profesional dalam kebidanan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

